

پچاؤ (Prophylaxis): بچے کی پیدائش کے فوراً بعد آنکھوں کو کاٹن وول (Cotton Wool) کی مدد سے صاف کریں۔ بچے کی آنکھ میں دس فیصد ایلبیو سڈ (Albucid 10%) آئی ڈراپس ڈالے جاسکتے ہیں۔

علاج: بچے کی آنکھ سے نکلنے والے مواد کا کچر کر دائیں تاکہ صحیح اینٹی بائیوٹک تجویز کی جاسکے۔ جب تک رپورٹ نہ آئے۔ اس وقت تک درج ذیل علاج دیا جاسکتا ہے۔ پینسلین جی (Pencillin-G) کے 10,000 یونٹ ایک ملی میٹر ڈسٹلڈ واٹر میں ڈال کر تیار کر لیں۔ اس کے بعد ہر آنکھ میں ان تیار کردہ ڈراپس کا ایک قطرہ درج ذیل ترتیب سے ڈالیں:

- ✿ ایک قطرہ ہر 30 منٹ بعد ڈالیں۔ کل 6 مرتبہ
- ✿ ایک قطرہ ہر 60 منٹ بعد ڈالیں۔ کل 6 مرتبہ
- ✿ جب کچر کی رپورٹ آجائے تو اس کے مطابق اینٹی بائیوٹک دیں۔

☆..... گیسٹر وائٹرائٹس (Gastroenteritis): ہمارے ملک میں نومولود بچوں میں یہ مرض بہت عام اور جان لیوا ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): نومولود بچوں میں گیسٹر وائٹرائٹس کے مرض کی علامات درج ذیل ہیں:

☆.....	بچہ بہت زیادہ چڑچڑاہو جاتا ہے اور بہت کم دودھ پیتا ہے یا پینے سے انکار کر دیتا ہے۔
☆.....	پاخانہ پہلے پانی کی طرح اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور بار بار آتا ہے جبکہ بعد میں پاخانے کی رنگت سبز ہو جاتی ہے۔
☆.....	پاخانے میں بہت زیادہ پانی اور نمکیات کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے بچے میں خشکی کی علامات نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
☆.....	بچے کے سر کی تالو کی ہڈیاں یعنی فانٹائلے (Fontanelae) بیٹھ جاتے ہیں۔
☆.....	بچے کے چہرے اور ماتھے پر چھریاں سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔
☆.....	بچے کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔
☆.....	بچے کی جلد کی رنگت زردی مائل خاکستری (Pale Grey) ہو جاتی ہے۔
☆.....	بچہ بہت بیمار اور لاغر دکھائی دیتا ہے۔
☆.....	اگر علاج غلط ہو جائے یا نامکمل علاج کیا جائے تو بچے کی جان بھی جاسکتی ہے۔

بچاؤ (Prophylaxis): نومولود میں گیسٹر وائٹرائی ٹس سے بچاؤ کے لئے درج ذیل نکات پر توجہ دیں؛

☆.....	دودھ پلانے کے دوران چھاتیوں کی صفائی رکھیں۔
☆.....	اگر بچے کو باہر کا دودھ دیا جا رہا ہے تو اسے ہر ممکن طریقہ سے جراثیموں سے پاک رکھیں۔
☆.....	متاثرہ بچے کو باقی بچوں سے الگ رکھیں۔
☆.....	آلودہ نمپکن وغیرہ کو ڈھانپ کر اینٹی سپٹک لوشن میں رکھیں اور گاہے بے گاہے تبدیل کرتی رہیں۔
☆.....	ریکٹل سمیر (Rectal Smear) کلچر اور سینٹی وٹی کے لئے بھجوا دیں۔

علاج (Treatment): نومولود میں گیسٹر وائٹرائی ٹس کے علاج کے سلسلے میں درج ذیل نکات اختیار کریں؛

- 1۔ درمیانے درجے کی انفیکشن میں دودھ بند کر دیں۔
- 2۔ چوبیس گھنٹے تک بچے کو گلوکوز سیلائن (Glucose Saline) دیں۔ 24 گھنٹے میں بچے کو 4 اونس گلوکوز سیلائن فی پاؤنڈ جسم کے وزن کے حساب سے دیں۔ 6 پاؤنڈ وزن بچے کیلئے $24 = 4 \times 6$ اونس گلوکوز سیلائن چوبیس گھنٹے میں دینے پڑیں گے۔ یعنی تین اونس ہر تین گھنٹے بعد دیں۔
- 3۔ انشاکس شربت بچے کے وزن کے حساب سے فی خوراک دن میں تین سے چار مرتبہ دیں۔
- 4۔ اگر انفیکشن شدید ہو یا پھر بچے میں پانی کی کمی کی شدید علامات نمایاں ہو جائیں تو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کریں۔
- 5۔ رگ کے ذریعے ڈرپ کی مدد سے بچے کے جسم میں پانی کی کمی کو دور کریں۔
- 6۔ شدید انفیکشن میں بچے کو طاقوٹورا اینٹی بائیوٹکس استعمال کروائی جاسکتی ہیں۔
- 7۔ جب انفیکشن کسی حد تک کنٹرول ہو جائے اور اسہال میں بھی کمی واقع ہو جائے تو بالائی سے پاک دودھ دینا شروع کر دیں۔
- 8۔ جب بچے کی حالت بہت بہتر ہو جائے تو پھر بچے کو ماں کا دودھ استعمال کروانا شروع کر دیں۔

☆..... نمونیا (Pneumonia): پھیپھڑوں کی سوزش کو نمونیا کہتے ہیں۔ نمونیا عام طور پر ریپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے باعث ہوا کرتا ہے۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms): نومولود میں نمونیا کی علامات درج ذیل ہیں:

☆.....	بچے کے عمل تنفس کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے۔
☆.....	جلد کی رنگت اکثر نیلی (Cyanosed) ہو جاتی ہے۔
☆.....	جب انفیکشن ہو جائے تو بچے کو بخار ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔
☆.....	بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔

علاج (Treatment): نمونیا کا علاج درج ذیل نکات کو ذہن میں رکھ کر کرنا چاہیے:

☆.....	جلد کی رنگت کا نیلا ہونا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لئے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔
☆.....	بچے کا سر ٹانگوں کے مقابلے میں بلند رکھا جاتا ہے اور ہر دو گھنٹے بعد بچے کی پوزیشن تبدیل کی جاتی ہے۔
☆.....	اگر دودھ پلانے سے بچے میں سایانوسس کی علامات نمودار ہونے لگ جائیں تو پھر نیوب فیڈنگ کو ترجیح دیں۔
☆.....	سکشن (Suction) کے ذریعے اضافی میوکس کو نکال دیں۔
☆.....	دافع بخار دوا کے ساتھ ساتھ ایک مناسب اینٹی بائیوٹک بھی دینا چاہیے۔
☆.....	اکثر اوقات ایسے کیسوں میں اینٹی بائیوٹک انجکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔

☆..... ہلکی انفیکشنز (Minor Infections): نومولود کو معمولی جسمانی انفیکشن ہو جانے کو مائنر انفیکشنز کہتے ہیں۔ نومولود میں درج ذیل دو

اقسام کی ہلکی انفیکشنز عام طور پر ہوتی ہیں:

1۔ پیرونا ئے شیا (Paronychia): پیرونا ئے شیا کے مرض میں نومولود کے کسی ایک ناخن کے کنارے میں انفیکشن سی ہو جایا کرتی ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو نومولود کی متاثرہ انگلی پر جنشن وائلٹ (Gention Violet) لگا کر انگلی پر پٹی باندھ دیں۔

2۔ چھاتی کی انفیکشن (Breast Infection): بعض اوقات نومولود بچوں کی چھاتیاں معمولی سی مٹھولی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر انہیں زیادہ دبایا جائے تو نومولود کو چھاتیوں کی انفیکشن ہو سکتی ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ نومولود کی چھاتیوں کو بالکل نہ چھوا جائے۔

علاج: اگر نومولود میں چھاتیوں کی سوزش ہو گئی ہے تو پھر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں اور اگر پھوڑا بن چکا ہے تو اسے فوراً صاف کریں۔

☆.....ہیمورہجک ڈیزیز آف نیو بارن (Haemorrhagic Disease Of Newborn): اس مرض میں پیدائش کے فوراً بعد نومولود بچے میں خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خون کا یہ اخراج پاخانے کے ذریعے ہو تو اسے مے لی نیا (Melenia) کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر خون کا یہ اخراج الٹی میں ہو تو اسے ہیماٹیسس (Haematemesis) کہتے ہیں۔ ان دونوں اخراج خون کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:

1۔ مے لی نیا (Melenia): اس مرض میں میکونیم میں خون ملا ہوا ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات صرف خون یا جما ہوا خون پاخانے کی جگہ نکلتا ہے۔ بعض اوقات بچہ لیبر کے دوران خون نگل لیتا ہے اور پھر یہ خون پاخانے کے ساتھ باہر آ جاتا ہے لیکن یہ بچے بالکل صحت مند ہوتے ہیں۔ مے لی نیا کا مطلب کالے رنگ کے پاخانے لیا جاسکتا ہے۔ اس حالت میں پاخانہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ میکونیم والا پاخانہ گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ جس بچے میں کالے پاخانے آرہے ہوتے ہیں وہ بالکل زرد پڑ جاتے ہیں۔ ایسے بچے نہ تو دودھ پیتے ہیں اور نہ ہی چیختے ہیں بلکہ بالکل چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ جن بچوں کا فوری علاج نہیں کیا جاتا وہ بچے فوت بھی ہو سکتے ہیں۔

علاج: اس صورت میں خون لگائیں اور اسکے ساتھ ساتھ وٹامن 'کے' (Vitamin K) اور وٹامن 'سی' (Vitamin C) بھی دینا چاہیے۔

2۔ خون کی الٹی (Haematemesis): اس حالت میں بچے کو الٹی کے ساتھ خون آتا ہے۔ اسکی وجہ لیبر کے دوران بچے کا خون نگل لینا ہے۔ اس کیفیت سے فوری طور پر ڈاکٹر کو آگاہ کریں۔



دیگر وجوہات کہ باعث نومولود میں بلیڈنگ

(BLEEDING FROM OTHER CAUSES IN NEWBORN)

1۔ نومولود کیوں میں وچائل بلیڈنگ (Vaginal Haemorrhage In Female Newborns): کئی مرتبہ نومولود کیوں میں وچائل سے معمولی خون کا اخراج ہو سکتا ہے۔ خون کا یہ اخراج نومولود کی پیدائش کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ ایسا ماں کی طرف سے ہارمونز کے ختم ہو جانے سے ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی علاج کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

2۔ امبالائیکل ہیموریج (Umbilical Haemorrhage): اگر کارڈ میں انفیکشن ہو تو جب کارڈ کو علیحدہ کیا جاتا ہے تو امبالائیکل کارڈ سے خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ اسکے علاج کیلئے پریشر بینڈج (Pressure Bandage) استعمال کی جاتی ہے اور اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔





Haemorrhagic Disease In Different Babies

نومولود بچوں کی اموات کی وجوہات

(CAUSES OF NEONATAL DEATHS)

تعارف (Introduction): نومولود یا نیونٹس (Neonates) کی اموات سے مراد وہ اموات ہیں جو پیدائش کے پہلے دن سے لے کر اٹھائیس دن مکمل ہونے تک کے درمیان واقع ہوا کرتی ہیں۔

نیونٹل مارٹلٹی ریٹ (Neonatal Mortality Rate): نیونٹل مارٹلٹی ریٹ سے مراد ایک سال میں 1000 زندہ بچوں میں سے نیونٹس (Neonates) کی تعداد جو کہ فوت ہو جائیں، اس کی پیمائش کرنے کیلئے درج ذیل فارمولا استعمال کیا جاتا ہے؛

$$NMR = \frac{\text{ایک سال میں اٹھائیس دن سے کم عمر مرنے والے بچوں کی تعداد}}{1000} \times 1000$$

اسی سال کل زندہ بچوں کی پیدائش

نومولود بچوں کی اموات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نومولود بچے پر اندرونی عوامل مثلاً کم وزن بچے یا پیدائشی چوٹوں کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ نومولود بچوں کی اموات براہ راست پیدائشی وزن اور حمل کے دورانیے پر منحصر ہے۔ اگر حاملہ خواتین میں اینٹی ٹیٹل کیئر اور پوسٹ ٹیٹل کیئر بہتر کر دی جائیں تو نومولود بچوں کی شرح اموات میں خاطر خواہ کمی کی جاسکتی ہے۔ ماحولیاتی عوامل کو ٹھیک کرنے کے باوجود نومولود بچوں کی شرح اموات میں کمی بہت مشکل کام ہے۔ نومولود بچوں میں لڑکے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ نومولود بچوں کی اموات کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں؛

(Low Birth Weight)	☆..... پیدائشی طور پر کم وزن بچے۔
(Birth Injuries & Difficult Labour)	☆..... پیدائشی چوٹیں اور مشکل لیبر۔
(Congenital Anomalies)	☆..... پیدائشی اور راشی نقائص۔
(Haemolytic Disease Of New Born)	☆..... ہیملوائٹک ڈیزیز آف نیو بارن۔
(Condition Of Placenta & Cord)	☆..... پلے سینٹا اور کارڈ کی حالت۔
(Diarrhoeal Diseases)	☆..... دست و اسہال۔
(Acute Respiratory Infections)	☆..... سانس کی نالی کی شدید انفیکشنز۔
(Tetanus)	☆..... تشنج کی بیماری۔

☆☆☆.....

فیٹل ڈیٹھ

(FOETAL DEATH)

تعارف (Introduction): فیٹل ڈیٹھ سے مراد بچے کی مکمل پیدائش سے پہلے وفات ہے۔ اس میں حمل کے دورانیے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مختلف ممالک میں حمل کا دورانیہ مختلف رکھا گیا ہے لیکن یہ اموات عموماً حمل کے 20 ویں اور 28 ویں ہفتے میں واقع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ حمل کے بیسویں اور ستائیسویں ہفتے کے دوران ہونے والی بچوں کی اموات کی معلومات اتنی درست نہیں ہیں جتنی کہ حمل کے 28 ہفتے مکمل ہو جانے کے بعد بچوں کی اموات کی معلومات ہیں۔ اس لئے ان دونوں اقسام کی اموات سے متعلق الگ الگ بحث کرنی چاہیے۔ اکثر ممالک تو اسل برتھ (Still Birth) کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا نہیں کر پاتے۔



اسٹل برتھ ریٹ

(STILL BIRTH RATE)

تعارف (Introduction): اسٹل برتھ سے مراد ایسے مردہ بچے کی پیدائش ہے کہ جس کا وزن 1000 گرام سے زیادہ ہو۔ اس وزن کو اٹھائیسویں ہفتے کے حمل کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اسٹل برتھ ریٹ سے مراد ایک سال میں 1000 پیدائشوں (زندہ بچے + مردہ بچے مجموعی طور پر) میں سے اسٹل برتھ بچوں کی تعداد ہے۔ اسے درج ذیل فارمولے کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{اسٹل برتھ ریٹ (Stillbirth Rate)} = \frac{\text{مردہ بچوں کی تعداد جن کا پیدائش کے وقت وزن 1000 گرام سے زائد ہے}}{1000 \times}$$

کل زندہ پیدائشیں + مردہ بچوں کی تعداد جن کا وزن 1000 گرام سے زائد ہے



اسٹل برتھ کی وجوہات

(CAUSES OF STILL BIRTH)

تعارف (Introduction): اسٹل برتھ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اسٹل برتھ کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

(Infections)	انفیکشنز۔	☆.....
(Pregnancy Induced Hypertension)	دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی۔	☆.....
(Rh-Incompatibility)	آراینج این کپی ٹی بلٹی۔	☆.....
(Diabetes)	ذیابیطس۔	☆.....
(Premature Rupture Of Membranes)	امنیٹک ممبرینز کا وقت سے پہلے پھٹ جانا۔	☆.....
(Multiple Pregnancy)	ملٹی پل پریگ نیسی۔	☆.....
(Cord Anomalies)	کارڈ کی خرابیاں۔	☆.....
(Foetal Malformations)	فیٹل میل فارمیشنز۔	☆.....
(Placental Anomalies)	پلے سینٹا کی خرابیاں۔	☆.....



پاکستان میں اسٹل برتھ ریٹ

(STILLBIRTH RATE IN PAKISTAN)

پیری نیٹل مارٹلٹی ریٹ (Perinatal Mortality Rate): پیری نیٹل مارٹلٹی سے مراد لیٹ فیٹل ڈیٹھ (اسٹل برتھ) اور ارلی نیونٹل ڈیٹھ

(Early Neonatal Death) کا مجموعہ ہوتا ہے۔

بیری نیٹل مارٹلٹی کی وجوہات (Causes Of Perinatal Mortality): بیری نیٹل مارٹلٹی کی پاکستان میں وجوہات درج ذیل ہیں:

(1) اینٹی نیٹل وجوہات (Antinatal Causes): اینٹی نیٹل وجوہات میں ماں کی بیماریاں مثلاً:

(Hypertension)	☆..... بلند پریشر کی زیادتی۔
(Cardiac Diseases)	☆..... دل کی بیماریاں۔
(Diabetes Mellitus)	☆..... ذیابیطس۔
(Tuberculosis)	☆..... تپ دق۔
(Severe Anaemia)	☆..... خون کی شدید کمی۔
(Pelvic Diseases)	☆..... پیلوک ڈیزیز۔
(Myomas)	☆..... مایوماز۔
(Endometriosis)	☆..... اینڈومیٹریوسس۔
(Ovarian Tumors)	☆..... اوویری کے ٹیومرز۔
(Uterine Anomalies)	☆..... یوٹرس کی خرابیاں
(Cervical Incompetence)	☆..... سروائیکل ان کمپیٹنس۔
(Defects In Endocrine System)	☆..... اینڈوکرائن نظام کی خرابیاں۔
(Blood Incompatibilities)	☆..... خون کی خرابیاں۔
(Malnutrition)	☆..... غذائی کمی۔
(Toxaemias Of Pregnancy)	☆..... ٹاکسمیا آف پریگننسی۔
(Antepartum Haemorrhage)	☆..... اینٹی پارٹم ہیمریج۔
(Congenital Anomalies)	☆..... وراثتی / پیدائشی نقائص۔
(Advance Maternal Age)	☆..... ماں کی عمر میں زیادتی۔

(2) انٹرنیٹل وجوہات (Internatal Causes): انٹرنیٹل وجوہات درج ذیل ہیں:

(Congenital Injuries)	☆..... پیدائشی چوٹیں۔
(Asphyxia)	☆..... اسفکسیا۔
(Prolonged Labour)	☆..... لیبر کا طویل ہو جانا۔
(Obstetric Complications)	☆..... دوران پیدائش پیچیدگیاں۔

(3) پوسٹ نیٹل وجوہات (Postnatal causes): پوسٹ نیٹل وجوہات درج ذیل ہیں:

(Prematurity)	☆..... پری میچورٹی۔
(Respiratory Distress Syndrome)	☆..... ریسپائرٹری ڈسٹریس سائنڈروم۔
(Respiratory Infections)	☆..... سانس کی نالیوں کی انفیکشنز۔
(Alimentary Infections)	☆..... نظام انہضام کی انفیکشنز۔
(Congenital Anomalies)	☆..... وراثتی/پیدائشی نقائص۔

(4) نامعلوم (Idiopathic): بعض اوقات پیری نیٹل مارٹیلٹی کی وجوہات کا کچھ پتہ نہیں چلتا لہذا انہیں آئیڈیوپیتھک وجوہات کہتے ہیں۔

پوسٹ نیٹل مارٹیلٹی ریٹ (Postnatal Mortality Rate): پیدائش کے اٹھائیسویں دن سے لے کر ایک سال کے دوران بچوں کی اموات کو پوسٹ نیٹل ڈیٹھ (Postnatal Deaths) کہتے ہیں۔ پوسٹ نیٹل مارٹیلٹی ریٹ کی پیمائش درج ذیل فارمولے سے کی جاتی ہے:

$$PNMR = \frac{\text{ایک سال میں اٹھائیسویں دن سے ایک سال تک کل بچوں کی تعداد جو فوت ہوئے}}{1000 \times}$$

اسی سال کل زندہ بچوں کی پیدائش کی تعداد

پوسٹ نٹل مارٹیلٹی کی وجوہات (Causes Of Postnatal Mortality): پوسٹ نٹل مارٹیلٹی کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

(Diarrhoea)	☆.... دسٹ واسہال۔
(Respiratory Infections)	☆.... سانس کی نالیوں کی انفیکشنز۔
(Malnutrition)	☆.... غذائی کمی۔
(Congenital Anomalies)	☆.... وراثتی / پیدائشی نقائص۔

انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ (Infant Mortality Rate): اس سے مراد ایک سال میں کل رجسٹرڈ ہونے والی پیدائشوں میں سے کتنے انفینٹس (Infants) کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ کی پیمائش درج ذیل فارمولے سے کی جاتی ہے؛

$$IMR = \frac{\text{ایک سال میں ایک سال سے کم عمر بچوں کی تعداد جو فوت ہو گئی ہے}}{1000 \times \text{اسی سال کل زندہ بچوں کی پیدائش کی تعداد}}$$

اسی سال کل زندہ بچوں کی پیدائش کی تعداد

انفینٹ مارٹیلٹی کی وجوہات (Causes of Infant Mortality): اس کی بھی وہی وجوہات ہیں جو کہ نیونٹل مارٹیلٹی کی ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ نائٹلی میڈیسن

رضاعت، دودھ پلانا

(LACTATION)

تعارف (Introduction): رضاعت (Lactation) سے مراد ماں کا اپنے نومولود بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ رضاعت کا یہ عرصہ پیدائش سے لے کر دو سال تک ہوتا ہے یعنی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی چھاتیوں سے بچے کی عمر دو سال ہونے تک دودھ پلائے۔

اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کو بچے کے لئے ایک مکمل غذا بنایا ہے۔ اس لئے نومولود بچے کی پیدائش سے لے کر چار ماہ تک دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں دینی چاہیے۔ موجودہ تحقیقات کے مطابق بچے کی پیدائش کے دو گھنٹے کے بعد بچے کو ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلانا چاہیے یا کم از کم بچے کا منہ چھاتیوں سے ضرور لگانا چاہیے خواہ ماں کو دودھ اترے یا نہ اترے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتے ہیں ایک تو چھاتی سے بچے کا منہ لگانے سے یوٹرس کا سکڑاؤ جلدی ہوگا اور یوٹرس کے سکڑنے سے خون کا بہاؤ بھی کم ہو جائیگا اور ماں کی توجہ جذباتی طور پر بچے کو دودھ پلانے کی جانب راغب ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ اپنے یوٹرس کے سکڑنے کے دوران محسوس ہونے والے درد میں بھی کمی محسوس کرے گی۔ شروع شروع میں چونکہ ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے اسلئے اس میں روغنیت زیادہ ہوتے ہیں جو بچے کے پیٹ میں پہنچ کر جلاب کا کام دیتے ہیں۔ اس طرح بچے کا پیٹ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو تیسرے دن یا چھٹے دن دودھ پلانا شروع کیا کرتی تھیں۔

ماں کا دودھ بچے کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ ماں کے اپنے بچے کو دودھ پلانے میں اور بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے دل میں اپنے بچے سے نسبتاً زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح وہ بچہ بھی اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ وہ زود ہضم اور متوازن غذا کھائیں۔ ایسے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مختلف بیماریوں کا بہت کم شکار ہوتے ہیں۔ ان کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور وہ تھوڑے اور اسہال کے امراض سے بڑی حد تک بچے رہتے ہیں۔

اسی طرح وہ مائیں جو بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں بہت سے مسائل سے بچی رہتی ہیں مثلاً جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانا ماں اور بچے میں محبت کا باعث ہوتا ہے اور ایسی مائیں ممکنہ طور پر چھاتیوں کی بیماریوں سے بچی رہتی ہیں۔ ماڈرن تحقیق کے مطابق بچے کو اپنا دودھ نہ پلانے والی مائیں اکثر چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور اس طرح اپنے جسم کا ایک خوبصورت عضو کٹاؤ بیٹھتی ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی ماؤں کا یوٹرس، ڈیلیوری کے بعد سکڑ کر جلد اپنی اصلی جگہ پر آ جاتا ہے جسے انوولیوشن آف یوٹرس (Involution Of Uterus) کہتے ہیں۔ اسی طرح نومولود کو اپنی چھاتی سے دودھ پلانا ماں کے لئے قدرتی طور پر ایک مانع حمل (Contraceptive) عمل ہوتا ہے اور یوں عام طور پر دودھ پلانے والی مائیں قدرتی طور پر رضاعت کے دوران حاملہ ہونے سے بچی رہتی ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ بوتل میں بار بار دودھ بنانے اور بوتل کو صاف کرنے کی زحمت سے بھی بچی رہتی ہیں۔ بازاری دودھ چونکہ مہنگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پینے سے عام طور پر بچے کی پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں لہذا پیسے کے فائدے کو خرچ سے بھی بچت رہتی ہے۔





Process Of Lactation



Common Technique For Lactation

یونٹ: 22

ماں کو ہدایات

(ADVICES TO MOTHER)

تعارف (Introduction): حمل چونکہ کوئی مرض نہیں بلکہ یہ نعمتِ خداوندی ہے اور ایک فزیولا جیکل کنڈیشن ہے لہذا ایسی صورت میں کسی بھی حاملہ کو جو کہ ماں بننے والی ہوتی ہے، درج ذیل مفید ہدایات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے کیونکہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے ماں کی صحت برقرار رہتی ہے۔

(Balanced Diet)	☆..... متوازن غذا۔
(Rest)	☆..... آرام۔
(Shoes)	☆..... جوتے۔
(Dress)	☆..... کپڑے۔
(Brassiers)	☆..... بریزیرز۔
(Breasts)	☆..... پستان۔
(Dental Care)	☆..... دانتوں کی حفاظت۔
(Drugs)	☆..... ادویات۔
(Travelling)	☆..... سفر۔
(Intercourse)	☆..... جماع۔
(Subsequent Visits)	☆..... مزید اینٹی نیٹل وزٹ۔
(Antinatal Classes)	☆..... اینٹی نیٹل کلاسیں۔

☆..... متوازن غذا (Balanced Diet): ایک متوازن غذا جو کم از کم 2500 کیلو ریز پر مشتمل ہو، حاملہ خاتون کو روزانہ درکار ہوتی ہے۔ غذا کے اجزاء پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یعنی پروٹینز کا زیادہ استعمال (گوشت، مچھلی، پنیر) کیلشیم (دودھ، پنیر، سبزیاں، روٹی) تازہ پھل اور سبزیاں وغیرہ زیادہ استعمال کرنی چاہئیں کیونکہ ان میں وٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فولاد (Iron) کو سبز پتوں والی سبزیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فولاد گوشت (بالخصوص جگر سے) انڈوں، اجناس، دالوں اور ڈرائی فروٹ میں پایا جاتا ہے۔ اگر غذا بہت زیادہ متوازن ہے تو پھر ایسی صورت میں حمل کے آخری مہینوں میں اضافی فولاد اور فولک ایسڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر غذا متوازن نہیں ہے تو پھر فولاد، فولک ایسڈ، وٹامن اور کیلشیم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور اسے حمل کی پہلی سہ ماہی (First Trimester) کے بعد حاملہ خاتون کو دینا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک حاملہ خاتون کے لئے روزانہ کی خوراک میں درج ذیل چیزیں شامل ہونی ضروری ہوتی ہیں:

☆..... دودھ ایک گلاس۔	(Glass of Milk)
☆..... ایک انڈا۔	(One Egg)
☆..... دن میں ایک مرتبہ گوشت کا استعمال۔	(Meat in single meal)
☆..... تازہ پھل۔	(Fresh Fruits)
☆..... تازہ سبزیاں۔	(Fresh Vegetables)
☆..... خشک میوہ جات۔	(Dry Fruits)
☆..... چکنائی اوسط مقدار میں۔	(Fats in balance quantity)
☆..... پانی کا زیادہ استعمال۔	(Plenty of Water)

تازہ پھل اور سبزیاں قبض سے بچاتی ہیں جو کہ حمل کے دوران بہت زیادہ مسئلہ بنی رہتی ہے۔

☆..... آرام (Rest): بہت سی خواتین حمل کے دوران تھکن کی شکایت کرتی ہیں۔ اسی لئے باقاعدہ آرام حمل کے دوران نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان خواتین کے لئے تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جو کہ باہر کام کرتی ہیں یا گھر کے اندر سارا دن کام کرتی رہتی ہیں۔ حمل کے آخری ہفتوں میں بائیں طرف کروٹ کر کے سونا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ایک تکیہ استعمال کر کے پیٹ کو سہارا دیا جاسکتا ہے۔

☆..... جوتے (Shoes): اونچی ایڑھی والے جوتوں کے استعمال سے احتراز کیا جائے کیونکہ ایسے جوتوں کے استعمال سے کمر درد کی شکایت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارشن کا خطرہ بھی رہتا ہے۔



Fresh Fruits



Vegetables



Medicines



Self Breast Examination

☆..... **کپڑے (Dress):** حاملہ کے کپڑے زیادہ تنگ نہیں ہونے چاہئیں خاص طور پر کمر کے ارد گرد کیونکہ اس کی وجہ سے بے چینی بڑھ سکتی ہے۔

☆..... **بریزیرز (Brassiers):** حاملہ خواتین کو بریزیرز استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے نپل پر پریشر بڑھ جائے اور وہ دب جائیں۔ حمل کے آخری مہینوں میں یوٹرس آگے کوڑھلک جاتا ہے تو ایسی صورت میں بیلٹ استعمال کی جاسکتی ہے۔

☆..... **پستان (Breasts):** دن کے دوران نپل شیلڈ استعمال کی جاسکتی ہے۔ حاملہ خاتون کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ جب بھی نہائے تو اس وقت نپل کو آرام سے پانی کے ساتھ صاف کرے اور اس پر لگے ہوئے چھلکوں کو نرمی کے ساتھ اتار دے اور نپل کو آہستگی سے دبا کر اس میں سے نکلنے والے دودھ کو بھی صاف کر دے۔ چھتیسویں ہفتے کے بعد اسے یہ ہدایت کر دیں کہ اس نے کس طرح چھاتیوں میں سے دودھ نکالنا ہے تاکہ چھاتیوں میں دودھ بہت زیادہ نہ بھر جائے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حاملہ خاتون کو ذہنی طور پر بھی تیار کریں کہ بچے کیلئے ماں کے دودھ کی اہمیت کتنی ہے۔ ماں کے دودھ اور باہر کے دودھ میں کیا فرق ہے اور یہ سب مفید و کارآمد باتیں ماں کو بتانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔

☆..... **دانتوں کی حفاظت (Dental Care):** 50 فیصد حاملہ خواتین میں مسوڑھوں کی سوزش کی شکایت ہو جاتی ہے اور دانتوں کو کیڑا بھی لگ سکتا ہے۔ اس لئے ہر حاملہ خاتون کو ڈینٹل سرجن سے حمل کے دوران ایک دفعہ ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔

☆..... **ادویات (Drugs):** ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کوئی بھی دوا حاملہ خاتون استعمال نہ کرے۔ حمل کی پہلی سہ ماہی (First Trimester) میں تو قطعاً کوئی دوا استعمال نہ کی جائے کیونکہ اس عرصے میں بچے کے مختلف اعضاء بننے کا عمل جاری ہوتا ہے اور بچے کے اعضاء پر خطرناک علامات مرتب ہو سکتی ہیں۔ اگر حمل کے دوران کوئی دوا استعمال کرنی ہو تو پھر صرف وہ دوا استعمال کی جائے جو کہ حمل میں محفوظ طریقے سے دی جاسکتی ہو۔

☆..... **سفر (Travelling):** بتیسویں ہفتے کے بعد لمبے سفر سے احتراز کریں جبکہ پیچیدہ کیسوں میں تو اس سے پہلے ہی سفر سے منع کر دیا جائے۔

☆..... **جماع (Intercourse):** جماع یا ہم بستری دوران حمل منع نہیں ہے لیکن اگر حاملہ خاتون میں بلیڈنگ (Bleeding)، ابارشن (Abortion) یا پری ٹرم لیبر (Pre-Term Labour) کی ہسٹری موجود ہو تو پھر جماع سے پرہیز کرنا زیادہ احسن ہے۔ دوران حمل عورت کی جنسی خواہش میں ویسے بھی قدرے کمی آ جاتی ہے۔

☆..... مزید اینٹی نیٹل وزٹ (Subsequent Visits): انٹائیسیو ہفتے تک ہر ماہ ایک دفعہ حاملہ خاتون کو اپنا معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ اس کے بعد چھتیسویں ہفتے تک ہر دو ہفتے بعد اور پھر ڈیلیوری ہونے تک ہر ہفتے معائنہ کروایا جائے۔ تیسویں ہفتے میں پیشاب کا مکمل ٹیسٹ اور ہیموگلوبن لیول دوبارہ چیک کرنا چاہیے۔

☆..... اینٹی نیٹل کلاسیس (Antinatal Classes): اینٹی نیٹل کلاسیس حاملہ خواتین اور ان کی رشتہ داروں کے ساتھ منعقد کروانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مختلف عمروں کی خواتین کو اینٹی نیٹل کینک پر بلایا جاتا ہے اور ان خواتین کو بہت ہی آسان زبان میں حمل، لیبر اور پریوریئم (Puerperium) کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حمل اور لیبر کے دوران کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ ان خواتین کو سمجھانے میں مختلف طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں مثلاً چارٹ اور تصاویر کی مدد سے حمل اور لیبر کے مختلف مراحل سمجھائے جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو فلم بھی دکھائی جاسکتی ہے۔ آخر میں ان خواتین کو سوالات پوچھنے کا موقع دیں۔ حاملہ خواتین کو اپنے آنے والے بچے کیلئے بھی تیار کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسے اپنا دودھ پلائیں۔ ان خواتین کو تشنج (Tetanus) کے خلاف ویکسین کا شیڈول بھی بتایا جاسکتا ہے۔ ٹینس ٹاکسائیڈ کی ویکسین کا عام شیڈول خواتین کے لئے ذیل میں دیا گیا ہے:

☆.....	TT 1	شادی سے پہلے یا شادی کے بعد یا حمل کے بعد لگائیں۔
☆.....	TT 2	پہلے ٹیکے کے ایک ماہ کے بعد لگائیں۔
☆.....	TT 3	دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگائیں۔
☆.....	TT 4	تیسرے ٹیکے کے ایک سال بعد لگائیں۔
☆.....	TT 5	چوتھے ٹیکے کے ایک سال بعد لگائیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



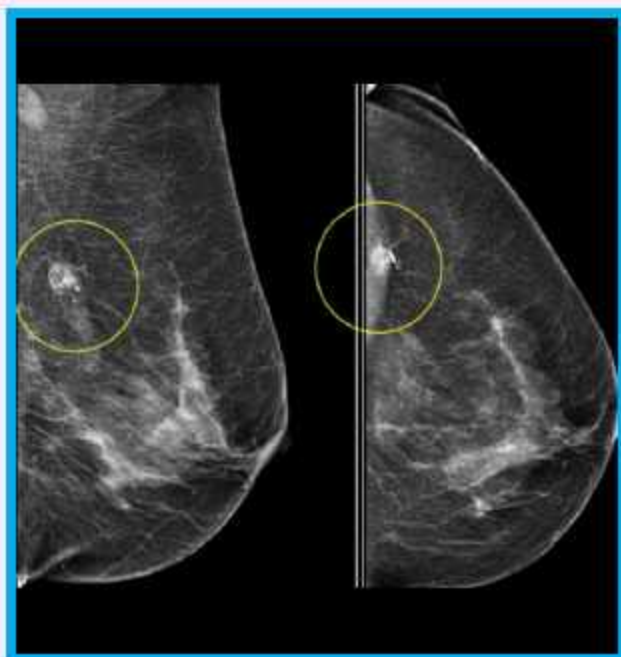
Self Breast Examination



Self Axillary Examination



Breast Base Examination



Mammographic Lymph Node

یونٹ: 23

بچوں کے متعدی امراض

(INFECTIOUS DISEASES OF CHILDREN)

تعارف (Introduction): بچوں کی پیدائش جہاں بذات خود ایک ٹیکنیکل اور پیچیدہ پراسس ہے وہیں بچوں کو کم عمری میں نشوونما کے دوران لگ جانے والے متعدی امراض بھی ان کے لئے ایک خطرناک کنڈیشن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے متعدی امراض کی انہی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے دنیا بھر کی حکومتوں نے اپنے اپنے ممالک میں بچوں کو متعدی امراض سے بچانے کے لئے بالکل فری اور نہایت موثر ویکسی نیشن پلان شروع کر رکھے ہیں جس سے آج کل دنیا کے تمام ممالک کے بچے مستفید ہو رہے ہیں۔ بچوں کو ممکنہ طور پر لگ جانے والے متعدی امراض سے متعلق سمجھ بوجھ رکھنا اور حاصل کرنا نہ صرف والدین بلکہ معاشرے کے تمام افراد کے لئے انتہائی ناگزیر ہے۔ ذیل میں کم عمری کے دوران بچوں کو لگنے والے خطرناک متعدی امراض سے متعلق بحث کی جا رہی ہے جس کا مقصد والدین اور خصوصاً ماؤں کو ان امراض سے متعلق تعلیم دینا ہے۔



(میزلز...خسرہ)

(MEASLES / RUBEOLA / MORBILLI)

تعارف (Introduction): خسرہ ایک اکیوٹ قسم کا متعدی مرض ہے جو کہ پیرامائیکسو وائرس کے ذریعے لاحق ہوتا ہے۔ اس مرض میں جلد اور میوکس ممبرینز متاثر ہوتی ہیں۔ یہ مرض بہت ہی جلد ایک شخص سے دوسرے کو لگتا ہے۔

An acute infectious disease caused by Paramyxovirus in which skin and mucous membranes are affected. It is highly contagious disease.

دورانیہ (Incubation Period):

(10 - 14 days)	☆..... 10 سے 14 دن۔
----------------	---------------------

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(Catarrhal symptoms)	☆..... نزلہ زکام جیسی علامات محسوس ہوں گی۔
(High grade fever)	☆..... اچانک تیز بخار کا آجانا۔
(Rhinorrhoea)	☆..... ناک کا بہنا۔

(Sneezing)	☆ چھینکیں آنا۔
(Conjunctivitis)	☆ آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔
(Blephritis)	☆ پپٹوں کی سوزش۔
(Epiphora)	☆ آنکھوں سے پانی بہنا۔
(Coughing)	☆ کھانسی آنا۔
(Hoarseness of voice)	☆ آواز کا پھٹ جانا۔
(Laryngitis)	☆ لیرنکس کی سوزش۔
(Photophobia)	☆ روشنی کی جانب دیکھنے سے تکلیف ہونا۔
(Koplik's spots)	☆ منہ کی میوکس ممبرین پر چھوٹے چھوٹے سفید دھبے پڑنا
(Maculo-papular skin rashes)	☆ تمام جسم پر سرخ رنگ کے خاص قسم کے دانے نمودار ہونا
(These rashes are present on skin superficially)	☆ یہ سرخ دانے جلد کی اوپری سطح پر ہی ہوا کرتے ہیں۔
(Rashes are present on face, neck, chest & back)	☆ یہ دانے چہرے، گردن، سینے اور کمر پر ہوتے ہیں۔
(Rashes take 3-4 days to appear)	☆ یہ دانے نمودار ہونے میں تین سے چار دن لیتے ہیں۔
(Rashes subsides itself & fever becomes low grade)	☆ دانے خود بخود مر جھاتے ہیں اور بخار کم ہونے لگتا ہے

پچیدگیاں (Complications):

(Otitis media)	☆ درمیانی کان کی سوزش ہو سکتی ہے۔
(Corneal ulcer)	☆ آنکھ کے شفاف پردے کا زخم ہو سکتا ہے۔
(Pneumonia)	☆ مریض کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔
(Encephalitis)	☆ دماغ کی ٹشوز کی سوزش یعنی انسفالائیٹس بھی ہو سکتا ہے۔
(Prone to other infections due to immune deficiency)	☆ قوت مدافعت کی کمی کے باعث دوسرے انفیکشن کا خطرہ ہونا۔

تشخیص (Diagnosis):

(Mostly it is diagnosed in clinical examination)	☆..... عام طور پر کلینیکل معائنے پر ہی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔
(It could not be diagnosed in catarrhal stage)	☆..... نزلہ وی کیفیت کے دوران عموماً تشخیص نہیں ہو پاتی۔
(It could be diagnosed when skin rashes appear)	☆..... ابھاروں والی کیفیت میں اس مرض کی واضح تشخیص ہو جاتی ہے
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

(Close contact with the infected patient is avoided)	☆..... متاثرہ مریض سے میل جول میں احتیاط کرنی چاہیے۔
(Children should be protected by active immunization)	☆..... خسرہ سے بچاؤ کیلئے بچوں کو ویکسین ضرور لگوانی چاہئیں۔

علاج (Treatment):

(Antibiotic e.g. Syp Velosef)	☆..... ایٹھی بائیوٹک شربت ویلوسیف۔
(Anti allergic e.g. Syp Actidil)	☆..... ایٹھی الرجک شربت اکتیڈیل۔
(Anti pyretic e.g. Syp Panadol)	☆..... دافع بخار شربت پیناڈول۔
(Vitamins with lysin e.g. Syp Lysovit)	☆..... وٹامن شربت لائیسوویت۔



رُوبیلا۔ جرمن خسرہ

(RUBELLA / GERMAN MEASLES)

تعارف (Introduction): رُوبیلا یا جرمن میزلز ایک وائرل بیماری ہے جو کہ کھانسنے یا چھینکنے وغیرہ سے پھیلا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے جسم میں اس بیماری کے خلاف طاقت و رقت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔

Rubella is a viral disease which spreads by droplet infection. One attack confers a high degree of immunity.

وجوہات (Causes):

Rubella Virus (An RNA Virus)	☆..... روبیلا وائرس (جو کہ ایک آر۔ این۔ اے وائرس ہے)۔
------------------------------	---

دورانیہ (Incubation Period):

(Usually 18 days)	☆..... عام طور پر 18 دن۔
-------------------	--------------------------

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(It tends to affect older children)	☆..... یہ بیماری ذرا بڑے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔
(The illness may be more severe but of short duration)	☆..... اس بیماری کا حملہ شدید لیکن مختصر عرصے کیلئے ہوتا ہے۔
(It can develop in a pregnant woman during 1st trimester)	☆..... اس کا حملہ حاملہ خواتین پر پہلے تین ماہ میں ہو سکتا ہے۔
(In such cases the child may born with congenital diseases like cardiac or mental defect, cataract, deafness)	☆..... ایسے کیسوں میں بچے پیدائشی طور پر دل و دماغ کے امراض، موتیا، بہرے پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔
(Symptoms are so slight)	☆..... علامات بہت ہلکی ہوں گی۔
(The spots are pink macules)	☆..... جلد پر گلابی دھبے ہوں گے۔
(Spots appear first behind the ears and on forehead)	☆..... یہ دھبے پہلے کانوں کے پیچھے اور ماتھے پر ظاہر ہوں گے۔

(The rash spreads to trunk and limbs)	یہ دھبے پیٹ اور ہاتھ، پیروں تک پھیل جاتے ہیں۔	☆.....
(Minor degree of conjunctivitis is present)	آنکھوں کی ہلکی سرخی و سوزش ہوتی ہے۔	☆.....
(Enlargement of lymph nodes in neck)	گردن کے لیف نوڈز بڑھ جاتے ہیں۔	☆.....
(The disease spreads by close contact with patient)	یہ بیماری مریض سے قریبی میل جول سے پھیلتی ہے۔	☆.....
(Headach, sore throat & slight fever develop)	سر درد، گلے میں دھن اور ہلکا بخار ہوتا ہے۔	☆.....
(The spots disappear within 7 days)	یہ دھبے 7 دنوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔	☆.....

پچیدگیاں (Complications):

(Polyarthrititis is a common complication)	مختلف جوڑوں کا درد اس مرض کی ایک عام پیچیدگی ہے۔	☆.....
(Encephalomyelitis may occur)	دماغی ششوں کی سوجن اور انفیکشن ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Thrombocytopenic purpura rarely may occur)	کچھ مریضوں میں پلیٹ لیٹس کی کمی سے جلد پر نیل پڑ سکتے ہیں۔	☆.....

تشخیص (Diagnosis):

(Isolation of the virus from throat confirms diagnosis)	گلے کے لعاب سے وائرس کی شناخت کا شٹ کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Rising titre of antibody in the blood)	خون میں اینٹی باڈیز کی شناخت کی جاتی ہے۔	☆.....
(Diagnosis may be made clinically)	اس مرض کی تشخیص کلینیکل معائنے پر بھی کی جاسکتی ہے۔	☆.....
(Complete blood count with ESR)	خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔	☆.....
(Urine R/E)	پیشاب کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔	☆.....

روک تھام (Prevention):

(Immunization of girls before puberty may be done)	بلوغت سے پہلے ہی لڑکیوں کو ویکسین لگانی چاہئے۔	☆.....
--	--	--------

علاج (Treatment):

(No specific treatment is available)	☆..... اس مرض کا کوئی خاص علاج موجود نہیں ہے۔
(Anti-biotic like Augmentin)	☆..... اینٹی بائیوٹک آگمنٹین۔
(Anti allergic like Adctidil)	☆..... اینٹی الرجک ایکٹیدیل۔
(Anti pyeratic Panadol)	☆..... دافع بخار پیناڈول۔
(Vitamin Syp Lysovit)	☆..... وٹامن شربت لائیسوویت۔



ہوپنگ کف۔۔ کالی کھانسی

(WHOOPING COUGH / PERTUSIS)

تعارف (Introduction): کالی کھانسی سانس کی نالیوں کا ایک ایکیوٹ مرض ہے جس میں مریض کو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں اور جب مریض سانس اندر کی جانب لیتا ہے تو اس کے سینے سے ایک خاص قسم کی آواز ”ہوپ“ آتی ہے۔

An acute infectious disease of the respiratory tract characterised by paroxysmal cough ending in a 'whoop' upon inhalation.

وجوہات (Causes):

(Bordetella Pertusis)	☆..... یہ بیماری بارڈیٹیلہ پریٹوسس جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔
-----------------------	--

دورانیہ (Incubation Period):

(7 - 10 days)	☆..... 7 سے 10 دن۔
---------------	--------------------

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

It consists of three stages).....	☆..... اس بیماری کے تین درجات ہوتے ہیں۔
-----------------------------------	---

(1) **نزلاوی درجہ:** اس درجہ میں مریض بچے کو سردی لگتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن، سرخی اور سوزش ہوتی ہے۔ چھینکیں آتی ہیں، ناک بہتی ہے، گلہ اور ناک کی میو کس ممبرین سرخ ہوتی ہے۔ خشک کھانسی، چہرے کی نیلاہٹ اور سانس میں تنگی اس درجہ کی خاص علامات ہیں۔ مریض کی نبض تیز رفتار ہوتی ہے اور مریض اس مرض سے بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔

(1) **CATARRHAL STAGE:** In this stage the child suffers from cold, cough, itching, redness and inflammation of eyes, sneezing, rhinorrhoea, congestion of throat and nasal mucosa. Dry cough, cyanosis and shortness of breath are features of this stage. Patient looks toxic with rapid pulse.

(2) **دورہ دار درجہ:** اس درجہ میں مرض ترقی کر لیتا ہے اور مریض بچے کو ایک ہی وقت میں خشک کھانسی کے کئی کئی دورے پڑتے ہیں اور ان کھانسی کے دوروں کے آخر میں ایک خاص آواز ”ہوپ“ آتی ہے یا الٹی آجاتی ہے۔ اکثر بچے کھانسی کے اس دورہ دار درجہ میں مر جاتے ہیں۔

(2) **PAROXYSMAL STAGE:** In this stage the disease progresses and the child has severe attacks of dry cough. He has many attacks of cough at a time. These attacks of cough are followed by a specific voice of "whoop" or vomiting. Most children die in this paroxysmal stage of cough.

(3) **افاقہ یا بی کا درجہ:** اس درجہ میں بچے کی علامات بہتر ہو جاتی ہیں، کھانسی کم ہو جاتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔

(3) **CONVALESCENCE (RECOVERY) STAGE:** In this stage the symptoms of child improve. Cough becomes decrease, general condition of pateint becomes good and at the last patient recovers.

پیچیدگیاں (Complications):

(Patient may develop pneumonia)	مریض کو نمونیا ہو سکتا ہے۔	☆
(Intra cranial bleeding may occur)	سر کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔	☆
(Intra ocular bleeding may occur)	آنکھوں کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔	☆
(Convulsions may occur due to hypoxia)	آکسیجن کی کمی کے باعث مریض کو جھٹکے بھی پڑ سکتے ہیں۔	☆
(Asphyxia is one of very critical complication)	سانس کی گھٹن بھی ایک انتہائی خطرناک پیچیدگی ہے۔	☆

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔	☆
(Throat smear culture is useful)	گلے کے بلغم کا معائنہ تشخیص میں سودمند ثابت ہوتا ہے۔	☆
(X-ray chest may be done)	سینے کا ایکس رے بھی بیماری کی تشخیص میں مدد دے سکتا ہے۔	☆
(Complete blood count with ESR)	خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔	☆
(Urine R/E)	پیشاب کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔	☆

روک تھام (Prevention):

(DPT vaccine must be done to all children)	☆..... تمام بچوں کو DPT ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔
(Erythromycin should be used to those children who are in close contact with the patient)	☆..... اُن بچوں کو اریٹھرومائی سین استعمال کروانی چاہیے جو مریض کے ساتھ میل جول رکھتے ہوں۔
(Hyperimmune globulin can offer temporary passive protection to the non-immunised children)	☆..... اُن بچوں کو جنہیں ویکسین نہ لگائے گئے ہوں وقتی بچاؤ کیلئے ہائپر ایمون گلوبولن دیئے جاسکتے ہیں۔

علاج (Treatment):

(Good nutrition is advised)	☆..... مریض کے لئے اچھی خوراک کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(Cough suppressants like Sancos D.M, Cosome)	☆..... خشک کھانسی کے لیے کف سیرپ مثلاً سینکوس ڈی، ایم یا کوسوم وغیرہ۔
(Anti-biotics like Azithromycin, Erythromycin etc)	☆..... اینٹی بائیوٹک ادویات مثلاً ازیٹھرومائی سین یا اریٹھرومائی سین وغیرہ

☆☆☆

ڈیفٹھیریا ... خناق

(DIPHTHERIA)

تعارف (Introduction): خناق ایک اکیوٹ انفیکشن ہے جس میں مریض کے گلے میں ایک ممبرین یعنی جھلی سی بن جاتی ہے جو مریض کے رسپائرٹری سسٹم، فیرنکس، لیرنکس اور ناک کی میوکس ممبرین کو متاثر کر سکتی ہے۔

An acute infectious condition characterised by the formation of tenacious grey pseudomembrane, which usually attacks the respiratory tract, pharynx, larynx and nasal mucous membrane.

وجوہات (Causes):

☆.....	کورانسی بیکٹیریم ڈیفٹیرائی بیکٹیریا۔	(Corynebacterium Diphtheriae Bacteria)
--------	--------------------------------------	--

دورانیہ (Incubation Period):

☆.....	2 سے 4 دن۔	(2 - 4 days)
--------	------------	--------------

ڈیفٹیریا کی اقسام (Types Of Diphtheria): ڈیفٹیریا تین اقسام کا ہو سکتا ہے:

This could be three types;

1	فیرنجیل ڈیفٹیریا۔	(PHARANGEAL DIPHTHERIA)
2	لیرنجیل ڈیفٹیریا۔	(LARYNGEAL DIPHTHERIA)
3	نیزل ڈیفٹیریا۔	(NASAL DIPHTHERIA)

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

☆.....	اس مرض کی شروعات میں گلے میں دکھن ہوتی ہے۔	(There is sore throat initially)
☆.....	مریض کو بخار ہو جاتا ہے۔	(Development of fever)
☆.....	مریض کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔	(Hoarseness of voice is there)
☆.....	مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔	(There is difficulty in respiration)
☆.....	ناک بہنے اور نزلہ زکام کی علامات ہوں گی۔	(Rhinorrhoea and Coryza symptoms are there)
☆.....	لیرنکس میں سوزش واقع ہو جاتی ہے۔	(Laryngeal swelling takes place)
☆.....	مریض کو زوردار کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔	(Forceful cough may be there)
☆.....	وقت کے ساتھ ساتھ مریض کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔	(Patient becomes pallor as the time passed)

(Membrane is visible on throat examination)	☆..... حلق کے معائنے پر گلے میں ایک ممبرین نظر آتی ہے۔
(Palatal palsy takes place as the infection progresses)	☆..... انفلکشن بڑھنے پر مریض کو تالو کا فالج ہو جاتا ہے۔
(Nasal tone disappears on talking or weeping)	☆..... بولنے یا رونے پر نازل ٹون غائب ہو جاتی ہے۔
(Restlessness due to hypoxia)	☆..... جسم میں آکسیجن کی کمی کے باعث بے چینی سی ہوگی۔
(Enlargement of cervicle lymph nodes)	☆..... گردن کے لیف نوڈز سوج کر بڑھ جاتے ہیں۔
(Dysphagia occurs)	☆..... مریض کو نگلنے یا کوئی چیز پینے میں تکلیف ہوتی ہے۔
(Bad smell in respiration)	☆..... مریض کی سانس یعنی تنفس میں بدبو ہوتی ہے۔
(Heart fail may occur)	☆..... مریض کو ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔
(Fever may or may not be there)	☆..... مریض کو بخار ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔
(Death may occur due to asphaxia)	☆..... سانس میں تنگی کے باعث مریض کی موت ہو جاتی ہے۔

پچیدگیاں (Complications):

(Patient may develop myocarditis)	☆..... مریض کو مایو کارڈیم کی سوزش مایو کارڈائی ٹس ہو سکتا ہے۔
(Neuritis may occur)	☆..... مریض کو اعصاب کی سوجن یعنی نیورائی ٹس ہو سکتا ہے۔
(Cardiac valvular lesions may occur)	☆..... دل کے والوز کی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔
(Patient may go into shock)	☆..... مریض کو شاک یعنی صدمے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔
(Death may occur)	☆..... مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔	☆.....
(Throat smear culture is useful)	گلے کے بلغم کا معائنہ تشخیص میں سودمند ثابت ہوتا ہے۔	☆.....
(X-ray chest and E.C.G may be done)	سینے کا ایکسرے اور ای۔سی۔جی کی جاتی ہے۔	☆.....
(Complete blood count with ESR)	خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔	☆.....
(Blood sugar should be estimated)	خون میں شوگر کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔	☆.....

روک تھام (Prevention):

(DPT vaccine must be done to children)	بچوں کو DPT ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔	☆.....
(Erythromycin should be used to those children who are in close contact with the patient)	اُن بچوں کو اریٹھرومائی سین استعمال کروانی چاہیے جو مریض کے ساتھ میل جول رکھتے ہوں	☆.....

علاج (Treatment):

(Inj. Benzyl penicillin i.v. TDS (ATD))	انجکشن بینزائل پنسلین ٹیڈ ڈوز کے بعد TDS لگائیں۔	☆.....
(Erythromycin should be used to those children who are allergic to penicillin)	اُن بچوں کو اریٹھرومائی سین استعمال کروانی چاہیے جو پنسلین سے الرجک ہوں۔	☆.....
(Anti toxin is given to neutralize toxin. Anti toxin dose depends upon the severity and duration of infection)	جراثیم کے زہریات زائل کرنے کیلئے اینٹی ٹاکسن ڈوز دی جاتی ہے۔ اس ڈوز کی مقدار انفکشن کے مطابق دی جاتی ہے	☆.....
(Patient should be observed for complications)	مریض میں پیچیدگیوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔	☆.....



ہائیڈرو فوبیا۔۔ آب ہول

(RABIES / HYDROPHOBIA)

تعارف (Introduction): ہائیڈرو فوبیا ایک شدید وائرل انفکشن ہے جو سنٹرل نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ اس مرض میں مریض پانی سے ڈرتا ہے، مریض کو جھٹکے پڑتے ہیں اور مریض فوج زدہ سا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری متاثرہ کتے کے کاٹنے سے لگتی ہے۔

An acute viral infection of central nervous system, characterised by hydrophobia, convulsions and paralysis. This disease is usually transmitted to humans by a bite from an infected dog.

وجوہات (Causes):

(Rhabdovirus)	ریبڈ وائرس۔	☆.....
---------------	-------------	--------

دورانیہ (Incubation Period):

(10 days - 1 year)	10 دن سے 1 سال۔	☆.....
--------------------	-----------------	--------

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(Parasthesia at the site of bite)	مریض کو کاٹی گئی جگہ پر سُن ہونے کا احساس ہوتا ہے۔	☆.....
(Development of fever)	مریض کو بخار ہو جاتا ہے۔	☆.....
(Patient suffers from anxiety and fear)	مریض کو تشویش اور خوف محسوس ہوتا ہے۔	☆.....
(Pain and inflammation at the site of bite)	مریض کو کاٹی گئی جگہ پر درد اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔	☆.....
(As the case progresses delerium develops)	مریض میں بڑھتی ہوئی ہذیانی کیفیت پائی جاتی ہے۔	☆.....
(Fear of water (hydrophobia) is present)	مریض میں پانی سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔	☆.....
(Delusions & hallucinations due to CNS involvement)	مریض کو مختلف واہے اور فریب نظر ہوتے ہیں۔	☆.....

(Patient becomes manic & starts biting & spitting)	☆..... مریض پاگل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کاٹتا اور فرش پر تھوکتا ہے۔
(Terminal hyperpyrexia develops)	☆..... آخر میں مریض کو انتہائی تیز درجے کا بخار ہو جاتا ہے۔
(Patient develops spasmodic contractions of throat muscles on drinking, sound or mention of any fluid)	☆..... مریض کے حلق کے مسلز پانی یا کوئی بھی سیال پینے یا یہاں تک کہ پانی گرنے کی آواز تک سے سکڑنے لگتے ہیں۔
(Even the salivary secretions of the mouth are not swallowed because of the fear of painful spasm)	☆..... یہاں تک کہ مریض حلق کے مسلز کے سکڑنے کے باعث اپنے منہ کا لعاب بھی نہیں نگل سکتا اور اس کی رال بہتی رہتی ہے۔
(History of biting of dog, coma and death)	☆..... کتے کے کانٹے کی ہسٹری، بے ہوشی اور موت واقع ہو سکتی ہے۔

پچیدگیاں (Complications):

(Coma and death may occur as complication)	☆..... اس مرض کے نتیجے میں بے ہوشی اور موت واقع ہو سکتی ہے۔
--	---

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	☆..... تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔
(Blood sugar should be estimated)	☆..... خون میں شوگر کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

(Anti-rabies vaccines are available e.g. Inj: Verorab)	☆..... اینٹی ریبیز ویکسین مثلاً انجکشن ویرورب دستیاب ہیں۔
(Properly repeated washing of bite area should be done)	☆..... کاٹی گئی جگہ کو درست طریقے سے بار بار دھوئیں۔
(Do not suture the wound)	☆..... زخم پر ٹائٹ نہ لگائیں۔
(Give some immunoglobulins / antiserum around wound)	☆..... زخم کے ارد گرد کچھ امیونوگلوبولن / اینٹی سیرم لگائیں۔

علاج (Treatment):

(As symptoms appear treatment becomes difficult)	☆..... اگر علامات ظاہر ہو جائیں تو علاج مشکل ہوتا ہے۔
(Diazepam 10mg TDS is given)	☆..... ڈایازپام 10 ملی گرام صبح، دوپہر، شام دیتے ہیں۔
(I.V. fluid may be given)	☆..... مریض کو بذریعہ وین ڈرپ لگانی چاہیے۔
(Feeding may be given through naso-gastric (N/G) tube)	☆..... مریض کو N/G ٹیوب کے ذریعے خوراک دینی چاہیے۔

☆☆☆

ٹیٹانوس ... کزاز

(TETANUS / LOCKJAW)

تعارف (Introduction): ٹیٹانوس یا جھٹکے کی بیماری نروس سسٹم اور مسلز کی ایک ایسی متعدی بیماری ہے جو کہ جلد میں کسی بھی ٹوٹ پھوٹ یا زخم کے ذریعے لاحق ہو جاتی ہے اور جس کے مہلک نتائج اس وقت سامنے آتے ہیں جب بیکٹیریا یا اپنازہر (ٹیٹانوسپازمین) خون میں شامل کر دیتا ہے۔

An acute neuro-muscular disorder characterised by convulsive tonic contraction by voluntary muscles due to any abrasion or wound in the skin & the fatal consequences of which appears when bacterial toxins (tetano spasmin) mixed in blood.

وجوہات (Causes):

(Clostridium tetani)	☆..... کلوزٹریڈیم ٹیٹانی۔
----------------------	---------------------------

دورانیہ (Incubation Period):

(5 days - 14 days)	☆..... 5 دن سے 14 دن۔
--------------------	-----------------------

اسباب (Etiology):

(Clostridium tetani, found in soil & feces of animals. It is transmitted through wound contamination)	☆..... یہ جراثیم مٹی اور جانوروں کی لید میں پایا جاتا ہے اور زخم کے ذریعے مریض کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔
---	--

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(Initially there are body pains are present)	☆..... شروعات میں مریض کے جسم اور عضلات میں درد ہوتا ہے۔
(There is rigidity of muscles of jaw (masseter))	☆..... جبڑے کے مسلز میں سختی محسوس ہوتی ہے۔
(Difficulty in mastication and opening of mouth)	☆..... منہ کھولنے اور چبانے میں مشکلات ہوتی ہیں۔
(Stiffness of sternocleidomastoid muscles in neck)	☆..... گردن کے مسلز سٹرنوکلیدیڈ و میسائڈ بھی اکڑ کر جم جاتے ہیں۔
(Difficulty in movement of mouth and neck)	☆..... گردن اور منہ کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔
(Rigidity also starts in chest and abdomen)	☆..... یہ جکڑن سینے اور پیٹ کے مسلز میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔
(Spasm of muscles causes severe pain)	☆..... مسلز کی یہ جکڑن سخت درد پیدا کرتی ہے۔

(Rigidity of respiratory muscles may cause difficulty in respiration which can lead to death)	☆..... نظام تنفس کے مسلز کی جکڑن سانس لینے میں دشواری پیدا کرتی ہے جسکے باعث مریض موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
(Stridors are present on respiration)	☆..... سانس لینے کے دوران گلے سے خرخراہٹ کی آواز آتی ہے۔
(Terminal hyperpyrexia upto 105 degree farhenhiet)	☆..... مریض کو 105 ڈگری فارن ہائیٹ تک بخار ہو جاتا ہے۔
(Spasmodic convulsions occur)	☆..... مریض کو تشنجی دورے یعنی جھٹکے پڑتے ہیں۔
(Convulsions occur even by mild stimulant)	☆..... ذرا سی آہٹ، حرکت اور روشنی سے بھی جھٹکے پڑتے ہیں۔
(Death may occur due to cardiac failure)	☆..... دل کی حرکت بند ہو جانے کے باعث موت واقع ہو جاتی ہے
(In infants tetanus occur due to umbilical wound)	☆..... نوزائیدہ میں ٹیٹانس جراثیم ناف کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں
(Rhisus sardonius and opsthotonus occur)	☆..... مریض کی شکل عجیب اور جسم کمان کی مانند اکڑ جاتا ہے۔

مپیڈگیاں (Complications):

(Death may occur as complication)	☆..... اس مرض کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے۔
(Asphyxia occurs due to respiratory muscles spasm)	☆..... مریض کو سانس میں دقت اور رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔
(Difficulty in mouth opening due to lockjaw)	☆..... جڑے کی جکڑن کے باعث مریض منہ نہیں کھول سکتا۔
(Aspiration pneumonia may occur)	☆..... مریض کو اسپائریشن پنمونیا بھی ہو سکتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	☆..... تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔
(C.T Scan to rule out neurological causes)	☆..... دماغی بیماریوں کی تشخیص کے لئے سی۔ ٹی سکین کرایا جاتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

Human tetanus Ig 500 units I.M. stat. OR	☆.....☆ ہیومن ٹیٹانس امیونوگلوبولن 500 یونٹ مسل میں لگاتے ہیں۔ یا
(Inj ATS 10,000-30,000 I.M. stat (ATD)	☆.....☆ انجکشن ATS ٹیسٹ ڈوز کے بعد مسل میں لگاتے ہیں۔
(In immunized people Tetanus toxoid I.M. stat)	☆.....☆ جنہوں نے ٹیٹانس ویکسین پہلے ہی لگائے ہوں انہیں TT دیتے ہیں۔
(To gain immunity for future, TT is given stat then after 1 month then after 1 year and then 5-10 yearly)	☆.....☆ ٹیٹانس کے خلاف امیونٹی حاصل کرنے کیلئے TT اسی وقت لگایا جاتا ہے پھر 1 مہینے پھر 1 سال پھر 5 سے 10 سال تک ہر سال لگاتے ہیں۔

علاج (Treatment):

(Proper wash of wound with disinfectant)	☆.....☆ جراثیم کش محلول سے زخم کو درست طریقے سے دھوئیں۔
(Removal of dead tissues from wound)	☆.....☆ زخم کے ارد گرد مردہ ٹشوز کو ہٹا دیں۔
(Inj Benzyl penicillin I.V (ATD)	☆.....☆ ٹیٹسٹ ڈوز کے بعد بینزائل پنسلین کا انجکشن رگ میں لگائیں۔
(Inj Diazepam TDS to relieve rigidity and convulsions)	☆.....☆ مسلز کی جکڑن اور جھٹکوں کیلئے انجکشن ڈایازپام لگاتے ہیں۔
(Avoid stimulating factors e.g. light, noise, etc)	☆.....☆ روشنی اور شور وغیرہ سے مریض کو بچائیں۔
(Keep the patient in silent and dark room)	☆.....☆ مریض کو خاموش اور اندھیرے کمرے میں رکھیں۔



چکن پاکس ... لاکڑا کا کڑا

(CHICKEN POX / VARICELLA)

تعارف (Introduction): چکن پاکس یعنی لاکڑا کا کڑا ایک شدید متعدی بیماری ہے جس میں مریض کو بخار، تھکن اور خارش والے پیپ دار، کھرنڈ والے دانے نکل آتے ہیں۔

A highly contagious disease characterised by fever, malaise and later by centripetal pruritic papular skin rash changing to vesicular, pustular and finally crusting

وجوہات (Causes):

☆.....	ویریسیلا (ہرپیز) وائرس۔	(Vericilla (Herpes) virus)
--------	-------------------------	----------------------------

دورانیہ (Incubation Period):

☆.....	10 دن سے 20 دن۔	(10 days - 20 days)
--------	-----------------	---------------------

اسباب (Etiology):

☆.....	یہ انفکشن ہوا کے ذریعے، کھانسنے، چھینکنے اور متاثرہ جلد کو چھو لینے سے لاحق ہو جاتا ہے۔	(The infection rapidly spreads through airborne droplets and from contact with infected skin)
--------	---	---

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

☆.....	عام طور پر 5 سال سے کم عمر بچے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔	(Children of aged less than 5 years are infected)
☆.....	جلد پر خاص قسم کے سرخ و جھبے نمودار ہوتے ہیں۔	(There are specific red colored skin rashes)

(Rashes first appear on chest & abdomen)	☆..... یہ دھبے سب سے پہلے سینے اور پیٹ کی جلد پر نمودار ہوتے ہیں۔
(Rashes then spread towards face & limbs)	☆..... پھر یہ دھبے چہرے اور ہاتھ پیروں کی جلد پر نمودار ہوتے ہیں
(Low grade fever in initial stage)	☆..... ابتداء میں مریض کو ہلکا سا بخار ہوتا ہے۔
(Later on eruptions filled with watery secretion)	☆..... دانوں میں شفاف سی رطوبت بھر جاتی ہے۔
(Then these eruptions filled with pus)	☆..... پھر ان دانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے۔
(Then these eruptions change to crusts)	☆..... پھر یہ دانے پختہ ہو کر کھرنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
(Skin burning and itching is present)	☆..... جلد میں جلن اور خارش ہوتی ہے۔
(These crusts slough out in 7-14 days)	☆..... پھر یہ کھرنڈ والے دانے 7 سے 14 دن میں جھڑ جاتے ہیں
(Symptoms may remain for some days then finish)	☆..... علامات کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔

پچیدگیاں (Complications):

(Secondary bacterial infection may occur)	☆..... اس مرض کیساتھ کوئی دوسرا بیکٹیریل انفکشن ہو سکتا ہے۔
(Pneumonia may occur)	☆..... اس مرض کیساتھ ساتھ نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔
(Encephalitis may occur)	☆..... اس مرض کیساتھ ساتھ دماغی نشوز کی سوزش ہو سکتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	☆..... تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

(Isolation of patient is necessary)	☆..... مریض کو دوسرے صحت مند لوگوں سے محدود رکھیں۔
(Effective control is possible through vaccination)	☆..... ویکسین کے ذریعے اس بیماری کو موثر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

علاج (Treatment):

(Anti-viral is used in severe cases)	☆..... شدید کیسز میں اینٹی وائرل ڈرگز استعمال کرائیں۔
(Anti-histamin e.g. Pheneramine, Citrizine etc)	☆..... اینٹی ہسٹامین ادویات مثلاً فینارامین، سیٹریزین وغیرہ۔
(Anti-pyretic/analgesic e.g. paracetamol, ponstan etc)	☆..... دافع درد و بخار ادویات مثلاً پیراٹامول، پونستان وغیرہ۔
(Local antiseptic wash e.g. dettol lotion, dettol soap etc)	☆..... مقامی جراثیم کش ادویات مثلاً ڈیٹول لوشن، صابن وغیرہ۔



ممپس کن پیڈے

(MUMPS / EPIDEMIC PAROTITIS)

تعارف (Introduction): ممپس یعنی کن پیڈے ایک اکیوٹ متعدی بیماری ہے جس میں مریض کے ایک یا دونوں جانب کے پیروٹڈ گلینڈز میں سوزش واقع ہو جاتی ہے اور یہ سوزش کبھی کبھار دوسرے لعابی غدود یعنی دوسرے سلائیری گلینڈز تک بھی پہنچ سکتی ہے۔

An acute contagious condition characterised by non-suppurative enlargement of one or both parotid glands and less commonly of other salivary glands.

وجوہات (Causes):

(Paramyxovirus)	☆..... پیرامایکزو وائرس۔
-----------------	--------------------------

دورانیہ (Incubation Period):

(12 - 21 days)	☆..... 12 دن سے 21 دن۔
----------------	------------------------

اسباب (Etiology):

(Infection spreads through droplet mode)	☆..... یہ انفکشن کھانسنے اور چھینکنے کے ذریعے لاحق ہوتا ہے۔
--	---

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(Virus enters through nose and mouth in the body)	☆..... یہ وائرس جسم ناک اور منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔
(Painful swelling at affected angle of jaw)	☆..... متاثرہ جڑے کی سائڈ پر درد اور سوجن ہوتی ہے۔
(Headache & mild temperature is there)	☆..... مریض کو ہلکا سر درد اور ہلکا سا بخار ہوتا ہے۔
(Difficulty in opening the mouth)	☆..... مریض کو منہ کھولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔
(Patient cannot move the mandible)	☆..... مریض جڑے کو حرکت نہیں دے سکتا۔
(Paroted glands become swell & tender)	☆..... پیروٹڈ گلینڈز پر حس اور بڑھے ہوئے ہونگے۔
(Even there is difficulty in talkings & swallowing)	☆..... حتیٰ کہ مریض کو بولنے اور نگلنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے
(As infection progresses temperature becomes high)	☆..... انفکشن کے بڑھنے کے ساتھ بخار بھی بڑھتا رہتا ہے۔
(Normally symptoms degrades after one week)	☆..... عموماً ایک ہفتے کے بعد علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
(Somtimes male pateint complains testicular pains)	☆..... بعض اوقات مرد مریض خسیوں میں درد کی شکایت کرتا ہے
(Orchitis may occur after 10 days of disease onset)	☆..... مرض کے حملے کے 10 دن بعد خسیوں میں سوزش ہو سکتی ہے
(Sometimes inability to walk due to orchitis)	☆..... بعض اوقات مریض خسیوں کی سوزش کی وجہ سے چل نہیں پاتا

پیچیدگیاں (Complications):

(Orchitis may occur)	☆..... لڑکوں میں خسیوں کی سوزش بطور پیچیدگی ہو سکتی ہے۔
(Oophritis may occur in females)	☆..... لڑکیوں میں بیضہ دانیوں کی سوزش ہو سکتی ہے۔
(Meningitis may occur)	☆..... دماغی پردوں کی سوزش ہو سکتی ہے۔
(Pancreatitis may occur)	☆..... پینکریاز یعنی لیلے کی سوزش بھی ہو سکتی ہے۔
(Permanent sterility may occur in males)	☆..... مردوں میں مستقل بانجھ پن بھی ہو سکتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔	☆.....
(Complete blood count with ESR)	خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔	☆.....
(Urine R/E)	پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Saliva culture to rule out other bacterial infection)	سلائیا کچر کیا جاتا ہے کہیں کوئی بیکٹیریل انفکشن نہ ہو۔	☆.....

روک تھام (Prevention):

(Isolation of patient is necessary)	مریض کو دوسرے صحت مند لوگوں سے محدود رکھیں۔	☆.....
(Children should be vaccinated for mumps)	بچوں کو مہمپس کے ویکسین لگوانے چاہئیں۔	☆.....
(MMR (measles, mumps, rubella) vaccines are effective)	MMR ویکسین موثر ثابت ہوتے ہیں۔	☆.....
(MMR should be injected at 12-15 months of age)	MMR ویکسین 12 سے 15 ماہ کی عمر میں لگانے چاہئیں	☆.....
(Infectivity occurs through saliva & urine)	مریض کے لعاب اور پیشاب سے یہ انفکشن پھیلتا ہے۔	☆.....

علاج (Treatment):

(Treatment is done according to symptoms)	علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Anti-pyretic/analgesic e.g. paracetamol, ponstan etc)	دافع درد بخار ادویات مثلاً پیرا سٹامول، پونسٹان وغیرہ	☆.....
(Bed rest and soft diet is advised)	مریض کو مکمل آرام اور نرم غذا کا مشورہ دیں۔	☆.....
(Prednisolone tabs are given if orchitis occur)	خصیوں کی سوجن ہونے پر پریڈنی سولون گولیاں دیں	☆.....



ٹائیفائیڈ فیور۔۔۔ تب محرقہ

(TYPHOID / ENTERIC FEVER)

تعارف (Introduction): ٹائیفائیڈ فیور یعنی تب محرقہ ایک ایکوٹ متعدی بیماری ہے جس میں مریض کو بخار درجہ بہ درجہ چڑھتا ہے جو کہ پھر آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ مریض کا پیٹ پھول جاتا ہے اور پُر حس ہو جاتا ہے۔

Enteric fever is an acute infectious disease characterised by stepladder rise of fever, returning to normal slowly, abdominal distension and tenderness.

وجوہات (Causes):

(Salmonella Typhi)	☆..... سالمونیلہ ٹائیفی۔
--------------------	--------------------------

دورانیہ (Incubation Period):

(10 - 14 days)	☆..... 10 دن سے 14 دن۔
----------------	------------------------

اسباب (Etiology):

(Infection spreads through contaminated food or drink or water or flies. Stool of the patient is also a major source of spread of infection)	☆..... یہ انفکشن خراب خوراک، پانی، مشروبات اور مکھیوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ مریض کا پاخانہ بھی یہ انفکشن پھیلانے کا سبب ہے۔
--	---

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(High grade and continuous fever)	☆..... مریض کو مستقل اور ہائی ٹیپر کیجھ ہوتا ہے۔
(The fever is usually more than 101 degree Fahrenheit)	☆..... عام طور پر یہ بخار 101 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے۔
(Fever is low in morning increases to high limit at evening)	☆..... صبح ہلکا بخار ہوتا ہے جو شام تک تیز ہو جاتا ہے۔
(Body aches, headache and myalgia is there)	☆..... جسم میں درد، سردرد اور مسکولر درد ہوتے ہیں۔
(There is sore throat and mild cough)	☆..... مریض کا گلہ دکھتا ہے اور ہلکی ہلکی کھانسی ہوتی ہے۔

(Anorexia, nausea, vomiting, diarrhoea or constipation)	☆..... بھوک نہیں لگتی، متلی، الٹی، دست یا قبض ہوتا ہے۔
(Spleen and liver may be enlarged)	☆..... تلی اور جگر بڑھ جاتے ہیں۔
(Macula roseola (skin rose spots) on chest or abdomen)	☆..... سینے، پیٹ پر گلاب جیسے سرخ دھبے نکل آتے ہیں۔
(White coated tongue is there)	☆..... مریض کی زبان مٹلی ہوتی ہے۔
(Abdomen becomes tender)	☆..... پیٹ پر حس ہو جاتا ہے۔

پچیدگیاں (Complications):

(Relapse of fever takes place if not treated properly)	☆..... اگر علاج درست طور پر نہ کیا جائے تو بخار دوبارہ آ جاتا ہے۔
(Intestinal haemorrhage may take place)	☆..... آنتوں سے جریان خون بھی ہو سکتا ہے۔
(Intestinal perforation may take place)	☆..... آنتوں میں سوراخ بھی ہو سکتے ہیں۔
(Hepatitis may occur)	☆..... جگر کی سوزش بھی ہو سکتی ہے۔
(Cholecystitis may occur)	☆..... پتے کی سوزش بھی ہو سکتی ہے۔
(Pneumonia may occur)	☆..... مریض کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔
(Meningitis may occur)	☆..... دماغی پردوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے۔
(Myocarditis may occur)	☆..... دل کے مسلز کی سوزش بھی ہو سکتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	☆..... تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(Widal's test or Typhidot test is advised)	☆..... ویدال ٹیسٹ یا ٹائفائیڈ ڈاٹ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔
(Blood or stool culture tests are advised)	☆..... خون یا پاخانہ کا کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

(Isolation of patient is necessary)	☆..... مریض کو دوسرے صحت مند لوگوں سے محدود رکھیں۔
(Adequate disposal of sewage & supply of pure water)	☆..... گندگی کو درست طور پر ٹھکانے لگانا اور صاف پانی کا ہونا۔
(Environment should be free from flies)	☆..... مکھیوں سے پاک ماحول میں رہنا۔
(Improvement of personal hygiene)	☆..... صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
(Active immunisation with typhoid vaccine)	☆..... ٹائیفائیڈ کے ویکسین لگوانے چاہئیں۔
(The biliary careers may need chole cystectomy)	☆..... پتے میں ٹائیفائیڈ جراثیم کی صورت میں آپریشن کروائیں
(Typhoid patient should not handle food items)	☆..... ٹائیفائیڈ کے مریض کھانے پینے کی اشیاء نہ چھوئیں۔

علاج (Treatment):

(Treatment is done according to symptoms)	☆..... علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔
(Anti-pyretic/analgesic e.g. paracetamol, ponstan etc)	☆..... دافع درد، بخار ادویات مثلاً پیراٹامول، پونستان وغیرہ۔
(Bed rest and soft diet is advised)	☆..... مریض کو مکمل آرام اور نرم غذا کا مشورہ دیں۔
(Anti-biotics e.g. Levofloxacin, Amoxil, Cefixime etc)	☆..... اینٹی بائیوٹکس مثلاً لیووفلاکساسن، ایماکسل، سفیکسیمز ائم۔



بیسلری ڈائسنٹری۔۔۔ جراثیمی پیچش

(BACILLARY DYSENTERY / SHIGELLOSIS)

تعارف (Introduction): بیسلری ڈائسنٹری یعنی جراثیمی پیچش آنتوں کا ایک ایسا ایکیوٹ انفکشن ہے جس میں مریض کو زبردست ڈائریا کے ساتھ خون اور بلغم آتا ہے۔

An acute infection of the intestinal tract causing severe diarrhoea with blood & mucous.

وجوہات (Causes):

(Shigella)	☆..... شائگیلا۔
------------	-----------------

دورانیہ (Incubation Period):

(1 - 6 days)	☆..... 1 دن سے 6 دن۔
--------------	----------------------

اسباب (Etiology):

(Infection spreads through contaminated food or drink or water or flies. Stool of the patient is also a major source of spread of infection)	☆..... یہ انفکشن خراب خوراک، پانی، مشروبات اور مکھیوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ مریض کا پاخانہ بھی یہ انفکشن پھیلانے کا سبب ہے۔
--	---

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(Germs reach to colon by contaminated food or water)	☆..... جراثیم خراب خوراک یا پانی سے بڑی آنت تک پہنچتے ہیں۔
(Ulcers may develop in the colon due to infection)	☆..... انفکشن کی وجہ سے آنت میں زخم بن سکتے ہیں۔
(Bacteria may infect deep tissues of colon)	☆..... یہ بیکٹیریا آنتوں میں گہرائی تک انفکشن کر سکتے ہیں۔
(In chronic cases colon may perforate)	☆..... پیچش اگر پرانی ہو جائے تو آنت میں سوراخ ہو سکتے ہیں۔
(Patient frequently passes small amount of stool)	☆..... مریض کئی مرتبہ تھوڑا تھوڑا سا نرم پاخانہ کرتا ہے۔

(Stool contain mucous due to inflammation in colon)	☆..... آنت میں سوزش کے باعث پاخانہ میں میو کس ہوتا ہے۔
(Stool contain blood due to ulcers in colon)	☆..... آنت میں زخم کے باعث پاخانہ خون ملا ہوتا ہے۔
(Intestinal peristaltic movements become rapid)	☆..... آنتوں کی حرکات بڑھ جاتی ہیں۔
(Stool may contain pus in developed cases)	☆..... شدید کیسوں میں پیپ دار پاخانہ آتا ہے۔
(Abdominal pain is there)	☆..... مریض کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے۔
(Fever may develop due to intestinal infection)	☆..... آنت کے انفکشن کے باعث مریض کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔
(There is pain during passing stool (tenesmus))	☆..... پاخانہ کرتے ہوئے پیٹ میں مروڑاٹھتا ہے۔
(There may be nausea and vomiting in severe cases)	☆..... شدید کیسوں میں مریض کو متلی اور الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔
(Tenderness in abdomen)	☆..... معائنے کے دوران مریض کا پیٹ پر حس ہوگا۔
(Discomfort in abdomen)	☆..... مریض کو پیٹ میں بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔
(Frequency of stool in small amounts)	☆..... مریض کو تھوڑا تھوڑا پاخانہ بار بار آتا ہے۔

تبعید گیاں (Complications):

(Acute dysentery may convert to chronic dysentery)	☆..... ایکیوٹ انفکشن، کرائمک انفکشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔
(Dehydration may occur)	☆..... جسم میں پانی کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔
(Electrolytes imbalance may happen)	☆..... جسم میں نمکیات غیر متوازن ہو سکتے ہیں۔
(Intestinal perforation may occur)	☆..... آنتوں میں زخم بھی ہو سکتے ہیں۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔	☆.....
(Complete blood count with ESR & Urine R/E)	خون اور پیشاب کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔	☆.....
(Identification of shigella in stool culture)	سٹول کلچر میں شائگیلا جراثیم کو دیکھا جاسکتا ہے۔	☆.....
(Sigmoidoscopy may be done if needed)	اگر ضرورت پڑے تو سگمائیڈوسکوپ بھی کی جاسکتی ہے۔	☆.....
(Abdominal ultrasound)	اگر ضرورت پڑے تو پیٹ کا الٹراساؤنڈ بھی کیا جاسکتا ہے۔	☆.....

روک تھام (Prevention):

(Isolation of patient is necessary)	مریض کو دوسرے صحت مند لوگوں سے محدود رکھیں۔	☆.....
(Adequate disposal of sewage & supply of pure water)	گندگی کو درست طور پر ٹھکانے لگانا اور صاف پانی کا ہونا۔	☆.....
(Environment should be free from flies)	کمکیوں سے پاک ماحول میں رہنا۔	☆.....
(Improvement of personal hygiene)	صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔	☆.....
(Protection of food and drinks from contamination)	خوراک اور پینے والی اشیاء کو خراب ہونے سے بچائیں۔	☆.....
(Patient should not handle food items)	مریض کھانے پینے کی اشیاء نہ چھوئیں۔	☆.....

علاج (Treatment):

(Treatment is done according to symptoms)	علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Anti-pyretic/analgesic e.g. paracetamol, ponstan etc)	دافع درد و بخار ادویات مثلاً پیراٹامول، پونستان وغیرہ۔	☆.....
(Bed rest and soft diet is advised)	مریض کو مکمل آرام اور نرم غذا کا مشورہ دیں۔	☆.....
(Anti-biotics e.g. Levofloxacin, Septran, Cefixime etc)	اینٹی بائیوٹکس مثلاً لیووفلاکساسن، سپٹران، سیفیکسیمز ائم۔	☆.....
(Therapy must be given at least for 5 days)	علاج کم از کم 5 دن تک تو ضرور جاری رکھنا چاہیے۔	☆.....



فوڈ پوائزننگ (خوراک کی جراثیمیت) (FOOD POISONING)

تعارف (Introduction): کھائی جانے والی خوراک میں اگر جراثیموں کے زہریات موجود ہوں اور یہ جسم کو بیمار کر دیں تو ایسی حالت کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔

The disease caused by toxins present in consumed (ingested) food is called food poisoning.

وجوہات (Causes):

(Staph: Aureus, Salmonella, Bacillus cereus, Clostridium etc)	☆..... سٹیفو لو کوکس آریس ، سالمونیلہ ، میسی لس سیریس ، کلاسٹریڈیم جراثیموں وغیرہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔
---	---

دورانیہ (Incubation Period):

(Less than 7 hours)	☆..... 7 گھنٹے سے کم وقت۔
---------------------	---------------------------

اسباب (Etiology):

(Infection may develop by ingestion of contaminated food and drink)	☆..... یہ انفلکشن خراب خوراک اور پانی کے باعث لگتا ہے۔
---	--

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(There is abdominal pain)	☆..... مریض کو پیٹ درد محسوس ہوتا ہے۔
(Feeling of nausea sensations)	☆..... مریض کا دل خراب ہوتا ہے اور متلی محسوس ہوتی ہے۔
(There is vomiting in developed cases)	☆..... مریض کو الٹیاں بھی آتی ہیں۔
(These complains start after ingestion of specific food)	☆..... ایسی شکایات خاص قسم کا کھانا کھانے سے ہوتی ہیں۔

(Usually many members of the family are affected)	☆..... عام طور پر ایک ہی خاندان کے کئی افراد متاثر ہوتے ہیں۔
(Severe diarrhoea is there)	☆..... مریض کو بہت زیادہ موٹن آتے ہیں۔
(Generalised weakness takes place)	☆..... عام جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔
(Headache along with nausea & vomiting)	☆..... متلی اور قے کے ساتھ سر درد بھی ہوتا ہے۔
(In severe cases pulse becomes slow)	☆..... شدید کیسوں میں نبض ہلکی چلتی ہے۔
(Blood pressure falls in well developed cases)	☆..... شدید کیسوں میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔
(Cold and clammy hands and feet)	☆..... مریض کے ہاتھ، پاؤں اور جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔
(Imbalancy in serum electrolytes)	☆..... جسم میں نمکیات غیر متوازن ہو جاتے ہیں۔
(Dehydration may occur in severe cases)	☆..... شدید کیسوں میں مریض کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔
(Patient becomes toxic)	☆..... مریض بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔

پچیدگیاں (Complications):

(Dehydration may occur)	☆..... جسم میں پانی کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔
(Electrolytes imbalancy may happen)	☆..... جسم میں نمکیات غیر متوازن ہو سکتے ہیں۔
(Hypovolaemic shock may occur)	☆..... مریض صدمے کی حالت میں بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Usually made on clinical features)	☆..... تشخیص عام طور پر کلینیکل علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(Serum electrolytes may be done)	☆..... خون میں نمکیات کا ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔
(Blood sugar estimation in severe weakness)	☆..... زیادہ کمزوری کی صورت میں خون میں شوگر ٹیسٹ کروائیں۔
(Abdominal ultrasound)	☆..... اگر ضرورت پڑے تو پیٹ کا الٹراساؤنڈ بھی کیا جاسکتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

(Isolation of patient is necessary)	☆..... مریض کو دوسرے صحت مند لوگوں سے محدود رکھیں۔
(Adequate disposal of sewage & supply of pure water)	☆..... گندگی کو درست طور پر ٹھکانے لگانا اور صاف پانی کا ہونا۔
(Environment should be free from flies)	☆..... مکھیوں سے پاک ماحول میں رہنا۔
(Improvement of personal hygiene)	☆..... صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
(Protection of food and drinks from contamination)	☆..... خوراک اور پینے والی اشیاء کو خراب ہونے سے بچائیں۔
(Food should be stored below 4 degree centigrade)	☆..... خوراک کی اشیاء 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ پر رکھیں۔

علاج (Treatment):

(Treatment is done according to symptoms)	☆..... علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔
(Anti-microbial e.g. metronidazole, entamizole etc)	☆..... اینٹی مائکروبیئل ڈرگز مثلاً میٹرونیڈازول، اینٹامیزول وغیرہ۔
(Bed rest and soft diet is advised)	☆..... مریض کو مکمل آرام اور نرم غذا کا مشورہ دیں۔
(Anti-biotics e.g. Levofloxacin, Septran, Cefixime etc)	☆..... اینٹی بائیوٹکس مثلاً لیو فلوکساسن، سپٹران، سیفیکسیم وغیرہ۔
(I.V. drip if dehydration occur)	☆..... پانی کی کمی صورت میں ڈرپ ہڈریریوین دینی چاہیے۔



پھیپھڑوں کی تپ دق

(PULMONARY TUBERCULOSIS)

تعارف (Introduction): پھیپھڑوں کی ٹی بی ایک متعدی بیماری ہے جس میں پھیپھڑے ٹی بی کے جراثیموں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور مریض کا وزن انتہائی کم ہو جاتا ہے۔

An infectious pulmonary condition characterized by the formation of tubercles in the lungs and loss of weight.

وجوہات (Causes):

(Mycobacterium tuberculosis is causative organism for this disease)	☆..... اس بیماری کا ذمہ دار جراثیم مائیکوبیکٹیریم ٹیوبریکولوسس ہے۔
(The disease spreads through droplet mode)	☆..... یہ بیماری کھانسنے، چھینکنے اور سانس کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔
(Malnutrition, general debility & certain diseases may act as predisposing factors)	☆..... خوراک کی کمی، عام جسمانی کمزوری اور کچھ دوسری بیماریاں ٹی بی کے مرض کو جسم پر حملہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔

علامات و نشانی (Signs & Symptoms):

(Symptoms are slow in onset)	☆..... اس بیماری کی علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔
(Cough)	☆..... مریض کو کھانسی ہوتی ہے۔
(Low grade fever)	☆..... مریض کو ہلکا سا بخار ہوتا ہے۔
(Evening rise of temperature)	☆..... یہ بخار شام کو بڑھا کرتا ہے۔
(Night sweats)	☆..... مریض کو رات کے وقت پسینے آتے ہیں۔
(Initially the cough is dry)	☆..... ابتداء میں خشک سی کھانسی ہوا کرتی ہے۔
(Later on it becomes productive)	☆..... جو بعد میں بلغمی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
(Purulent sputum)	☆..... زنگ آلود سا بلغم کھانسی میں خارج ہوا کرتا ہے۔
(Haemoptysis due to rupture in small blood vessels in lungs)	☆..... پھیپھڑوں کی رگیں پھٹنے سے خون ملا بلغم آتا ہے۔

(Massive haemorrhage may occur)	☆..... یہ خون بہت زیادہ مقدار میں بھی آ سکتا ہے۔
(Cavitation in the lungs)	☆..... پھیپھڑوں میں سوراخ سے بن جاتے ہیں۔
(Cavitation first appears in one lung)	☆..... پہلے ایک پھیپھڑے میں سوراخ ہوتے ہیں۔
(Then involvement of second lung takes place)	☆..... پھر دوسرے پھیپھڑے میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔
(As the disease advances, lung is destroyed)	☆..... مرض بڑھنے سے متاثرہ پھیپھڑا تباہ ہو جاتا ہے۔
(Pleural effusion)	☆..... پھیپھڑوں کی جھلی میں پانی پڑ جاتا ہے۔
(Collapse of lung)	☆..... متاثرہ پھیپھڑا چپک سا جاتا ہے۔
(Pleurisy)	☆..... پھیپھڑوں کی جھلی میں سوزش واقع ہو جاتی ہے۔
(Pneumothorax)	☆..... پھیپھڑوں کی جھلی میں ہوا بھر جاتی ہے۔
(Exertional dyspnoea)	☆..... ذرا سے کام کرنے پر سانس پھول جاتی ہے۔
(Anorexia/Loss of weight)	☆..... بھوک نہیں لگتی اور مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے۔
(General weakness/Anaemia)	☆..... خون کی کمی اور عام جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔
(Painless lymphadenitis may occur)	☆..... متعلقہ لیف نوڈز بغیر درد کے بڑھ جاتے ہیں۔

پچیدگیاں (Complications):

(Extra pulmonary tuberculosis)	☆..... پھیپھڑوں کے علاوہ بھی ٹی بی ہو سکتی ہے۔
(Cervical lymphadenitis)	☆..... گردن کے ارد گرد لیف نوڈز بڑھ سکتے ہیں۔
(Tuberculous meningitis)	☆..... دماغی پردوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔
(Miliary T.B)	☆..... یہ مرض ملیرئی ٹی بی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔
(Cor-pulmonale)	☆..... پھیپھڑوں کی وجہ سے دل کا متاثر ہونا۔
(Pleurisy)	☆..... پھیپھڑوں کی جھلی میں پانی پڑ سکتا ہے اور سوزش ہو سکتی ہے۔
(Pneumothorax)	☆..... پھیپھڑوں کی جھلی میں ہوا بھر جاتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(Sputum for A.F.B (Acid Fast Bacilli)	☆..... ٹی بی کی تشخیص کے لئے بلغم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(Sputum culture)	☆..... بلغم کا کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ای۔ ایس۔ آر کرایا جاتا ہے۔
(X-Ray chest P.A.view)	☆..... سینے کا ایکسرے کیا جاتا ہے۔
(Montoux test (Tuberculin Test))	☆..... مانتا کس ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔
(Blood Mycodot / I.C.T. Tuberculosis)	☆..... خون کا مائیکوڈاٹ / آئی، سی، ٹی، ٹیو برکیو لوسسٹیسٹ کیا جاتا ہے

روک تھام (Prevention):

(BCG (Bacilli, Calmette, Guerin) vaccine must be given)	☆..... بی، سی، جی ویکسین دینی چاہیے۔
(Prevent infected individual to develop active disease)	☆..... متاثرہ شخص کی بیماری کو مزید بڑھنے سے روکنا چاہیے۔
(Isolation of patient is necessary)	☆..... مریض کو محدود رکھنا چاہیے۔
(Do not contact with the articles and sputum of patient)	☆..... مریض کی استعمال شدہ اشیاء اور بلغم سے دور رہیں۔
(Educate the people about tuberculosis)	☆..... لوگوں کو ٹی بی کے متعلق آگاہی دینی چاہیے۔
(Properly disposal of the sputum of patient is necessary)	☆..... مریض کے بلغم کو درست طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔
(Watch out properly about intake of ATT)	☆..... مریض کے میڈیسن لینے کو نظر میں رکھیں۔

علاج (Treatment):

(Good nutrition is advised)	☆..... مریض کو بہتر خوراک کا مشورہ دیں۔
(Improvement in standard of life)	☆..... معیار زندگی کو بہتر بنائیں۔

(INH+Rifampicin+Ethambutol+Pyrazinamide combination is recommended for first two months e.g. Myrin-P tab)	☆..... آئی سونیازید + ریفامپاسین + ایتھامبوٹال + پایرازینا مائیڈ ملا کر پہلے دو ماہ کے لیے دیں۔
(Combination of INH + Rifampicin is recommended for further seven months e.g. Rimactazid tab 300mg)	☆..... آئی سونیازید + ریفامپاسین اگلے سات ماہ کے لیے دی جاتی ہے مثلاً ریماکٹازید 300 ملی گرام۔
(Vitamin B6 (Pyridoxine) 1 tablet daily is advised)	☆..... وٹامن بی 6 کی ایک گولی روزانہ دیں۔
(Multivitamins for improvement of health e.g. B-Complex)	☆..... صحت برقرار رکھنے کے لیے ملٹی وٹامن دیں۔
(Cough expectorants are given e.g. hydrillin syrup)	☆..... مخرج بلغم مثلاً ہائیڈرالین شربت دیں۔
(Anti biotics are also advised if needed e.g. Vibramycin)	☆..... بوقت ضرورت اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔



پولیو میلائی ٹس (POLIOMYELITIS)

تعارف (Introduction): یہ وائرل انفیکشن ہے جو پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ایک نان این ویلوپڈ آراین اے وائرس ہے۔ تقریباً نوے سے پچانوے فیصد شکار افراد میں کوئی علامات نہیں ہوتیں جبکہ ایک سے پانچ فیصد مریضوں میں متاثرہ ٹانگ فالج ہو کر سکڑ سکتی ہے۔

It is a viral infection caused by Polio-Virus which is a Non-enveloped RNA containing virus. About 90 - 95% victims remain asymptomatic about 01 - 05% get paralysis of the lower limb.

متنقل (Transmission):

(Oro - Fecal Route)	☆..... یہ جراثیم پاخانے اور منہ کے ذریعے پھیلتے ہیں۔
---------------------	--

دورانیہ (Incubation Period):

(3 days to 6 days)	☆..... 3 دن سے 6 دن۔
--------------------	----------------------

علامات و نشانات (Signs & Symptoms):

(Muscle weakness)	☆..... پٹھوں کی کمزوری۔
(Headache)	☆..... سردرد۔
(Stiffness of neck)	☆..... گردن کا اکڑ جانا۔
(Fever)	☆..... بخار۔
(Nausea / vomiting)	☆..... متلی اور قے۔
(Diarrhea)	☆..... اسہال۔
(Sore throat)	☆..... گلے کی سوزش۔
(Lower motor neuron lesion)	☆..... نچلے موٹر نیوران کی خرابی۔
(Muscles wasting)	☆..... پٹھوں کا سکڑ جانا۔

پولیومیلائٹس کی اقسام (Types Of Polimyelitis):

(Abortive poliomyelitis)	1 ناکام پولیو (یہ قسم بہت معمولی قسم کی بیماری ہے)۔
(Non paralytic poliomyelitis)	2 غیر مفلوج پولیو۔
(Paralytic poliomyelitis)	3 فالجی پولیو۔

تشخیص (Diagnosis):

(Mostly clinically on history)	☆..... کلینیکل ہسٹری سی تشخیص ہو جاتی ہے۔
(Feces culture)	☆..... پاخانے کا کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(Throat secretion culture)	☆..... گلے کے لعاب کا کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

(CSF shows excess lymphocytes)	☆..... سیربروسپائل فلوئیڈ میں لمفوسائٹس کی زیادتی۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے۔
(Blood culture)	☆..... خون کا کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

روک تھام (Prevention):

(Specific immunization)	☆..... مخصوص حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔
(Polio-Vaccine) OPV.)	☆..... پولیو ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔

پیچیدگیاں (Complications):

(Gastric distension)	☆..... پیٹ کا پھولنا۔
(Gastric Haemorrhage)	☆..... معدے کا جریان خون۔
(Bladder Atony)	☆..... مثانے کا فالج۔

علاج (Treatment):

(Analgesics for pain)	☆..... درد سے آرام پہنچانے والی ادویات دیتے ہیں۔
(Sedatives for muscles spasm)	☆..... پٹھوں کی کڑن کیلئے سکون آور ادویات دیتے ہیں۔
(Sedatives for muscular rigidity)	☆..... پٹھوں کے کچھاؤ کیلئے سکون آور ادویات دیتے ہیں۔
(Complete bed rest)	☆..... مکمل آرام کرنا چاہیے۔
(Good diet)	☆..... اچھی غذائینی چاہیے۔
(Physiotherapy)	☆..... مساج/ہالاش کروانا چاہیے۔
(Exercise therapy)	☆..... ورزش کرنا چاہیے۔



برڈ فلو

(اے وین انفلوئنزا)

(BIRD FLUE)

تعارف (Introduction): عام طور پر اس بیماری کو اے ویون زکام کہتے ہیں یہ ایک وائرل متعددی بیماری ہے جو زیادہ تر پرندوں کو متاثر کرتی ہے جبکہ ان میں موجود وائرس انسانوں میں بیماری پھیلاتے ہیں۔

It is commonly called Avian Influenza. It is a viral infectious disease that infects mostly birds. While the virus like A(H5 N1) and A(H7N9) causes disease in humans.

وجوہات (Causes):

(Exposure to infected birds)	☆..... متاثرہ پرندوں کو ہاتھ لگانا یا قریب جانا۔
(Exposure to contaminated environment)	☆..... آلودہ ماحول۔
(Cold weather/Air)	☆..... سرد موسم / سرد ہوا۔

دورانیہ (Incubation Period):

(02 - 17 days)	☆..... 2 سے 17 دن۔
----------------	--------------------

بیماری کی منتقلی (Transmission): یہ بیماری مردہ پولٹری یا زندہ پرندوں سے براہ راست یا بلواسطہ رابطے سے پھیلتی ہے اور اسی سے اس بیماری کی منتقلی منسلک ہے اس بیماری میں موت کی شرح انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔

The disease transmission is associated with direct or indirect contact with infected live or dead poultry. The disease has high mortality rate.

علامات و نشانات (Signs & Symptoms):

(High graded fever (103 F)	☆..... بہت تیز بخار کا ہونا (103 فارن ہائیٹ)۔
(Cough with sputum)	☆..... بلغم والی کھانسی۔
(Sore throat)	☆..... گلے کا خراب ہونا۔
(Sneezing)	☆..... چھینکیں آنا۔
(Diarrhea)	☆..... اسہال / دست۔

(Nausea / Vomiting)	متلی / الٹی کا آنا۔	☆.....
(Abdominal pain)	پیٹ کا درد۔	☆.....
(Chest pain)	سینے میں درد کا اٹھنا۔	☆.....
(Bleeding from nose)	ناک سے خون بہنا۔	☆.....
(Respiratory distress)	سانس کی تکلیف۔	☆.....

برڈ فلو کی روک تھام (Prevention Of Bird Flue):

(Wash your hands regularly, particularly after going to the toilet and before handling food)	اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں خصوصاً پاخانہ کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے۔	☆.....
(Turn away from other people & cover your mouth with tissue when you coughing or sneezing)	کھانسی اور چھینکنے کے دوران دوسرے لوگوں سے منہ موڑ لیں اور ٹشو پیپر کا استعمال کریں۔	☆.....
(Dispose off tissue immediately after use and wash your hands with soap and warm water)	ٹشو استعمال کرنے کے فوراً بعد ضائع کر دیں اور صاف و گرم پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں۔	☆.....
(Avoid public places if you are ill)	اگر آپ بیمار ہیں تو عوامی مقامات سے گریز کریں۔	☆.....
(Good health mentainenance)	اچھی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے۔	☆.....
(Seasonal flu vaccine)	موسمی زکام کا ویکسین لگانا چاہیے۔	☆.....

تشخیص (Diagnosis):

(Based on history / clinical exam)	طبعی معائنہ / کلینیکل ہسٹری۔	☆.....
(Chest x-ray)	چھاتی کا ایکس رے۔	☆.....
(Nose and throat smear culture)	ناک اور گلے کے لعاب کا کلچر ٹیسٹ۔	☆.....
(Blood culture)	بلڈ کلچر ٹیسٹ۔	☆.....
(C.B.C with E.S.R)	خون کا مکمل معائنہ۔	☆.....

علاج (Treatment):

(Rest)	☆..... آرام کرنا۔
(Drink plenty of fluids)	☆..... پانی اور فلوئیڈز زیادہ سے زیادہ پینا۔
(Eating healthy stuffs (food).	☆..... صحت مند غذا کھانا۔
(Analgesic/Antipyretic med: e.g; Paracetamol / Aspirin)	☆..... بخار اور درد کیلئے دوا جیسے اسپرین اور پیرا سٹامول۔
(Antiviral medications e.g;)	☆..... اینٹی وائرل دوائیں مثلاً؛
(Oseltamivir (Tamiflu)	☆..... اوسیلٹامی ویر (ٹیمی فلو)۔
(Zanamivir (Relenza)	☆..... زینامی ویر (ری لینزا)۔
(Paramivir (Act rapid)	☆..... پیرامی ویر (ایکٹ رپڈ)۔
(Pneumonia needs antibiotics)	☆..... نمونیا جیسی بیماری کا اینٹی بائیوٹک سے علاج کریں۔



ڈینگی بخار (DENGUE FEVER)

تعارف (Introduction): یہ ایک ایکیوٹ وائرل انفیکشن والی بیماری ہے جو کہ ایک خاص قسم کے ایڈس مچھر کے ذریعے فلیوی وائرس سے پھیلتی ہے۔ اس میں مریض کو سر درد، بخار، جوڑوں کی تیز دردیں ہوتی ہیں ورجم پر خاص قسم کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس بخار کو ہڈی توڑ بخار بھی کہتے ہیں۔

It is an acute infectious disease caused by a flavivirus (species Dengue virus of the genus Flavivirus), transmitted by aedes mosquitoes, characterized by headache, fever, severe joint pains and rashes on body. It is also called breakbone fever.

متنقل (Transmission):

(Through mosquitoes)	☆..... ڈینگلی کی منتقلی مچھروں کے ذریعے ہوتی ہے۔
----------------------	--

دورانیہ (Incubation Period):

(3-15 days)	☆..... تین سے پندرہ دن۔
-------------	-------------------------

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(Sudden onset of high fever)	☆..... اچانک تیز بخار ہونا۔
(Chilliness)	☆..... سردی کا لگنا۔
(Sever headache)	☆..... تیز سردرد۔
(Backache)	☆..... کمر میں شدید درد۔
(Extremities pains)	☆..... ہاتھ پیروں میں درد۔
(Sore throat)	☆..... گلے میں سوزش۔
(Prostration)	☆..... جسمانی تھکن ہونا۔
(Depression)	☆..... اعصاب پر دباؤ پڑنا۔
(Conjunctivital redness)	☆..... آشوب چشم ہونا۔
(Flushing of the skin)	☆..... جلد پر سرخ دانے سے نکل آنا۔
(Febrile phase lasts 3 - 4 days)	☆..... بخار کی مدت تین چار دن ہوتی ہے۔
(Eruption appearin 80% cases)	☆..... 80 فیصد لوگوں میں جلد پر دھبے نمودار ہونا۔
(Bleeding from nose, gums etc)	☆..... ناک مسوڑوں وغیرہ سے خون بہنا۔
(Internal bleeding in GIT)	☆..... نظام انہظام کے راستوں میں بلیڈنگ ہونا۔
(Bleeding in Urinary tract)	☆..... پیشاب کے نظم میں بلیڈنگ ہونا۔

تشخیص (Diagnosis):

(Blood for Danguue Antibodies)	☆..... خون میں اینٹی ہاڈیز کا ٹیسٹ۔
--------------------------------	-------------------------------------

(CBC shows low platelets count)	☆..... خون میں پلیٹ لیٹس کم ہونا۔
(CBC shows low WBCs count)	☆..... خون میں سفید ذرات کم ہونا۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا ٹیسٹ۔
(Other relevant tests)	☆..... دوسرے متعلقہ ٹیسٹ کریں۔

روک تھام (Prevention):

(Prophylactic measurements)	☆..... حفاظتی اقدامات کریں۔
(Screening)	☆..... ڈیٹنگ کا سکریننگ ٹیسٹ کروائیں۔
(DDT/BHC spray)	☆..... ڈی ڈی ٹی / بی ایچ سی سپرے کریں۔
(Mosquitoes repellent sprays)	☆..... مچھر بھگانے والے سپرے کریں۔
(Use mosquito nets)	☆..... مچھر وائیاں استعمال کریں۔
(Indoor sleeping)	☆..... اندر کمروں میں سوئیں۔

پچیدگیاں (Complications):

(Bleeding)	☆..... خون آنا۔
(Bone Marrow Failure)	☆..... ہون میروکا فیل ہو جانا۔
(Shock)	☆..... شاک یعنی صدمے کی کیفیت میں چلے جانا۔
(Death)	☆..... مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

علاج (Treatment): علامتی علاج کیا جاتا ہے اس میں درد اور بخار کے لئے پیراٹامول دی جاتی ہے یا درکھیں کہ مریض کو کسی صورت اسپرین استعمال نہ کروائیں۔ پلیٹ لیٹس کا کاؤنٹ کرنا چاہیے اور اگر اس کی تعداد خون میں کم ہو تو پلیٹ لیٹس ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر بذریعہ وریڈ فلونڈ دے سکتے ہیں۔

It is symptomatic paracetamol for pain and fever, remember that aspirin should not be used in this case. Platelets monitoring is needed if platelets count is low then blood (or platelets) transfusion is needed. I/V fluids may be given if needed.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

یونٹ: 24

جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں

(SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES)

تعارف (Introduction): وہ بیماریاں جو جنسی ملاپ کے باعث لاحق ہوں جنسی ذریعے سے پھیلنے والی بیماریاں کہلاتی ہیں مثلاً ایڈز، گنوریا یعنی سوزاک اور سفلس یعنی آتشک وغیرہ۔ پہلے پہل جنسی طور پر منتقل ہونے والی ان بیماریوں کو وی نیریل ڈیزیزز کہتے تھے۔

Diseases transmitted by sexual intercourse are called sexual transmitted diseases e.g. AIDS, Gonorrhoea, Syphilis etc. Formerly these diseases were termed as Venereal diseases.

(ایڈز)

(ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME - AIDS)

تعارف (Introduction): ایڈز سے مراد ایک وائرل امیونو ڈیفی شینسی سائنڈروم یعنی حاصل شدہ طریقے سے جسم کی قوت مدافعت کم ہو جانے کی صورت میں بہت سے علامات کا اظہار ہے۔ یہ مرض عموماً مہلک ہوتا ہے۔ اس مرض میں خلیاتی قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، مریض کے جسم کے لیفٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں اور جسم پر مختلف معمولی معمولی انفکشنز بھی حملہ کر دیتے ہیں۔

An acquired symptom complex, frequently fatal, associated with a defect in cell-mediated immunity & characterised by persistent unexplained lymphadenopathy & opportunistic infections.

اسباب (Causative Organisms):

(Human Immunodeficiency Virus (HIV)

☆..... ایچ۔ آئی۔ وی۔

پھیلنے کا طریقہ کار (Mode Of Spread):

(Transfusion of contaminated blood)	ایڈز سے متاثرہ خون کے ٹرانسفیوژن سے یہ مرض پھیلتا ہے۔	☆.....
(Prick by a contaminated syringe)	ایڈز سے متاثرہ مریض کی سرنج استعمال کرنے سے یہ مرض پھیلتا ہے	☆.....
(Contaminated surgical utensils)	ایڈز سے متاثرہ سرجیکل آلات کے استعمال سے یہ مرض پھیلتا ہے	☆.....
(By sexual contact)	نا جائز جنسی میل جول بھی ایڈز کا مرض پھیلا سکتی ہے۔	☆.....
(Through breast feeding)	ایڈز سے متاثرہ مریضہ کا دودھ یہ مرض شیرخواروں تک پہنچا سکتا ہے	☆.....
(From infected mother to fetus)	ایڈز کی مریضہ ماں سے یہ مرض پیٹ میں موجود بچے کو لاحق ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Spreads by contaminated tooth brush, razor)	ایڈز کے مریض کا ٹوتھ برش، شیوینگ بلیڈ وغیرہ استعمال کرنے سے	☆.....

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):

(HIV infection may be symptom free for long time)	ہو سکتا ہے ایڈز کی علامات لمبے عرصے تک ظاہر نہ ہوں۔	☆.....
(Incubation period may be prolonged upto 10 years)	ایڈز کا انکیوبیشن پیریڈ 10 سال تک بھی ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Symptom free patient can spread AIDS)	جس مریض میں علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں یہ مرض پھیلا سکتا ہے	☆.....
(Initially rhinorrhoea may occur)	ابتدا میں مریض کو معمولی نزلہ زکام سا ہوتا ہے۔	☆.....
(Fatigue, malaise, weight loss occur)	ذرا سا کام کرنے پر تھکن، کام کے بغیر تھکن، وزن کم ہوتا ہے	☆.....
(Fever, body aches, enlarged lymph nodes)	بخار، جسم میں دکھن ہوتی ہے اور لیف نوڈز بڑھ جاتے ہیں۔	☆.....
(Initially treatment gives response)	شروعات میں علاج سے مریض فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔	☆.....
(Later on treatment gives slow / no response)	لیکن بعد میں علاج سے بھی تھوڑا یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔	☆.....
(Even patient suffers from fever upto months)	یہاں تک کہ مریض کو مہینہ مہینہ تک بخار رہتا ہے۔	☆.....
(Persistant cough)	کھانسی رہتی ہے جو دائمی صورت اختیار کر جاتی ہے۔	☆.....

(Recurrent oral or vaginal ulcers)	منہ اور شرماگہ میں اکثر زخم ہوتے رہتے ہیں۔	☆.....
(Recurrent fungal, bacterial or protozoal infections)	بار بار فنگل، بیکٹیریل اور پروٹوزوئل انفکشن حملہ کرتے ہیں	☆.....
(Nausea, anorexia and diarrhoea occurs)	مریض کو متلی، بھوک کی کمی اور موٹن ہوتے ہیں۔	☆.....
(Bluish spots on skin with itching)	جلد پر خارش کے ساتھ نیلے نیلے دھبے پڑ جاتے ہیں۔	☆.....
(Patient becomes immun deficient)	مریض میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔	☆.....
(Patient becomes weak and emaciated)	مریض بڑا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔	☆.....
(Pneumonia may occur commonly)	عام طور پر پھیپھڑوں کی سوزش یعنی نمونیا ہو جاتا ہے۔	☆.....
(At the last no medicine gives any response)	یہاں تک کہ مریض پر کوئی ادویات اثر نہیں کرتیں۔	☆.....
(Patient becomes victimise by different infections)	مریض دن بدن مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا جاتا ہے۔	☆.....
(Even dementia occurs before death)	موت سے پہلے مریض بھلکدہ پن، ڈیمینشیا کا شکار ہو جاتا ہے۔	☆.....
(Lungs, skin and brain becomes infected)	پھیپھڑے، جلد اور دماغ انفکشن کا زیادہ تر شکار رہتے ہیں	☆.....
(Ultimately death may occur)	آخر کار مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔	☆.....

تبعید گیاں (Complications):

(Severe infections)	مریض کو شدید انفکشنز ہو سکتے ہیں۔	☆.....
(Kaposi's sarcoma)	جلد میں خون کی رگوں کا میلکینیٹ کینسر جو نیلے دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔	☆.....
(Non-Hodgkin's lymphoma)	مریض کو لیفٹ نوڈز کے کینسر کی ایک قسم نان ہاجکنز لیمفوما بھی ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Squamous cell carcinoma of anus)	اینل امیریہ کا اسکوائمس سیل کارسینوما بھی ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Death may occur)	مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔	☆.....

تشخیص (Diagnosis):

(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا مکمل معائنہ کرایا جاتا ہے۔
(Urine R/E may be done)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(Stool R/E may be done)	☆..... پاخانے کا عام امتحان کرایا جاتا ہے۔
(HIV-Antibodies by ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)	☆..... ایچ۔ آئی۔ وی۔ اینٹی باڈیز۔
(HIV PCR (Polymerase Chain Reaction) for viral load)	☆..... ایچ۔ آئی۔ وی۔ پی سی آر۔
(Severity of immune deficiency by CD4 count which will be usually less than 200 cells / millimeter cube)	☆..... خون میں CD4 کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔
(Chest X-Ray may be done)	☆..... سینے کا ایکس رے کیا جاتا ہے۔
(Biopsy of bluish spots of the skin)	☆..... جلد کے نیلے دھبوں کی بائیوپسی۔

روک تھام (Preventions):

(Public awareness about AIDS)	☆..... ایڈز سے متعلق عوام کو معلومات دینی چاہیے۔
(HIV screening of blood before transfusion)	☆..... ٹرانسفیوژن سے پہلے خون کا ایچ آئی وی ٹیسٹ کریں۔
(Use of disposable syringes/needles strictly)	☆..... سرنج اور بلیڈز ایک مرتبہ کے بعد استعمال نہ کریں۔
(Avoid needle prick & use disinfectant surgicals)	☆..... سوئی سے نہ گدوائیں اور صاف سرجیکل آلات استعمال کریں
(Do safe sex (with condom)	☆..... جنسی میل جول محفوظ طریقے سے کریں۔
(Infected mothers should avoid breast feeding)	☆..... ایڈز سے متاثرہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے۔

علاج (Treatment):

(Treatment is done according to symptoms)	☆..... علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔
(Psychological support for the patient is needed)	☆..... مریض کو نفسیاتی سہارا دیں۔
(Specific treatment is still under research)	☆..... ایڈز کے خاص علاج پر ابھی تک ریسرچ جاری ہے۔
(Protease inhibitors are used)	☆..... پروٹی ایز ان ہی ٹریز استعمال کیے جاتے ہیں۔
(Nucleoside reverse transcriptase inhibitors are used)	☆..... نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز ان ہی ٹریز۔
(Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors are used)	☆..... نان نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز ان ہی ٹریز۔



گنوریا

(سوزاک)

(GONORRHOEA)

تعارف (Introduction): گنوریا یعنی سوزاک ایک متعدی جنسی بیماری ہے جس میں مرد مریض کے یوریتھرا سے اور عورت مریض کی اندام نہانی سے پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔

An acute infectious condition characterised by a discharge from the genitalia.

اسباب (Causative Organisms):

(Neisseria Gonococci)	☆..... نسیریا گونوکوکائی۔
-----------------------	---------------------------

دورانیہ (Incubation Period):

☆.....	2 سے 10 دن۔	(2 - 10 days)
--------	-------------	---------------

پھیلنے کا طریقہ کار (Mode Of Spread):

☆.....	یہ مرض متاثرہ مریض سے جنسی میل جول سے لگ جایا کرتا ہے۔	(Transmitted by intercourse with infected partner)
☆.....	یہ مرض صحت مند کیرم کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔	(Transmitted through healthy carriers)
☆.....	سوزاک کی مریضہ ماں سے پیدا ہونے والے بچے کو ہو سکتا ہے۔	(From infected mother to delivered baby)

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): سوزاک چونکہ مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو متاثر کرتی ہے اس لئے اس مرض کی علامات مردوں، عورتوں اور بچوں میں مختلف ہوتی ہیں۔

Gonorrhoea can infect males, females and infants. So the signs and symptoms are different in males, females and infants.

مردوں میں علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms In Males):

☆.....	مردوں میں پیشاب کی نالی یوریتھرا میں سوزش ہو جاتی ہے۔	(In males urethritis occur)
☆.....	مردوں میں یہ انفکشن یوریتھرا کے اگلے سرے سے شروع ہوتا ہے۔	(Infection starts from anterior of urethra in males)
☆.....	مرد مریض جسم میں علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں یہ مرض پھیلا سکتا ہے	(Symptom free male can spread gonorrhoea)
☆.....	بعد ازاں یہ انفکشن یوریتھرا کے پچھلے حصے تک پھیل جاتا ہے۔	(Later on infection spreads at posterior urethra)
☆.....	یہ انفکشن اپنی ڈیڈی مس تک بھی پھیل سکتا ہے۔	(Infection can spread till epididymus)

(Patient complains about dysuria)	☆..... مریض پیشاب کرتے وقت سخت درد کی شکایت کرتا ہے۔
(Patient complains about burning micturation)	☆..... مریض پیشاب کرتے وقت سخت جلن کی شکایت کرتا ہے۔
(There is discharge of pus from urethra)	☆..... یوریتھرا سے گاڑھی سی پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔
(Sometimes discharge of blood from urethra)	☆..... بعض اوقات یوریتھرا سے خون کا اخراج بھی ہوتا ہے۔
(Many times patient develops fever)	☆..... کئی مرتبہ مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔
(Glans penis becomes reddened due to urethritis)	☆..... یوریتھرا کی سوزش کی وجہ سے عضو تناسل کا اگلا سر سرخ ہو جاتا ہے
(Glans penis becomes painful due to urethritis)	☆..... یوریتھرا کی سوزش کی وجہ سے عضو تناسل کا اگلا سر اُرد ہو جاتا ہے
(Pus discharge increases as infection develops)	☆..... جوں جوں انفکشن ترقی کرتا جاتا ہے پیپ کا اخراج بڑھ جاتا ہے
(Patient complains about polyurea)	☆..... مریض پیشاب بار بار آنے کی شکایت کرتی ہے۔

عورتوں میں علامات و نشانیائیں (Signs & Symptoms In Females):

(In females urethritis occur)	☆..... عورتوں میں پیشاب کی نالی یوریتھرا میں سوزش ہو جاتی ہے۔
(There is history of vaginal discharge)	☆..... عضو مخصوصہ سے رطوبت کے اخراج کی ہسٹری بھی ملتی ہے۔
(Symptom free female can spread gonorrhoea)	☆..... عورت مریض جسم میں علامات نہ ہوں یہ مرض پھیلا سکتی ہے۔
(Later on infection spreads to cervix and anus)	☆..... بعد ازاں یہ انفکشن سرویکس اور مقعد تک پھیل جاتا ہے۔
(Infection can involve female pelvic organs)	☆..... یہ انفکشن پیڑو کے اعضاء تک بھی پھیل سکتا ہے۔
(Patient complains about dysuria)	☆..... مریضہ پیشاب کرتے وقت سخت درد کی شکایت کرتی ہے۔

(Patient complains about burning micturation)	☆..... مریض پیشاب کرتے وقت سخت جلن کی شکایت کرتی ہے۔
(There is discharge of pus from urethra)	☆..... یوریتھرا سے گاڑھی سی پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔
(Sometimes discharge of blood from urethra)	☆..... بعض اوقات یوریتھرا سے خون کا اخراج بھی ہوتا ہے۔
(Many times patient develops fever)	☆..... کئی مرتبہ مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔
(Patient complains about polyurea)	☆..... مریض پیشاب بار بار آنے کی شکایت کرتی ہے۔
(Pus discharge increases as infection develops)	☆..... جوں جوں انفکشن ترقی کرتا جاتا ہے پیپ کا اخراج بڑھ جاتا ہے
(Signs & symptoms are not severe in females)	☆..... مردوں کی نسبت عورتوں میں سوزاک کی علامات شدید نہیں ہوتیں

شیر خواروں میں علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms In Infants):

(Infected babies are delivered by infected mothers)	☆..... متاثرہ ماں سے پیدا کیے پیدائشی سوزاک میں مبتلا ہوتے ہیں۔
(Ophthalmitis occurs in infected infant)	☆..... ایسے شیر خوار کو آنکھوں کی سوزش ہوتی ہے۔
(Purulent ophthalmic discharge in infant)	☆..... شیر خوار کی آنکھوں سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔
(If not treated effectively vision may be disturbed)	☆..... اگر درست علاج نہ کیا جائے تو شیر خوار کی نظر متاثر ہو سکتی ہے۔
(Infants who suffer from ophthalmitis & discharge of pus from eyes are examined for gonorrhoea)	☆..... ایسے شیر خوار جو پیدائش کے فوراً بعد آنکھوں کی سوزش اور پیپ کے اخراج میں مبتلا ہوں تو ان میں سوزاک کی تشخیص کی جاتی ہے

پچیدگیاں (Complications):

(Infection become chronic if kept privacy)	☆..... اگر انفکشن کو چھپایا جائے تو یہ کرائف صورت اختیار کر سکتا ہے۔
(Infection may spread to associated areas)	☆..... یہ انفکشن آس پاس دوسرے حصوں تک پھیل سکتا ہے۔
(Chronic gonorrhoea may cause sterility)	☆..... کرائف سوزاک مردوں و عورتوں میں بانجھ پن بھی کر سکتا ہے۔
(In females can cause pelvic inflammatory disease)	☆..... عورتوں میں یہ انفکشن پیلوک انفلا میٹری ڈیزیز بھی کر سکتا ہے۔
(Disturbance of vision can occur in infected infants)	☆..... متاثرہ شیرخواروں میں نظر متاثر ہو سکتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis):

(In time diagnosis are essential)	☆..... سوزاک کی بروقت تشخیص انتہائی ضروری ہے۔
(Complete blood count with ESR)	☆..... خون کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(Pus discharge culture & sensitivity test)	☆..... پیپ کے اخراج کا کلچر اور حساسیت ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(Urine culture and sensitivity test)	☆..... پیشاب کا کلچر اور حساسیت ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(VDRL test)	☆..... وی۔ ڈی۔ آر۔ ایل۔ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(Pelvic ultrasound is advised)	☆..... پیٹ کے نچلے حصے کا الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے۔

علاج (Treatment):

(Highly effective antibiotic injections e.g. inj Rocephin)	☆..... انجکشن رو سیفن لگائے جاتے ہیں۔
(Antibiotic capsules e.g. cap Cefspan 400mg)	☆..... اینٹی بائیوٹک کپسول سیف سپان 400 ملی گرام۔
(Anti inflammatory enzyme e.g. tab Danzen D.S)	☆..... دافع سوزش انزائم مثلاً ڈانزن ڈی۔ ایس۔
(Urinary alkalizer e.g. syp Citralka)	☆..... پیشاب کی جلن دور کرنے کیلئے سٹراکالک شربت دیں۔
(Infant must be treated under paediatric supervision)	☆..... شیرخوار کو بچوں کے سپیشلسٹ کو دکھائیں۔
(Anti pyretic e.g. Panadol in case of fever)	☆..... بخار کی صورت میں دافع بخار مثلاً پیناڈول دیں۔





Vaginal Gonorrhoea



Congenital Gonorrhoea



Vaginal Syphilis



Congenital Syphilis

سفلس

(آتشک)

(SYPHILIS)

تعارف (Introduction): سفلس یعنی آتشک جنسی میل جول کے ذریعے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جس میں تمام جسم پر خاص قسم کے دھبے اور چھالے سے نکل آتے ہیں۔

A sexually transmitted disease resulting in the formation of lesions throughout the body.

اسباب (Causative Organisms):

(Treponema Pallidum)	☆..... ٹریپونیمیا پالی ڈم۔
----------------------	----------------------------

دورانیہ (Incubation Period):

(9 - 90 days)	☆..... 9 سے 90 دن۔
---------------	--------------------

پھیلنے کا طریقہ کار (Mode Of Spread):

(Transmitted by intercourse with infected partner)	☆..... یہ مرض متاثرہ مریض سے جنسی میل جول سے لگ جاتا ہے۔
(Transmitted through kissing with infected partner)	☆..... یہ مرض متاثرہ مریض سے بوس و کنار سے لگ جاتا ہے۔
(Spreads sexually/non sexually contact with patient)	☆..... آتشک کے مریض سے جنسی و غیر جنسی فعل کے نتیجے میں لگتا ہے۔
(By the use of patient's daily use articles)	☆..... مریض کی استعمال شدہ اشیاء کے ذریعے بھی یہ مرض پھیلتا ہے۔
(By touching the wound of syphilis patient)	☆..... آتشک کے مریض کے زخم کو چھو لینے سے بھی یہ مرض لگتا ہے۔
(The disease spreads through blood transfusion)	☆..... یہ مرض انتقال خون کے باعث بھی پھیل سکتا ہے۔

علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): سفلس کی علامات کو ان کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے تین درجات میں تقسیم کیا گیا ہے؛

The signs and symptoms of syphilis are divided into three stages according to their appearance, which are as follows;

پہلے درجے کے سفلس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms In Primary Syphilis):

(This is an initial stage of disease)	☆..... یہ مرض کی ابتدائی حالت ہوتی ہے۔
(Bacteria ruptures penile skin and gets entry)	☆..... بیکٹیریا عضو تناسل کی جلد کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔
(Pinkish blister appears at the site of ruptured skin)	☆..... پنیس کی جلد کے متاثرہ مقام پر ایک گلابی چھالہ نمودار ہوتا ہے
(Penis infects in males by this infection)	☆..... مردوں میں اس مرض سے عضو تناسل متاثر ہوتا ہے۔
(Vagina and uterus are infected by this infection)	☆..... عورتوں میں اس مرض سے ویجینا اور بچہ دانی متاثر ہوتی ہے۔
(There is no pain in this blister)	☆..... اس چھالے میں کوئی درد نہیں ہوتا۔
(This blister is called "Chancre")	☆..... اس چھالہ نما بھار کو "شینکر" کہا جاتا ہے۔
(Without treatment blister dries within 3-6 weeks)	☆..... یہ چھالہ بغیر علاج کے 3 سے 6 ہفتوں میں خشک ہو جاتا ہے۔
(Blister remains on penis as sloughing)	☆..... یہ چھالہ عضو تناسل پر ایک کھرند سا بن جاتا ہے۔
(Penile wound heals and scar remains only)	☆..... زخم مندمل ہو جاتا ہے اور صرف نشان باقی رہ جاتا ہے۔
(Inguinal & submandibular lymph nodes enlarged)	☆..... رانوں اور جبرے کے نیچے لیف نوڈز بڑھ جاتے ہیں۔
(These lymph nodes are hard but having no pains)	☆..... یہ لیف نوڈز سخت ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی درد نہیں ہوتا۔

دوسرے درجے کے سفلس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms In Secondary Syphilis):

(Disease goes in dormant period after primary stage)	☆..... ابتدائی سفلس کے بعد مرض خوابیدہ درجہ میں چلا جاتا ہے
(It looks that as if the disease became cure)	☆..... ایسا لگتا ہے کہ مریض بالکل صحت یاب ہو گیا ہے۔

(Disease spreads in all body after 2-3 months)	☆..... 2 سے 3 ماہ بعد یہ مرض سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔
(Warts appear on penile skin)	☆..... عضو تناسل کی جلد پر سخت ابھار والی پھنسیاں بن جاتی ہیں
(Lesions on mucous membranes of mouth & throat)	☆..... منہ اور حلق کی میوکس ممبرینز پر ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔
(These lesions become wound when spread)	☆..... جب یہ ابھار پھلتے ہیں تو زخم بن جاتے ہیں۔
(Feverish condition appears)	☆..... مریض میں بخار کی سی کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے۔
(Joint pains, laziness & other symptoms worse at night)	☆..... جوڑوں میں درد، سستی اور تکالیف رات کو بڑھ جاتی ہیں۔
(Weakness due to anemia)	☆..... خون کی کمی کے باعث کمزوری ہوتی ہے۔
(Wounds contain germs which become infectious)	☆..... زخموں میں جراثیم بھرے ہوتے ہیں جو پھیل سکتے ہیں۔

تیسرے درجے کی سفلس کی علامات و نشانات (Signs & Symptoms In Tertiary Syphilis):

(At end of secondary stage there is gap of few years)	☆..... دوسرے درجے کے خاتمے پر کچھ سالوں کا وقفہ آتا ہے۔
(In this stage no signs / symptoms appear)	☆..... اس دوران مرض کی کوئی بھی علامات دیکھنے میں نہیں آتیں۔
(Thats why this stage is called latent stage)	☆..... اسی لیے مرض کا یہ درجہ خفیہ سٹیج کہلاتا ہے۔
(After latent stage disease enters in tertiary stage)	☆..... خفیہ مرحلے کے بعد مرض تیسرے درجے میں داخل ہوتا ہے۔
(Eruptions appear on liver)	☆..... جگر کے مقام پر ابھار سے پیدا ہو جاتے ہیں۔
(Eruptions appear on bones)	☆..... ہڈیوں کے مقام پر ابھار سے پیدا ہو جاتے ہیں۔
(Eruptions appear on testes)	☆..... خصیوں کے مقام پر ابھار سے پیدا ہو جاتے ہیں۔
(These eruptions are called "Gummas")	☆..... ان ابھاروں کو "گمما" کہتے ہیں۔

(These gummas are greenish or yellow coloured)	☆..... یہ گمما عام طور پر سبزی مائل یا زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔
(These gummas appear on different parts of body e.g. around knees, chest, sternum and nasal bone etc)	☆..... یہ گمما جسم کے مختلف حصوں مثلاً گھٹنوں اور سینے کے ارد گرد سٹرنم ہڈی اور ناک کی ہڈی پر ظاہر ہوتے ہیں۔
(These gummas are misdiagnosed over to tumors)	☆..... غلطی سے انہیں رسولی سمجھ لیا جاتا ہے۔
(At termination of this stage CNS affects)	☆..... مرض کے آخری درجے میں سنٹرل نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے۔
(Due to which paralytic condition arises)	☆..... جس کی وجہ سے فالج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
(Fetus can acquire syphilis called congenital syphilis)	☆..... بچے کو پیدائشی سفلس بھی ہو سکتا ہے۔

پہچیدگیاں (Complications):

(The disease may become chronic in nature)	☆..... یہ بیماری کرائیک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔
(Relapses of stages can occur)	☆..... مرض کے مختلف درجے بار بار حملہ کر سکتے ہیں۔
(The infection may spread to others)	☆..... یہ بیماری دوسروں تک پھیل سکتی ہے۔
(Infected mother can transmit disease to new born)	☆..... متاثرہ ماں سے یہ مرض پیدا ہونے والے بچے کو لگ سکتا ہے۔
(The disease may invite secondary infections)	☆..... یہ مرض دوسری بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔

علاج (Treatment):

(Penicillin is highly effective e.g. inj Penidure)	☆..... انجکشن پنسیلین لگائے جاتے ہیں۔
(If patient allergic to penicillin then give Cephalosporins)	☆..... اگر پنسیلین سے الرجی ہو تو سیفالاسپورینز دیں۔
(Symptomatic treatment may be done)	☆..... علامتی علاج بھی کیا جاتا ہے۔





Gonorrhoea In Female



Neonatal
Gonorrhoeal Ophthalmitis



Genital Syphilis



AIDS Patient

یونٹ: 25

توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات

(ای۔ پی۔ آئی)

(EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION)
(E.P.I)

تعارف (Introduction): گورنمنٹ کے پروگرام ای۔ پی۔ آئی (E.P.I) کی بدولت بچوں کو سات مہلک بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کیلئے ویکسین مفت لگائی جاتی ہیں۔ اس لئے ماں کو ای۔ پی۔ آئی پروگرام کے بارے میں مکمل علم ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو یہ ٹیکے لگوا کر سات خطرناک بیماریوں سے بچا سکے۔ اس پروگرام کے بارے میں تفصیلاً جاننے سے پہلے ذرا ویکسین اور اس کے کام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔

ویکسین (Vaccine): ویکسین ایک ایسی امیونوبیالوجیکل (Immuno Biological Substance) چیز ہے جسے کسی بیماری کے خلاف مخصوص بچاؤ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

ویکسین کا طریقہ عمل (Mode Of Action Of Vaccine): ویکسین جب جسم کے اندر جاتی ہے تو جسم اس ویکسین کو بیماری کا جراثیم سمجھ کر اس کے خلاف رد عمل ظاہر کرتا ہے اور خون میں مخصوص مادے بناتا ہے جسے اینٹی باڈیز (Antibodies) کہتے ہیں۔ کسی جراثیم کے خلاف جتنی زیادہ اور طاقت ور اینٹی باڈیز ہوں گی، جسم میں اس بیماری کے خلاف لڑنے کی اتنی ہی زیادہ صلاحیت یعنی طاقت ہوگی۔

ویکسین کی اقسام (Types Of Vaccine): ویکسین مردہ، نیم مردہ (Live Attenuated) یا جراثیم کے زہر (Toxin) سے بنتی ہے اور ویکسین کی درج ذیل اقسام ہیں؛

(Live Attenuated Vaccine)	☆..... نیم مردہ جراثیموں سے تیار شدہ ویکسین۔
(Inactivated or Killed Vaccine)	☆..... مردہ جراثیموں سے تیار شدہ ویکسین۔
(Toxoids)	☆..... جراثیموں کے زہریات یعنی ٹاکسائیڈز سے تیار شدہ ویکسین۔
(Combined Preparations)	☆..... ان تینوں طریقوں سے تیار کردہ ویکسین یعنی کمبائنڈ پریپیریشنز۔



ویکسین کی ممنوعات

(CONTRAINDICATIONS OF VACCINES)

عمومی (General): عام طور پر ویکسین کے استعمال کی درج ذیل حالات میں ممانعت ہے؛

- 1- کوئی شدید مرض (Any Acute Illness)
- 2- شدید غذائی کمی (Severe Malnutrition)
- 3- جسم میں قوت مدافعت کی کمی (Immune Deficiency)

حفاظتی ٹیکوں / ایمونائزیشن کا تعارف (INTRODUCTION TO IMMUNIZATION): حفاظتی ٹیکے ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک شخص کو کسی ایک متعدی بیماری کے خلاف مزاحمت کرنے یا مدافعت پیدا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ عمل ایک ویکسین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ویکسین انسان کے جسم میں موجود اپنے ہی مدافعتی نظام کو متحرک کر دیتی ہے جس سے وہ شخص آنے والی انفیکشن یا بیماری اور ان کی علامات و پیچیدگیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. Vaccines stimulate the body's own immune system to protect the person against subsequent infections or diseases and signs/symptoms & complications.

ایمونالوجی (IMMUNOLOGY): قوت مدافعت کے بارے میں جاننا یا معلومات حاصل کرنے کیلئے مطالعہ کرنا ایمونالوجی کہلاتا ہے۔

The study about immunity is called immunology.

قوت مدافعت (IMMUNITY): یہ جسم کا دفاعی نظام ہے یا کسی بھی بیرونی چیز، انفیکشن یا بیماری کی طرف جسم کا رد عمل ہے۔

It is the defense mechanism of the body or the reaction of the body towards any foreign substance, infection or disease.



ای، پی، آئی، کی ابتداء

(START OF E.P.I)

تعارف (Introduction): ڈبلیو ایچ او نے 1974 میں ای پی آئی پروگرام شروع کیا تھا۔ پاکستان میں حفاظتی سرگرمیاں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ ایک جاری پروگرام ہے جو کیونٹی کی مدد سے انتظامی، عمل درآمد، تربیت، رپورٹنگ اور جائزہ کے باقاعدہ نظام کیساتھ چلتا ہے۔ اس پروگرام کا عالمی نظر ثانی کے طور پر مشترکہ جائزہ حکومت پاکستان، ڈبلیو ایچ او، یوئیسیف، یو ایس ایڈ اور سیڈا نے 1988 میں لیا اور اب ای پی آئی یونیورسل چائلڈ ایمونائزیشن کہلاتا ہے۔ ای پی آئی میں شامل بیماریاں یہ ہیں:

(Tuberculosis)	☆..... ٹی بی یعنی تپ دق۔
(Polio)	☆..... پولیو۔
(Measles)	☆..... خسرہ۔
(Diphtheria)	☆..... خناق۔
(Pertusis)	☆..... کالی کھانسی۔
(Tetanus)	☆..... تشنج۔
(Hepatitis)	☆..... کالا میرقان۔
(Pneumonia)	☆..... نمونیا۔
(Meningitis)	☆..... گردن توڑ بخار۔
(Influenza)	☆..... وبائی زکام۔

ای پی آئی کے مقاصد (OBJECTIVES OF EPI): ای پی آئی کے مقاصد درج ذیل ہیں؛

☆.....	حفاظتی ٹیکوں کی سو فیصد کوریج کا حصول۔	Attainment of 100% immunization coverage.
☆.....	خسرے کے واقعات کو کم کرنا۔	Reducing measles incidence.
☆.....	بچوں میں تشنج کا خاتمہ کرنا۔	Elimination of neonatal tetanus.
☆.....	پولیو کا خاتمہ کرنا۔	Eradication of poliomyelitis.
☆.....	کالی کھانسی کو کم سے کم سطح پر لانا۔	Reducing pertussis incidence to a minimum level.
☆.....	بچوں میں ٹی بی کو کم کرنا۔	Reducing childhood TB incidence.

بیکٹیریل ویکسین (BACTERIAL VACCINES): بی سی جی ویکسین، کالی کھانسی کی ویکسین، مہیضے کی ویکسین، گردن توڑ بخار کی ویکسین، نمونیا کی ویکسین اور ٹائیفائیڈ کی ویکسین وغیرہ بیکٹیریل ویکسین کی مثالیں ہیں۔

BCG, Pertussis vaccine, Cholera vaccine, Meningococcal vaccine, Pneumococcal vaccine and Typhoid vaccines are examples of bacterial vaccines.

وائرسل ویکسین (VIRAL VACCINES): کالے پیرقان کی ویکسین، پولیو ویکسین اور خسرہ ویکسین وغیرہ وائرسل ویکسین کی مثالیں ہیں۔

Hepatitis vaccines, Poliomyelitis vaccines & measles vaccines are viral vaccines.

ویکسی نیشن شیڈول (VACCINATION SCHEDULE): پاکستان میں ویکسی نیشن شیڈول درج ذیل ہے؛

The vaccination schedule in Pakistan is as under;

AGE	VACCINE	DOSE & ROUTE
At birth	BCG OPV-0	0.05ML, I.D. 2 Drops, Oral
6 weeks	DPT-1 OPV-1 HBV-1 H.Influenzae	0.5 ML, I.M. 2 Drops, Oral 0.5 ML, I.M.
10 weeks	DPT-2 OPV-2 HBV-2 H.Influenzae	0.5 ML, I.M. 2 Drops, Oral 0.5 ML, I.M.
14 weeks	DPT-3 OPV-3 HBV-3 H.Influenzae	0.5 ML, I.M. 2 Drops, Oral 0.5 ML, I.M.
9 months	Measles	0.5 ML, S.C.
15 months	Measles	0.5 ML, S.C.
18 months	DPT Booster OPV Booster	0.5 ML, I.M. 2 Drops, Oral
5 years	DPT Booster OPV Booster	0.5 ML, I.M. 2 Drops, Oral
10 years	Td Booster	0.5 ML, I.M.

جدول میں استعمال کئے گئے مخففات (ABBREVIATIONS USED IN THE TABLE): استعمال کئے گئے مخففات یہ ہیں؛

BCG: Bacilli, Calmette, Guerin (vaccine for TB).	☆..... بی سی جی: ٹی بی ویکسین۔
OPV: Oral Polio Vaccine.	☆..... او پی وی: او رل پولیو ویکسین۔
DPT: Diphtheria, Pertussis and Tetanus.	☆..... ڈی پی ٹی: ڈیفٹیریا، پرتیوسس اور ٹیٹانس۔
HBV: Hepatitis B Vaccine.	☆..... ایچ بی وی: ہیپاٹائٹس بی ویکسین۔
Td: Tetanus toxoid.	☆..... ٹی ڈی: ٹیٹانس ٹاکسائیڈ۔
IM: Intramuscular.	☆..... آئی ایم: انٹرا مسکولر (گوشت میں)۔
SC: Subcutaneous.	☆..... ایس سی: سب کیوٹینیس (زیر جلد)۔
ML: Milliliter.	☆..... ایم ایل: ملی لیٹر۔

ویکسین لگانے کے طریقے (METHODS OF VACCINATION): ویکسین لگانے کے عام طریقے درج ذیل ہیں؛

☆..... بی سی جی ویکسین جلد کے اندر لگایا جاتا ہے۔ یہ ویکسین بازو کے اوپر کے حصے میں لگایا جاتا ہے۔

☆..... BCG vaccine is given intradermally in upper part of right deltoid.

☆..... ڈی، پی، ٹی، ویکسین گوشت میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ویکسین سیدھے ران کے نچلے حصے میں مسلز میں لگایا جاتا ہے۔

☆..... DPT vaccine is given intramuscularly in lateral side of right thigh.

☆..... پولیو ویکسین منہ کے ذریعے دی جاتی ہے۔

☆..... OPV is given by mouth.

☆..... خسرہ ویکسین جلد کے نیچے بائیں ہاتھ پہ ڈیلٹائیڈ مسل کے درمیان لگائی جاتی ہے۔

☆..... MEASLES vaccine is given subcutaneously in the middle of deltoid of left arm.

☆☆☆.....

ویکسین کے منفی اثرات (ADVERSE EFFECTS OF VACCINES): مختلف ویکسین جسم پر مختلف قسم کے رد عمل یعنی سائیڈ

ایفیکٹس مرتب کر سکتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں؛

Different vaccines can cause different adverse effects;

☆..... بی سی جی ویکسین (BCG Vaccine): اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں؛

(Local reaction at site of vaccination lasts long)	☆..... ویکسین کے مقام پر مقامی رد عمل زیادہ دیر تک ہوتا ہے
(Suppurative generalized TB infection rarely occurs)	☆..... اس ویکسین سے ٹی بی کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔

☆..... پروٹوسس ویکسین (Pertussis Vaccine): اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں؛

(Local and systemic reaction can occur)	☆..... جسمانی اور مقامی رد عمل ہو سکتا ہے۔
(Cyst formation at the site of injection)	☆..... انجکشن لگانے والی جگہ پر گوڑ کا بننا۔
(Convulsion)	☆..... جھٹکے لگنا

☆.....تشخ ویکسین (Tetanus Vaccine): اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں؛

(No side effects)	☆..... اس کے کوئی منفی اثرات / نقصانات نہیں۔
-------------------	--

☆.....خناق ویکسین (Diphtheria Vaccine): اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں؛

(Allergic reactions may occur)	☆..... اس ویکسین سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔
--------------------------------	---

☆.....پولیو ویکسین (Polio Vaccine): اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں؛

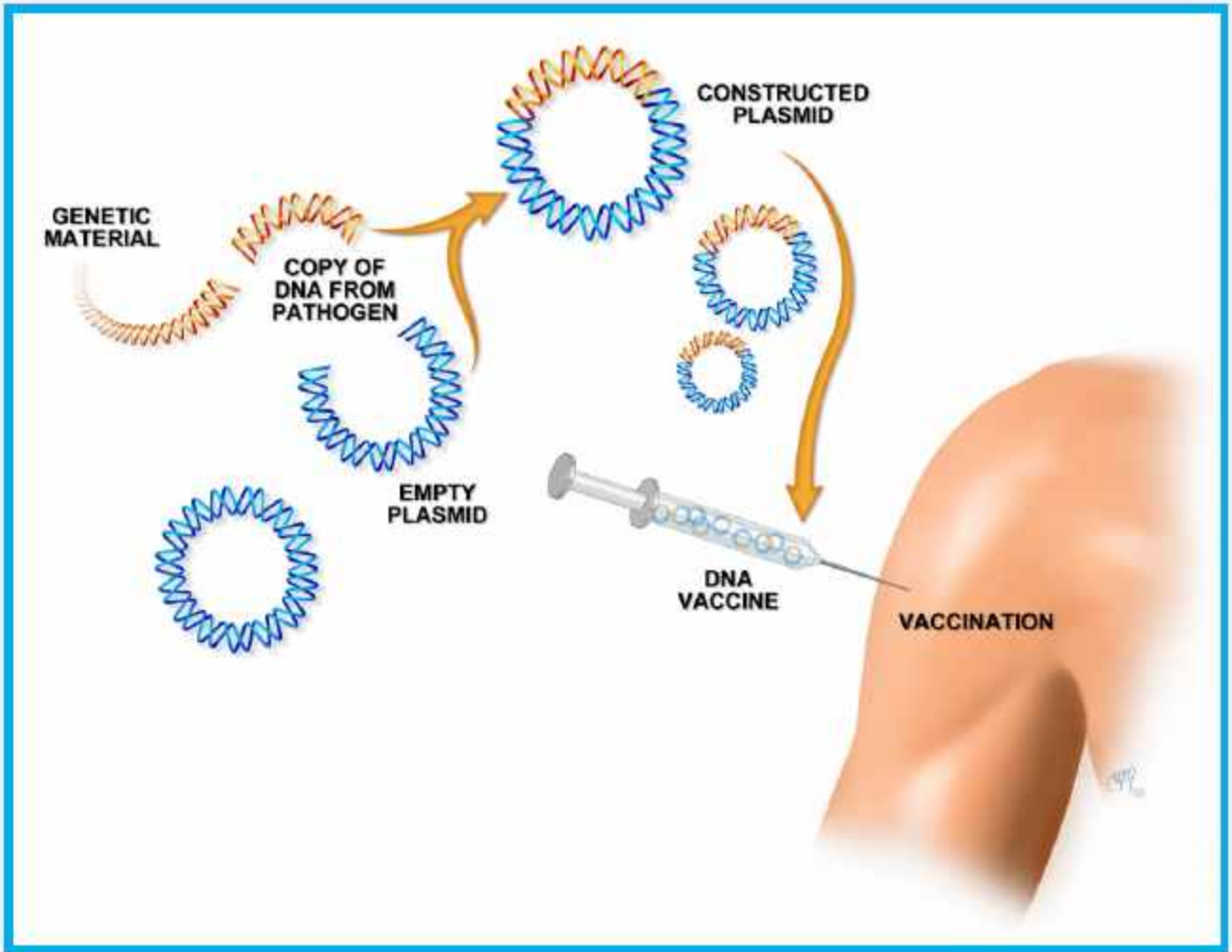
(Killed vaccine is harmless)	☆..... مرے ہوئے وائرس سے تیار کردہ ویکسین غیر نقصان دہ ہوتی ہیں۔
(Live attenuated vaccine may cause paralysis)	☆..... نیم مردہ وائرس سے تیار کردہ ویکسین نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔

☆.....خسرہ ویکسین (Measles Vaccine): اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں؛

(Febrile reactions can occur)	☆..... بخار کی صورت میں رد عمل ہو سکتا ہے۔
(Local reaction may occur)	☆..... مقامی رد عمل ہو سکتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ سلی میڈیسن



Vaccination Process



Vaccine Vials

فیملی پلاننگ کی اہمیت

(IMPORTANCE OF FAMILY PLANNING)

تعارف (Introduction): دورِ حاضر میں جہاں لطیف احساسات و جذبات کی جگہ مشینوں کی کثافت نے لے لی ہے وہیں ہماری زندگی کے کئی تقاضوں میں بھی تبدیلیاں کارفرما ہو چکی ہیں۔ آج کے مہنگائی کے اس دور میں ضروریاتِ زندگی کو محدود کرنے کی اہم ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی کے تحت بچوں کی پیدائش اور فیملی پلاننگ کرنے کے اقدامات ایک جانب جہاں معاشی بوجھ اور مسائل کو کم کرتے ہیں وہیں عورت کی جنسی و جسمانی صحت میں بھی مفید اور موثر کردار ادا کرتے ہیں غرضیکہ بچے جتنے کم ہوں گے آپ بچوں کی نگہداشت، پرورش، تعلیم و تربیت اور ان کے مستقبل کے لئے اتنی ہی اچھی اور شاندار منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ لہذا فیملی پلاننگ آج کے اس زبوں حال معاشرتی دور کا ایک اہم تقاضا ہے تاکہ ملک کی آبادی جتنی مناسب اور کم رہے گی تو ملکی، معاشرتی اور قومی ترقی کے امکانات اتنے ہی روشن اور بہتر ہوں گے غرضیکہ مناسب فیملی پلاننگ نہ صرف بچوں کے بہترین مستقبل، عورت کی جنسی و جسمانی صحت، گھریلو اخراجات میں کمی، معاشرتی ترقی کی ضامن، قومی وقار کے لئے ضروری ہے بلکہ ملکی ترقی کا انحصار بھی اسی فیملی پلاننگ پر ہے۔

یوں تو فیملی پلاننگ میڈیکل سائنس کا ایک وسیع و عریض موضوع ہے جس کا مکمل احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں لیکن ذیل میں شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لئے فیملی پلاننگ کے چند معروف، موثر اور محدود طریقہ جات بیان کئے گئے ہیں تاکہ قارئین کو اس سے متعلق کچھ مختصر اور بنیادی معلومات حاصل ہو سکیں اور وہ فیملی پلاننگ کے خواہش مند شادی شدہ جوڑوں کو فیملی پلاننگ کلینکس ریفر کر سکیں۔



کنڈوم

(CONDOM)

تعارف (Introduction): کنڈوم کا استعمال شادی شدہ مردوں کے لئے خاندانی منصوبہ بندی کا سب سے معروف اور آسان مستعمل طریقہ ہے۔ کنڈوم دراصل ایک باریک نہایت نفیس ربڑ کا غلاف ہوتا ہے جسے مرد بوقتِ جماعت عضو تناسل پر چڑھا کر آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کنڈوم چکنے ہوتے ہیں اور سادہ رنگدار دونوں اقسام میں مختلف خوشبو یا ت کے ساتھ آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ یہ کنڈوم انتہائی کم قیمت اور آسانی سے دستیاب ہیں۔ کنڈوم کے استعمال کے کوئی برے اور مضر اثرات نہیں بلکہ میاں یا بیوی میں سے کوئی اگر اندرونی انفیکشن میں مبتلا ہو تو یہ

کنڈوم ایک دوسرے کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا استعمال ایڈز سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کنڈوم کے استعمال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مانع حمل طریقہ حسب منشاء استعمال کیا جاتا ہے اور جب بھی میاں بیوی کو بچے کی خواہش ہو تو اس کا استعمال ترک کیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ کنڈوم کے استعمال میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں مثلاً استعمال کرنے سے پہلے کنڈوم کھول کر چیک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ کنڈوم کو ناخن کا کوئی کونہ وغیرہ نہ لگ جائے کیونکہ اس سے کنڈوم پھٹ سکتا ہے۔ اس طرح ایک کنڈوم صرف ایک بار ہی استعمال کرنا چاہیے اور کنڈوم دھو کر دوسری مرتبہ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر اس بات کا ضروری خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت کے بعد کنڈوم کو ہاتھ سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ چکنائٹ کی وجہ سے کنڈوم اتر کر عورت کے جسم میں نہ رہ جائے۔



نس بندی

(VASECTOMY)

تعارف (Introduction): نس بندی یعنی ویزیکٹومی مردوں کے لئے خاندانی منصوبہ بندی کا ایک محفوظ کامیاب ترین اور مستقل طریقہ ہے۔ جس طرح عورتوں کے لئے نل بندی کا طریقہ ہے بالکل اسی طرح نس بندی کا طریقہ مردوں کے لئے مستقل، محفوظ اور کامیاب ترین قرار دیا جاتا ہے۔ جو شادی شدہ جوڑے اپنی خواہش کے مطابق اپنی فیملی مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے مرد اس سو فیصد کامیاب طریقہ کو اپناتے ہیں۔ نس بندی دراصل ایک معمولی سا سرجیکل پراسس ہے جو سرجن چند منٹوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ لوکل اینسٹھنک انجکشن کے ذریعے مردوں کے ٹیسٹی کو لیریا کو بے حس کر کے ٹیسٹیز سے سپرمز لے جانے والی نالیوں واز ڈیفرنس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سیکس کے دوران جب مرد فارغ ہوتا ہے تو منی کے کیڑے سپرمز عورت کے جسم میں داخل نہیں ہو پاتے اور یوں حمل قرار نہیں ہو پاتا۔ یہ طریقہ اپنانے سے مردانہ قوت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا یعنی مرد کی تمام مردانہ خصوصیات قائم رہتی ہیں بلکہ بعض اوقات بڑھ بھی جاتی ہیں۔ اس طریقہ کے اپنانے سے کسی قسم کی کوئی کمزوری یا تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔ نس بندی کروالینے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ طریقہ نہایت آسان، سادہ، سو فیصد موثر، محفوظ اور مستقل ہے۔ اس طریقہ سے مرد کے تولیدی مادہ کے اخراج میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی صحت پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔

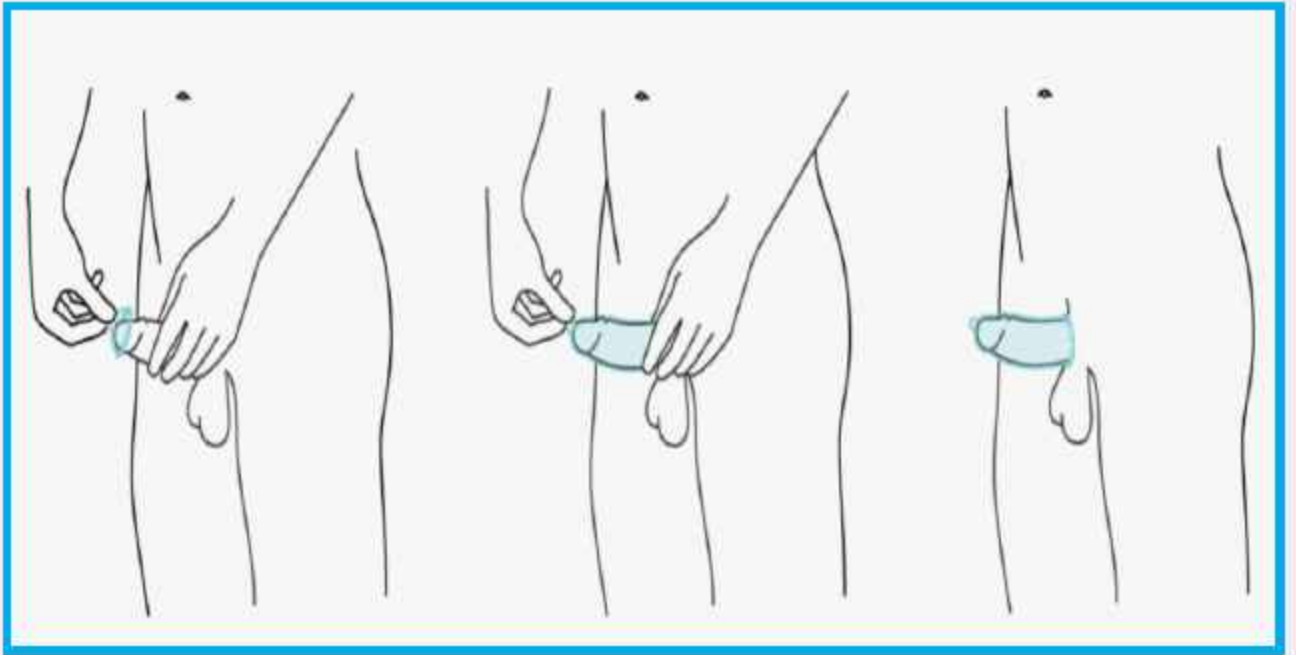




Condom



Colorful Condoms



Condom Used On Penis

چھلہ۔ آئی، یو، سی، ڈی

(INTRA UTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE)

(I.U.C.D)

تعارف (Introduction): چھلے یعنی آئی، یو، سی، ڈی کا استعمال خواتین کے لئے خاندانی منصوبہ کا نہایت ہی مفید، موثر، بے ضرر اور محفوظ طریقہ ہے۔ اس وقت بشمول ترقی یافتہ ممالک تمام ہی دنیا میں آئی، یو، سی، ڈی کا استعمال اپنی اثر پذیری، مفید اور موثر و محفوظ ہونے کے باعث عام ہے۔ اس طریقے میں پلاسٹک سے بنا ہوا ایک خاص چھلہ کا وپرزٹی (Copper's-T) لیڈی ڈاکٹریا تربیت یافتہ لیڈی عملہ عورت کی ویسجائنه میں رکھ دیتی ہے جس سے حمل قرار نہیں پاتا اور یوں عورت خاندانی منصوبہ بندی پر عمل پیرا رہتی ہے۔ آئی، یو، سی، ڈی یعنی کا وپرزٹی انتہائی بے ضرر ہے اور اس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ کا وپرزٹی کا استعمال اتنا موثر ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ہوتے ہوئے کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کا وپرزٹی چھلہ پانچ سے دس سال تک کارآمد رہ سکتا ہے تاہم مناسب یہ ہوتا ہے کہ ابتداء میں تین ماہ اور پھر بعد میں ایک سال گزر جانے پر لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ کا وپرزٹی رکھنے سے میاں بیوی کے جنسی تعلقات میں کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی کا وپرزٹی چھلہ جنسی تعلقات میں کسی قسم کی مداخلت کرتا ہے۔ یہ کا وپرزٹی کسی بھی وقت نہایت آسانی سے نکلائی جاسکتی ہے اور اسکے نکلوانے کے بعد عورت بچہ پیدا کرنے کی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ بعض اوقات کا وپرزٹی رکھے جانے کے بعد عورت کو معمولی سا خون آسکتا ہے جو کچھ دن جاری رہ سکتا ہے اور زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض عورتوں میں کا وپرزٹی رکھنے کے بعد ماہواری کا خون معمول سے پہلے یا زیادہ مقدار میں آئے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ ایک دو ماہواریوں کے بعد ماہواری کا خون حسب سابق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کا وپرزٹی رکھوانے کے بعد بعض عورتوں کے تلوں میں درد شروع ہو جاتا ہے جو آرام کرنے پر ٹھیک ہو جایا کرتا ہے لیکن اگر یہ درد زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی ہلکی سی درد کش گولیاں لے لینے سے عام طور پر درد ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ کا وپرزٹی یوں تو تمام ہی عورتیں رکھ سکتی ہیں لیکن جن عورتوں کو یوٹرس یعنی بچے دانی میں ورم ہو یا بچے دانی میں رسولیاں ہوں یا عورت حاملہ ہو تو انہیں کا وپرزٹی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ماہرین کی رائے میں کا وپرزٹی کے کوئی برے اثرات نہیں اور نہ ہی اس سے عورت کی صحت پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ ضمنی اثرات کی صورت میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ضمنی اثرات تھوڑے عرصے کے لئے ہوتے ہیں اور جلد ہی خود بخود بغیر کسی ادویات کے استعمال کے ختم ہو جاتے ہیں۔

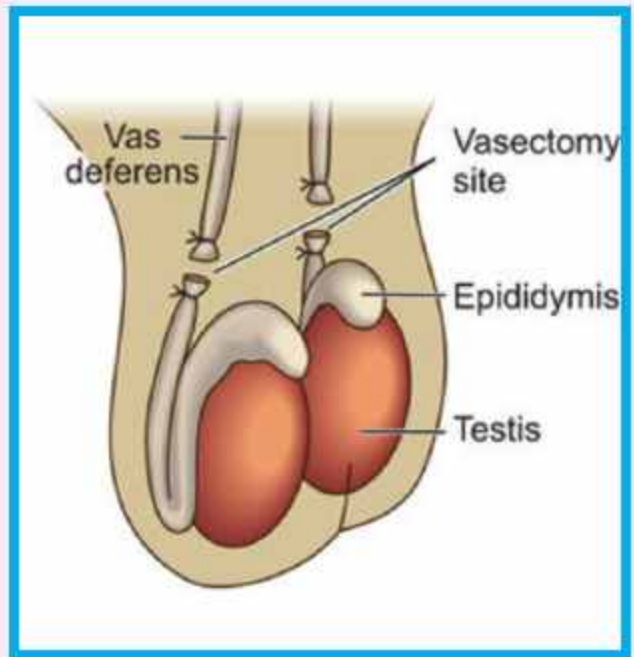




Contraceptive Injection on Female's Hip & Deltoid



Copper's - T (I.U.C.D.)



Vasectomy In Male

مانع حمل ٹیکہ

(CONTRACEPTIVE INJECTIONS)

تعارف (Introduction): مانع حمل انجکشن بھی خواتین میں خاندانی منصوبہ بندی کے لئے ایک محفوظ اور کامیاب ترین طریقہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں دو قسم کے مانع حمل انجکشن استعمال کئے جاتے ہیں ایک انجکشن ڈیپو پرویرا (Depo Provera) جو تقریباً ہر 85 دن کے بعد لگوا دیا جاتا ہے اور دوسرا انجکشن نوری جیسٹ (Norigest) جو تقریباً 55 دنوں کے بعد لگوا دیا جاتا ہے۔ یہ انجکشن عورتوں کے کوہے کے قریب لگایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکہ کھائی جانے والی مانع حمل گولیوں کی طرح بے حد موثر ہے۔ ٹیکہ لگوانے کے بعد عورت کو صرف یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ یہ انجکشن دوبارہ لگوانا ضروری ہوتا ہے۔ اس انجکشن کا استعمال حمل روکنے کے دوسرے پُر اثر طریقوں میں سب سے پُر اثر طریقہ ہے۔ اس انجکشن کا استعمال نہایت آسان ہے اور انجکشن لگوانے کے بعد میاں بیوی کے جنسی تعلقات پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ دیر پا اثر قائم رکھنے کے لئے ایک سال میں چار سے پانچ مرتبہ یہ انجکشن لگوانا پڑتا ہے۔ اس طرح اس انجکشن کے لگوانے کے بعد شیر خوار بچے کو دودھ پلانے پر کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی اس انجکشن کے لگوانے سے ماں کے دودھ میں کسی قسم کی کمی یا اثرات ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں البتہ اس انجکشن کے ضمنی اثرات مشاہدے میں آئے ہیں جن میں عام شکایت یہ ہے کہ جو خواتین یہ انجکشن لگواتی ہیں انہیں ماہواری میں انتہائی معمولی خون کا دھبہ آتا ہے یا پھر ماہواری قدرے بے قاعدگی سے آتی ہے مگر دوسرے یا تیسرے مہینے یہ تکلیف جاتی رہتی ہے اور طبی نکتہ نگاہ سے یہ ضمنی اثرات اتنے اہم نہیں کہ اس کے متعلق خواتین پریشان ہوں لیکن بہر حال خواتین کو مانع حمل انجکشن لگوانے سے پہلے لیڈی ڈاکٹر سے اپنا طبی معائنہ کروالینا چاہیے۔



مانع حمل کھانہ والی گولیاں

(ORAL CONTRACEPTIVE PILLS)

تعارف (Introduction): مانع حمل کھائی جانے والی گولیوں کا استعمال خواتین میں خاندانی منصوبہ بندی کا نہایت آسان، بے ضرر اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ بچوں کی پیدائش میں اپنی خواہش کے مطابق وقفہ رکھنے کے لئے یہ گولیاں انتہائی بے ضرر، پا اثر اور قابل اعتماد ہیں۔ گولیوں کو حسب ہدایت متواتر استعمال کیا جائے تو یہ طریقہ بہت موثر ہے۔ گولیوں کا استعمال ترک کر دینے پر عورت دوبارہ بچہ پیدا کرنے کی خواہش پورا کر سکتی ہے یہ مانع حمل گولیاں دو طرح کے پتوں میں دستیاب ہیں۔ ایک قسم کے پورے پتے میں صرف ایکس سفید گولیاں ہوتی ہیں جبکہ دوسرے قسم کے پورے پتے میں ایکس سفید اور سات رنگدار گولیاں ہوتی ہیں۔ دونوں طرح کے پتوں کو پہلی مرتبہ شروع کرنے کے لئے ماہواری کے پانچویں دن سے ایک سفید گولی روزانہ بلا ناغہ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ وہ پتہ جس میں صرف سفید رنگ کی گولیاں ہوتی ہیں ختم کرنے کے بعد ایک ہفتہ تک



Contraceptive Injection



28 - Double Coloured Contraceptive Pills



21 - Single Coloured Contraceptive Pills

بغیر کسی گولی کے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اسی ہفتہ سے ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور پھر ماہواری کے پانچویں دن سے نیا پتہ سفید گولی سے شروع کرنا ہوتا ہے اور وہ پتہ جس میں اکیس سفید اور سات رنگدار گولیاں ہوتی ہیں۔ اس پتے کو ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد لگاتار ایک گولی روزانہ کھانی ہوتی ہے۔ پہلے سفید گولیاں اور پھر رنگدار گولیاں ختم کرنی ہوتی ہیں اور جب رنگدار گولیاں ختم ہو جائیں تب بغیر نانچے کے دوسرا نیا پتہ سفید گولی سے پھر شروع کرنا ہوتا ہے۔ اگر گولیاں کھانے میں ایک نانچہ ہو جائے تو اگلے دن صبح کو پہلے نانچہ والی گولی کھانی ہوتی ہے اور اسی شام کو مقررہ گولی کھانی ہوتی ہے لیکن تین روز نانچے کی صورت میں گولیاں کھانا بند کر دینی چاہیے اور کوئی موزوں طریقہ اپنانا چاہیے۔ اگرچہ ان مانع حمل گولیوں کا استعمال طبی لحاظ سے بے ضرر سمجھا جاتا ہے تاہم جگر کی بیماری اور بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا خواتین کو یہ گولیاں استعمال نہیں کرائی جاتیں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان مانع حمل گولیوں کے استعمال کے دوران کچھ خواتین کا وزن وقتی طور پر بڑھ جاتا ہے یا متلی ہونے لگتی ہے یا سر چکرانے کی عارضی تکلیف ہو جاتی ہے۔ عام طور پر گولیوں کے استعمال کے چند دن بعد ایسی شکایات خود بخود دور ہو جاتی ہیں کیونکہ جسم ان گولیوں کے استعمال کا عادی ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین خاندانی منصوبہ بندی کیلئے ان مانع حمل گولیوں کے استعمال سے پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرالیں اور ان گولیوں کے استعمال کے سلسلے میں اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ ان مانع حمل گولیوں کے استعمال کے سلسلے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اور وہ یہ کہ بچوں کو دودھ پلانے کے شروع کے چھ ماہ کے دوران گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔ اسی طرح پینتیس سال سے زائد عمر کی خواتین کو یہ گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حمل کے دوران ان گولیوں کا استعمال قطعی طور پر ممنوع ہے اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد چار ہفتے تک یہ مانع حمل گولیاں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئیں۔

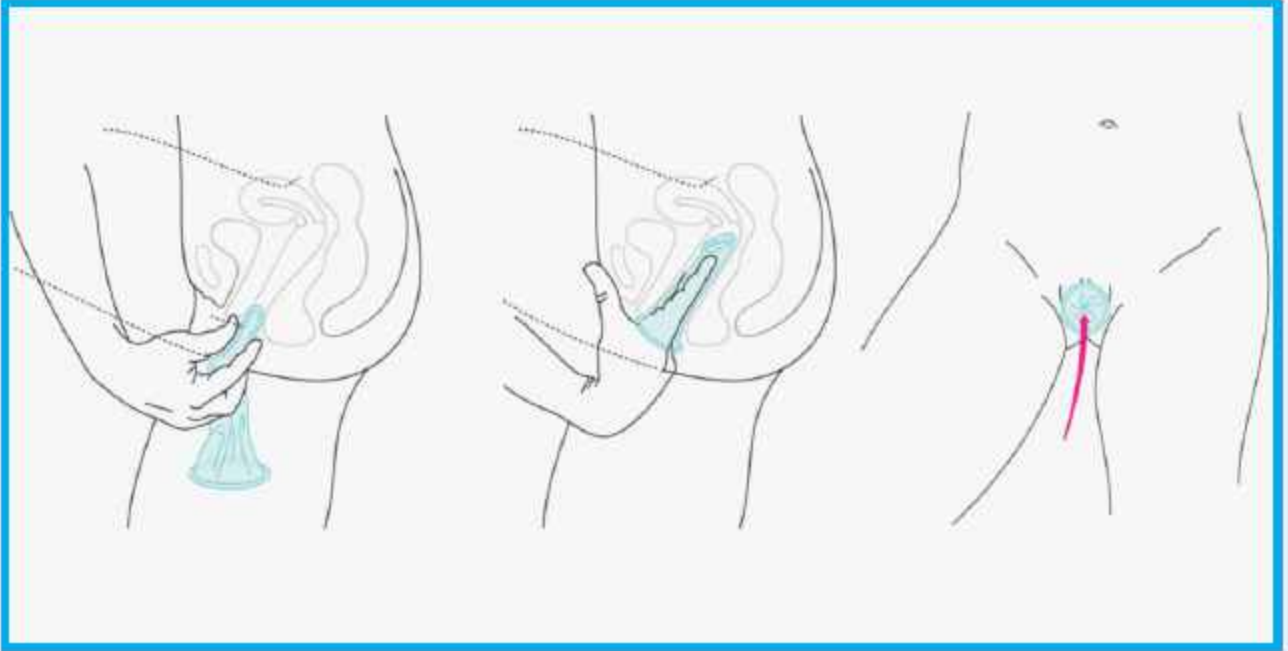


نل بندی

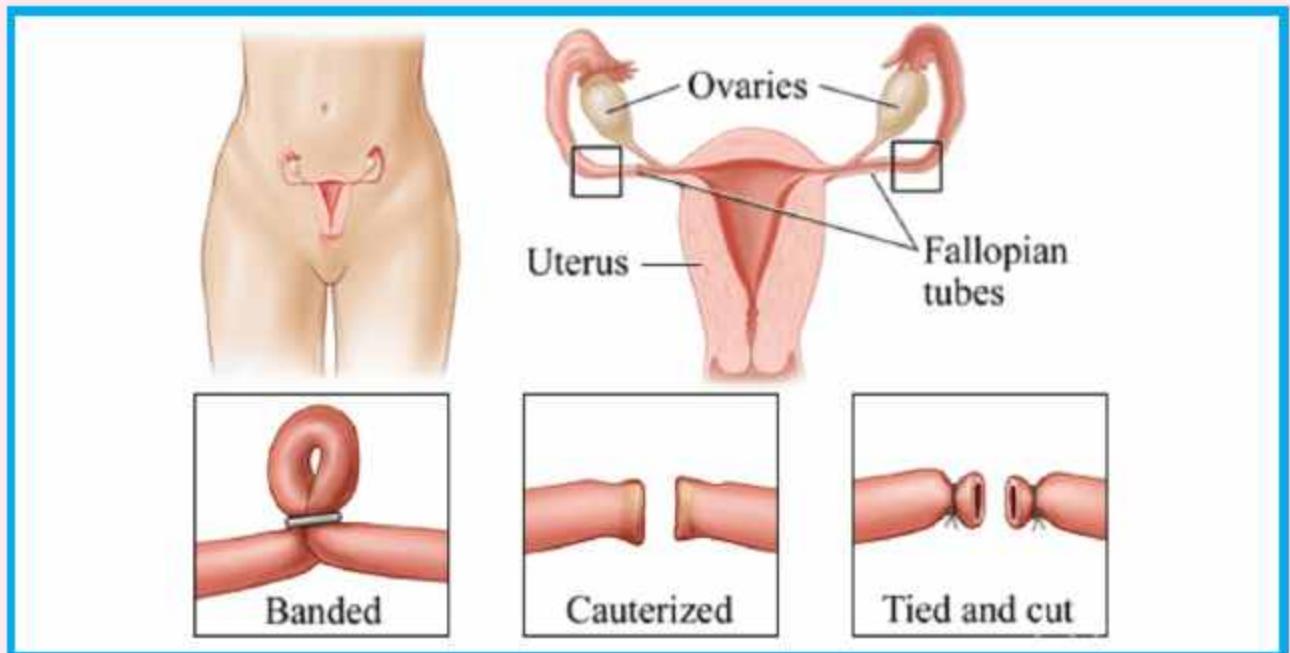
(TUBE LIGATION)

تعارف (Introduction): نل بندی خواتین کے لئے خاندانی منصوبہ بندی کا ایک محفوظ اور کامیاب ترین مستقل طریقہ ہے۔ یہ ایک نہایت معمولی سرجیکل عمل ہے جس کے ذریعے عورت کے دائیں اور بائیں دونوں نلوں یعنی فیلوپین ٹیوبز کو باندھ دیا جاتا ہے جسے ٹیوب لائی گیشن کہتے ہیں۔ اس طرح عورت کا اووم اور مرد کا سپرم آپس میں نہیں مل پاتے لہذا حمل قرار نہیں پاتا۔ یہ طریقہ سو فیصد موثر اور مستقل ہے۔ اس عمل کے بعد کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ طریقہ نہایت ہی آسان اور سادہ ہے۔ یہ طریقہ اپنانے کے بعد عورت کو کسی طرح کی کوئی کمزوری یا تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔ ماہواری میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ماہواری باقاعدہ رہتی ہے۔ اس طریقے کے اپنانے کے بعد میاں بیوی کے جنسی تعلقات پر کوئی پابندی نہیں رہتی۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نل بندی کے اس عمل کا عورت کی صحت پر کوئی ضمنی اثر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر کسی کو آپریشن کے بعد ناکوں میں کوئی تکلیف ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے۔





Vaginal Condom Usage



Tubal Ligation In Female

گائنا کولاجیکل اینڈ آبسٹیٹریکل فارما کالوجی (GYNAECOLOGICAL & OBSTETRICAL PHARMACOLOGY)

”توجہ فرمائیں“

کتاب کے اس باب میں لڑکیوں اور عورتوں سے متعلقہ عام بیماریوں کے لئے علاج و ادویات کے عام فہم آسان نسخہ جات تحریر کئے گئے ہیں۔ یہ نسخہ جات معالجے کا محض ایک اشاریہ ہیں۔ ان نسخہ جات کو تجویز کرنے اور استعمال کرنے سے پہلے مریضہ کی صحت، مرض کے اسباب اور کلینکل ٹسٹوں کے رزلٹ کی روشنی میں کسی قریبی مستند گائنا کالوجسٹ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ لیڈی ہیلتھ وزیٹر کورس کی سٹوڈنٹس کو ان نسخہ جات کے استعمال اور تجویز کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے۔

شکریہ



DYSMENORRHOEA

﴿..... ماہواری کا درد کے ساتھ آنا﴾

تعارف (Introduction):

کئی عورتوں خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں ماہواری قدرے شدت درد کے ساتھ آیا کرتی ہے جسے ڈسمنوریا کہتے ہیں۔
ماہواری کے درد کے ساتھ آنے کی وجوہات کا پتہ لگا کر علاج کرنا چاہیے۔ ڈسمنوریا کا علاج درج ذیل ہے:

Rx

1. Tab Ponstan Forte

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab No-Spa Forte

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Syp Aletris Cordial

1+1+1 بڑا چمپ کھانے کے بعد

4. Cap Fefol Vit

ایک روز اندر رات سوتے وقت

☆☆☆

AMENORRHOEA

﴿..... ماہواری کا بند ہو جانا﴾

تعارف (Introduction):

بعض اوقات حمل اور سن یاس کے علاوہ بھی عورتوں اور لڑکیوں میں ماہواری کا آنا بند ہو سکتا ہے۔ ماہواری کا اس طرح بند ہو جانا عورتوں اور لڑکیوں کے لئے ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اے مینوریا کی وجوہات کی درست تشخیص کر کے ہی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس مرض کا عام مستعمل علاج ذیل میں دیا گیا ہے:

Rx

1. Tab Premarin 0.625 mg

ہر ماہواری کے ماہ کے دوران ایک سے پچیس دن تک روزانہ ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں
(نوٹ: اے مینوریا کو ٹریٹ کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ عورت کو حمل تو نہیں ٹھہر گیا)

2. Tab Sangobion

ایک روزانہ رات سوتے وقت

3. Syp Aletris Cordial

1+1+1 بڑا چمچ کھانے کے بعد



OLIGOMENORRHOEA

﴿..... ماہواری کی کمی﴾

تعارف (Introduction):

اکثر اوقات صنفِ نازک میں ماہواری کے خون کے اخراج میں کمی واقع ہو جایا کرتی ہے جس سے عورتوں اور لڑکیوں کو ذہنی اُلجھن کے علاوہ پیلوُس میں ایک خاص طرح کا درد اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ عورتوں میں پائی جانے والی اس کنڈیشن کو اولیگو مینوریا کہتے ہیں جس کا علاج درج ذیل ہے:

Rx

1. Tab Gynaecosid (2 Tab)

ماہواری آنے سے ایک ہفتہ قبل ایک دن ایک گولی اور دوسرے دن ایک گولی پانی سے دیں
عموماً ایک ہفتہ میں ماہواری کھل کر آ جاتی ہے

2. Tab Buscopan Plus

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Syp Aletris Cordial

1+1+1 بڑا چمچ کھانے کے بعد



METRRRHAGIA / MENORRHAGIA

﴿..... ماہواری کی زیادتی﴾

تعارف (Introduction):

ماہواری عورتوں میں خون کے اخراج کا ایک ماہانہ قدرتی نظام ہے جس میں کسی قسم کی بھی کمی یا زیادتی بیماری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اکثر اوقات عورتوں اور لڑکیوں میں ماہواری میں خارج ہونے والا خون نارمل سے زیادہ ہی بلیڈ ہوتا ہے جسے عام طور پر میٹرورجیا اور مینورجیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا علاج ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

Rx

1. Tab Primolut-N

1+1+1 کھانے کے بعد پندرہ دن تک کھائیں

2. Cap Transamin 500 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Iron Polymaltose

ایک روزانہ

4. Inj Vitamin-K

ایک انجکشن بازو میں لگائیں

☆☆☆

PRE-MENSTRUAL SYNDROME

﴿..... ماہواری سے پہلے اور دوران جسمانی و نفسیاتی شکایات﴾

تعارف (Introduction):

کئی کمزور اور نازک طبع فی میلز میں ماہواری جاری ہونے سے پہلے ہر ماہ جسمانی و نفسیاتی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان شکایات کے نتیجے میں فی میلز بہت چڑچڑی اور نازک مزاج ہو جاتی ہیں۔ اس مرض میں مریضہ کونارمل سے زیادہ ہی کمزور، زیر ناف درد، جسمانی درد اور بخار و کمزوری کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جسے گائنی کی اصطلاح میں پری منسٹروئل سائنڈروم کہتے ہیں۔ اس کا علاج ذیل میں دیا گیا ہے:

Rx

1. Tab Brufen 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Parlodel 5 mg

ایک گولی رات سوتے وقت سائیکل کے 10 سے 26 دنوں تک ہر ماہ استعمال کریں

3. Tab Theragran-M

ایک روزانہ رات کو

4. Tab Prozac

ایک روزانہ صبح ناشتے کے بعد

☆☆☆

MENOPAUSAL SYNDROME

﴿..... سن یاس﴾

تعارف (Introduction):

پچاس سے پچپن سال کی عمر کے درمیان عام طور پر عورتوں میں ماہواری آنے کا نظام بند ہو جایا کرتا ہے جسے مینوپاز کہتے ہیں۔ ماہواری کے نظام کے رُک جانے کے باعث فی میلز میں کچھ علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو کئی عورتوں کے لئے قدرے تکلیف دہ ہو کر تھیں۔ ماہواری بند ہو جانے کے بعد پیدا ہونے والی ان علامات کو مینوپازل سائنڈروم کہتے ہیں جس کا موثر علاج درج ذیل ہے؛

Rx

1. Tab Premarin 0.625 mg

ایک گولی روزانہ صبح کے وقت

2. Tab Primolut-N 5 mg

آدھی گولی روزانہ اوپر والی دواء کے ساتھ استعمال کریں

3. Tab Cac 1000

ایک روزانہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر پیئیں

4. Tab Surbex-Z

ایک روزانہ

☆☆☆

UTERINE FIBROIDS

﴿..... بچے دانی کی رسولیاں﴾

تعارف (Introduction):

اکثر اوقات شادی شدہ عورتوں میں اور کئی مرتبہ کنواری لڑکیوں کے یوٹرس میں رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں یوٹرائن فائبرائڈز کہا جاتا ہے۔ یہ فائبرائڈز عورتوں میں ہیوی بلیڈنگ، بے قاعدہ بلیڈنگ، بچے دانی کے نیچے کی جانب دباؤ، پیلوک پین اور کمر درد کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا اصل علاج تو سرجری ہے لیکن وقتی ادویاتی علاج یہاں درج کر دیا گیا ہے؛ (یوٹرائن فائبرائڈز کا اصل علاج سرجری ہے لیکن درج ذیل ادویات سے وقتی طور پر یوٹرائن بلیڈنگ کو کم کیا جاسکتا ہے)

Rx

1. Cap Brino 500 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Inj Vitamin-K

بلیڈنگ زیادہ ہونے کی صورت میں ایک روزانہ بازو میں لگائیں

3. Calcee Plus Sachets

ایک روزانہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پیئیں

4. Cap Vio-Vioptal

ایک روزانہ استعمال کریں

☆☆☆

CARCINOMA ENDOMETRIUM

..... یوٹرس کی اندرونی سطح کا کینسر ❦

تعارف (Introduction):

عورت کے یوٹرس یعنی بچے دانی کی تین تہیں ہوتی ہیں۔ یوٹرس کی بیرونی تہہ کو پیری میٹریم کہتے ہیں، درمیانی تہہ کو مائیو میٹریم کہتے ہیں جبکہ اندرونی سطح اینڈومیٹریم کہلاتی ہے۔ بعض اوقات یوٹرس کے کینسر میں اینڈومیٹریم کا کینسر لاحق ہو جاتا ہے جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کارسی نو ما اینڈومیٹریم کہا جاتا ہے۔ کارسی نو ما اینڈومیٹریم کا علاج سرجری کے ذریعے یوٹرس، فیلوپین ٹیوبز اور اووریز کا نکال دینا ہے۔ لیکن ایسی عورتیں جو سرجری کے لئے فٹ کیس نہ ہوں تو ان کا علاماتی علاج ریڈی ایشن تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بہر حال درج ذیل ادویات یوٹرائن بلیڈنگ اور درد کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس طرح کئی آنکالوجسٹ ان ادویات کے ساتھ ساتھ پروجیسٹران تھراپی بھی دیتے ہیں۔

Rx

1. Tab Naprosyn 250 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Cap Transamin 500 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Inj Vitamin-K

اگر بلیڈنگ زیادہ ہو تو ایک انجکشن روزانہ بازو میں لگائیں

4. Tab Theragran-H

ایک روزانہ استعمال کریں

.....☆☆☆.....

CARCINOMA CERVIX

﴿..... سرویکس کا کینسر﴾

تعارف (Introduction):

سرویکس عورت کی بچے دانی کا اگلا حصہ ہوتا ہے۔ سرویکس عورت کی بچے دانی اور ویجاہ کو ملانے والا ایک اہم عضو ہے۔ عام طور پر مختلف وجوہات کی بناء پر عورتوں کو سرویکس کے کینسر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جسے کاری نو ماسرویکس کہتے ہیں۔ اس کا علاج آئنا لوجسٹ کے زیر نگرانی کرانا چاہیے۔ سرجری کے ذریعے عورت کی بچے دانی نکال دی جاتی ہے۔ درج ذیل علاج علاماتی طور پر اس مرض میں نافع ثابت ہوا ہے؛

Rx

1. Tab Temgesic 0.2 mg

شدید دردوں میں ایک گولی ہر چھ سے آٹھ گھنٹے بعد زبان کے نیچے رکھیں

2. Cap Transamin 500 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Inj Tramal

بوقت ضرورت شدید درد کے لئے لگائیں

4. Tab Sangobion

ایک روزانہ استعمال کریں

.....☆☆☆.....

ENDOMETRIOSIS

﴿..... اینڈومیٹریوس.....﴾

تعارف (Introduction):

ایسی عورتیں جو بہت زیادہ بچے پیدا کر چکی ہوں یا ایسی عورتیں جن میں بار بار پیریڈز کی خرابیاں واقع ہوا کرتی ہیں اور ان خرابیوں کے نتیجے میں اگر بار بار اور کافی مقدار میں فی میل ہارمونل ڈرگز استعمال کی جائیں تو پھر ایسی عورتوں کی بچے دانی کی اندرونی سطح اینڈومیٹریم میں کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جس کے باعث اینڈومیٹریم کی سطح موٹی ہو کر یعنی ہائپرٹروفیڈ ہو کر پھول سی جاتی ہے اور یہ بچے دانی کی اندرونی غیر ضروری سطحوں تک پھیل جاتی ہے جس کے باعث متاثرہ عورت کو پیریڈز کی خرابیوں کے علاوہ بے تحاشہ پیلوک پیٹن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے گائنا کالوجسٹ تھیراپیونک ڈی اینڈسی تجویز کرتی ہے۔ اگر اینڈومیٹریوس شدید ہے اور اسکی علامات مریضہ کیلئے ناقابل برداشت ہیں تو سرجیکل طریقے سے مریضہ کی بچے دانی، فیلوپین ٹیوبز اور اووریز نکال دی جاتی ہیں۔ اگر کیس زیادہ ڈیولپ نہیں ہے تو درج ذیل ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں:

Rx

1. Tab Danocrine (Danazol) 400 mg

400mg سے 800mg روزانہ 6 سے 9 ماہ تک استعمال کرائیں

یا

اگر مریضہ کو ہلکی قسم کی اینڈومیٹریوس ہے تو یہ دوا استعمال کروائیں

2. Tab Tramal

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Provera

30 یا 40 ملی گرام روزانہ بطور ایک خوراک استعمال کریں

☆☆☆

DYSFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING

﴿..... یوٹرس سے غیر نارمل بلیڈنگ﴾

تعارف (Introduction):

عورت کی بچے دانی یعنی یوٹرس سے نارمل بلیڈنگ کا ہونا ایک فزیولوجیکل فنکشن ہے جس کی ایک عام مثال عورت کو ہر ماہ پیریڈز ہونا ہے لیکن کئی مرتبہ عورت کے یوٹرس سے انتہائی زیادہ اور ہر کچھ دنوں بعد غیر نارمل بلیڈنگ ہوتی ہے جو کہ عورت کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بچے دانی میں کسی ٹیومر، فائبرائیڈز، کینسر یا کسی اور مرض کی موجودگی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی عورت کے یوٹرس سے ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ ہو رہی ہو تو درج ذیل ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ یوٹرس سے اس غیر نارمل بلیڈنگ کی تشخیص بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے تاکہ ایسی عورت کا بنیادی تشخیصی مستقل علاج کیا جاسکے۔

Rx

1. Tab Ponstan Forte

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Cap Transamin 500 mg

2+2 کھانے کے بعد

3. Tab Danazol 10 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Ethamsylate 500 mg

1+1+1+1 دن میں چار مرتبہ

ماہواری سے پانچ دن پہلے شروع کریں اور دس دن تک استعمال کریں

شدید کیسوں میں یہ انجکشن بھی استعمال کریں

5. Inj GnRh Analogves Depot

مہینے میں صرف اور صرف ایک انجکشن بازو میں لگائیں

☆☆☆

DYSPAREUNIA

﴿.....جماع کے دوران درد ہونا.....﴾

تعارف (Introduction):

ہمبستری کے دوران عورتوں کو عموماً قابل برداشت درد ہوا کرتا ہے۔ ہمبستری کے دوران عورتوں کو یہ درد شادی کے شروع دنوں میں واقعی ناقابل برداشت بھی ہوا کرتا ہے لیکن جیسے جیسے عورت کو ہمبستری کی عادت ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے جماع کے دوران یہ درد کم ہوتا چلا جاتا ہے لیکن بعض عورتوں میں کئی بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ہمبستری کے دوران یہ درد نہایت شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے لہذا ایسی عورتوں کی اس شکایت پر مکمل توجہ دیتے ہوئے درست تشخیص کرنی چاہیے کہ آیا یہ درد عورت کو اس قدر زیادہ کیوں محسوس ہوتا ہے جب کچھ تشخیص سامنے آجائے تو اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ عام طور پر جب تک تشخیص نہیں ہوتی تب تک درج ذیل ادویات بھی دوران جماع درد کی اس شدت بھری کیفیت کو کم کرتی ہیں۔

Rx

1. Tab Dicloran 50 mg

1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Hyoscine

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Xanax 0.25 mg

ایک گولی شام سے کھالیں

4. Petroleum Jelly

جماع سے پہلے ویجائنہ میں تھوڑی سی لگالیں

☆☆☆

POST-MENOPAUSAL BLEEDING

﴿.....سن یاس کے بعد ہونے والی بلیڈنگ.....﴾

تعارف (Introduction):

سن یاس یعنی مینوپاؤز عورتوں کی عمر کے اس زمانے کو کہتے ہیں جب فزیولوجیکل طور پر عورت کے جسم میں ہارمونل تبدیلیوں کے باعث حیض یعنی ماہواری خود بخود قدرتی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ عام طور پر سن یاس کا یہ زمانہ عورتوں میں پچاس سے پچپن سال کی عمر میں آتا ہے۔ سن یاس میں عورتوں کو ویجائٹل بلیڈنگ بالکل نہیں ہوتی یعنی ہر ماہ آنے والے مینسز ختم ہو جاتے ہیں لیکن کئی مرتبہ کچھ عورتوں میں سن یاس کا زمانہ آ جانے پر کچھ مہینوں کے لئے تو حیض نہیں آتا لیکن بعد میں پھر ویجائٹل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا عام علاج درج ذیل ہے جبکہ سن یاس کے بعد ہونے والی بلیڈنگ عورت میں کئی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے لہذا اس کی درست طور پر تشخیص کر کے ہی علاج کرنا چاہیے۔

Rx

پہلا علاج

1. Tab Medroxy Progesterone Acetate

10 ملی گرام روزانہ پہلے 21 دن کیلئے ہر ماہ (تین ماہ تک استعمال کریں)

2. Cap Transamin 500 mg

1+1+1 بلیڈنگ کے دوران استعمال کریں

دوسرا علاج

1. Estrogens Therapy

ہر ماہ سائیکل کے پہلے 25 دن روزانہ استعمال کرائیں

2. Progesterone 10 mg

ہر ماہ سائیکل کے آخری 12 دنوں میں اوپر والی دوا کیساتھ ملا کر استعمال کریں اور پھر آخری 5 دن کوئی ہارمون نہ دیں

تیسرا علاج

1. Advice Diagnostic D & C

اس ٹیسٹ کے ذریعے بلیڈنگ ہوئی کی وجہ معلوم کر کے اس کی مطابق علاج کریں

☆☆☆

PRE-MENOPAUSAL ABNORMAL BLEEDING

﴿.....سن یاس سے پہلے ہونے والی غیر نارمل بلیڈنگ.....﴾

تعارف (Introduction):

سن یاس کا زمانہ ہر عورت میں فزیولوجیکل طور پر پچاس سے پچپن سال کی عمر کے درمیان آیا کرتا ہے۔ سن یاس میں عورت کے حیض بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ سن یاس کے زمانے سے کچھ پہلے یعنی سن یاس سے ڈیڑھ دو سال پہلے سے عورت کی ماہواری قدرے کم ہوتے ہوئے آخر کار بالکل بند ہو جاتی ہے لیکن کچھ عورتوں میں سن یاس سے پہلے ماہواری کی بلیڈنگ کم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہے جو کہ ایک خطرناک علامت ہے۔ سن یاس سے پہلے ہونے والی اس غیر نارمل بلیڈنگ کی درست طور پر تشخیص کرنی چاہیے اور تشخیص کے مطابق اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بہر حال ذیل میں علاماتی طور پر اس غیر نارمل بلیڈنگ کا علاج دیا جا رہا ہے۔

Rx

1. Tab Flagyle 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Cap Brino 500 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Iberet Folic

ایک روزانہ

4. Inj Neurobion

خون کی شدید کمی میں ایک انجکشن روزانہ لگائیں

5. Tab Danzen D.S

1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆

UTERINE PROLAPSE

﴿..... یوٹرس کا پرولپس ہونا﴾

تعارف (Introduction):

یوٹرس کے پرولپس کو عام زبان میں عورتیں پیڑ کا نیچے کی جانب زور ہونا، بیان کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں بچے دانی کا زور نیچے کی جانب ہونا، بیان کرتی ہیں، بہر حال اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ عورت کی بچے دانی نیچے کی جانب دباؤ ڈالتی ہے جس کے باعث عورت انتہائی بے چینی اور تکلیف محسوس کرتی ہے۔ عام طور پر پرولپس یوٹرس کی وجہ یوٹرس کے لیگامینٹس یعنی بچے دانی کے پٹھوں کا ڈھیلا پڑ جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مرض ان عورتوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جنہوں نے بہت سے بچے پیدا کئے ہوں۔ موٹی اور فربہ عورتوں میں بھی یہ مرض عام ہے بہر حال کسی گائنا کالوجسٹ کو دکھا کر اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کئی مرتبہ یوٹرس کے لیگامینٹس کو ٹانگے بھی لگائے جاتے ہیں۔ یوٹرس پرولپس کا عام ادویاتی علاج نیچے دے دیا گیا ہے:

Rx

1. Tab Metronidazole 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Syb Femiguard

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Chymotrip

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Polybion

1+1+1 کھانے کے بعد

بوجھ وزن اٹھانے، اونچی ہیل والی چپل پہننے، پیروں کے بل بیٹھنے سے

پرہیز کریں اور اگر وزن زیادہ ہو تو وزن کم کریں

☆☆☆.....

OVARIAN CYST

﴿..... اوویرین سسٹ﴾

تعارف (Introduction):

عورتوں کی بیضہ دانی یا کسی ایک اووری میں پانی کی تھیلی یا سسٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کی تشخیص عموماً پیلوک الٹراساؤنڈ میں ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ اوویرین سسٹ کسی قسم کی کوئی بیماری کی علامات پیدا نہیں کرتی لیکن شاذ و نادر ہی بعض فی میلز میں یہ سسٹ ماہواری کی خرابیاں پیدا کر کے بانجھ پن کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ عام طور پر اوویرین سسٹ کا علاج ہارمونل میڈیسن سے ہو جایا کرتا ہے۔ ذیل میں اوویرین سسٹ کا عام علاج لکھا جا رہا ہے:

Rx

1. Tab Calimin

ایک روزانہ 21 دن تک استعمال کریں، کم از کم تین ماہ تک کورس کریں

2. Tab Iberet Folc

ایک روزانہ

3. Tab Chewcal

ایک روزانہ



MASTITIS

﴿..... چھاتی کی سوجن﴾

تعارف (Introduction):

چھاتی کی سوجن کو میسٹائیٹس کہتے ہیں۔ کنواری لڑکیوں کی بہ نسبت دودھ پلانے والی ماؤں کو یہ مرض عموماً لاحق ہوا کرتا ہے جس کی ایک عام وجہ عورتوں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا ہے کیونکہ دودھ نہ پلانے سے یہی دودھ ماں کے پستان میں بلاک ہو کر جم سکتا ہے اور چھاتی کی سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بریسٹ پر چوٹ لگ جائے یا جراثیم حملہ کر دیں تو بھی چھاتی کے انفیکشن کے نتیجے میں میسٹائیٹس ہو سکتا ہے۔ میسٹائیٹس کا عام موثر علاج یہ ہے:

Rx

1. Cap Lincocin 500 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Danzen D.S

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Mefnec D.S

ایک گولی شام سے کھالیں

4. Tab Revital-B

ایک روزانہ

☆☆☆

CERVICITIS

﴿..... سروی سائی ٹس﴾

تعارف (Introduction):

یوٹرس کا اگلا حصہ سرویکس کہلاتا ہے۔ سرویکس دراصل ویجائنہ اور یوٹرس کے درمیان ایک پل کا سا کام دیتا ہے۔ عورت میں یوٹرس کے اگلے حصے سرویکس کی سوزش بہت عام ہے جسے گائنی کی زبان میں سروی سائی ٹس کہتے ہیں۔ سروی سائی ٹس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ سوزش پھیل کر ویجینی نائی ٹس اور اینڈومیٹرائی ٹس جیسے امراض کا بھی موجب بنتی ہے۔ سروی سائی ٹس ہو جانے کی عام وجوہات میں بیکٹیریل انفیکشن، فنگل انفیکشن، الرجک انفیکشن اور لوکل مانع حمل ادویات کا استعمال شامل ہیں۔ سروی سائی ٹس کا علاج درج ذیل ہے:

Rx

1. Tab Augmentin 625 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Enoxabid 400 mg

1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Brufen 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Flagyle 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

5. Tab Nizoral

دو گولیاں ایک دفعہ صبح 5 دن تک دیں

6. Clotrim Vaginal Cream

ویجائنہ کے اندر دن میں دو بار 7 دن تک لگائیں

☆☆☆

VAGINITIS

﴿..... ویجائنہ کی سوزش﴾

تعارف (Introduction):

عورتوں میں ویجائنہ کی سوزش کو ویجی نائی ٹس کہتے ہیں۔ اس کی عام وجہ ویجائنہ کے انفیکشن ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ انسٹرومینٹل ویجائنٹل انفیکشن، ڈرگز کاری ایکشن، ویجائنہ کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا اور ویجائنہ کے متعلقہ علاقوں کے انفیکشن بھی ویجی نائی ٹس کا سبب بنتے ہیں، ویجائنہ کی سوزش عورتوں اور خصوصاً لڑکیوں کے لئے ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے جس کا فوری اثر علاج درج ذیل ہے؛

Rx

1. Tab Amoxiclav 375 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Chymotrip

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Piriton

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Flagyle 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

5. Syp Lysovit

1+1+1 کھانے کے بعد

6. Daktarin Vaginal Cream

ویجائنہ کے اندر دن میں دو مرتبہ 7 دن تک لگائیں

☆☆☆.....

VULVITIS**﴿..... ولوائی ٹس﴾****تعارف (Introduction):**

عورتوں کے بیرونی اعضائے تناسل کی سوزش کو ولوائی ٹس کہا جاتا ہے۔ ولوائی ٹس کی عام وجوہات میں بیکٹیریل انفیکشن، فنگل انفیکشن، الرجک انفیکشن اور ڈرگزری ایکشن وغیرہ شامل ہیں لیکن کئی مرتبہ اعضائے مخصوصہ کی صفائی ستھرائی کی حالت اچھی نہ ہو تو بھی ولوائی ٹس کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ولوائی ٹس چونکہ ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے لہذا اس کا علاج بھی انتہائی توجہ طلب ہوتا ہے۔ ولوائی ٹس کا نہایت ہی سریع الاثر علاج نیچے بیان کیا گیا ہے؛

Rx**1. Tab Flagyle 400 mg****1+1+1 کھانے کے بعد****2. Tab Danzen D.S****1+1+1 کھانے کے بعد****3. Tab Ponstan Forte****1+1+1 کھانے کے بعد****4. Tab Novidat 250 mg****1+1+1 کھانے کے بعد****5. Clotrimazole Vaginal Cream****ویچائنے کے اندرون میں دو مرتبہ 7 دن تک لگائیں****☆☆☆**

PELVIC INFLAMMATORY DISEASE

﴿..... پیلوک انفلا میٹری ڈیزیز﴾

تعارف (Introduction):

عورت کے پیلوکس میں اس کے اندرونی اعضائے مخصوصہ موجود ہوتے ہیں۔ ان اندرونی اعضائے مخصوصہ میں اووریز، فیلوپین ٹیوبز، یوٹرس اور ویجائنا وغیرہ شامل ہیں۔ بعض اوقات تو ان اندرونی اعضاء کی انفرادی سوزش ہوا کرتی ہے اور کئی مرتبہ پیلوکس میں موجود ان تمام اعضاء کی مشترکہ سوزش ہو جایا کرتی ہے جسے گائنا کولاجیکل ٹرینالوجی میں پیلوک انفلا میٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ پیلوکس میں اعضائے مخصوصہ کا اس طرح سوزش اختیار کر جانا عورت کیلئے انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اگر اس کا علاج توجہ سے نہ کیا جائے تو یہ بیماری کراںک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس بیماری کا بہترین علاج درج ذیل ہے؛

Rx

1. Inj Rocephin 250 mg

صرف ایک انجکشن بازو میں لگائیں

2. Cap Vibramycin 100 mg

1+1 کھانے کے بعد 14 دن تک دیں

3. Tab Flagyle 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Ibuprofen 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

5. Tab Danzen D.S

1+1+1 کھانے کے بعد

6. Cap Pipemedic Acid 400 mg

1+1 کھانے کے بعد چودہ دن تک دیں

☆☆☆

HYPEREMESIS GRAVIDARUM

﴿..... دورانِ حمل زیادہ الٹیاں آنا﴾

تعارف (Introduction):

شادی کے بعد حمل ٹھہرنا ایک قدرتی عمل ہے جسے بیماری نہیں کہا جاسکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ حمل ٹھہر جانے کے بعد عورت میں جنسی ہارمونز میں تبدیلیوں کے باعث بیماری سے مشابہہ کچھ علامات ظاہر ہوا کرتی ہیں جن میں ایک بڑی علامت دل متلانا اور الٹی ہونا ہے۔ ایسا ہارمونز کی زیادتی کے باعث ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر دل کا یہ متلانا اور الٹیاں آنا حمل کی پہلی سہ ماہی میں ہوا کرتا ہے لیکن کچھ نازک مزاج عورتوں میں الٹیوں کا ہونا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے عورت میں کئی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں جن میں لو بلڈ پریشر کا ہو جانا سرفہرست ہے لہذا حمل کے دوران الٹیوں کے زیادہ آنے کیلئے ذیل میں انتہائی موثر نسخہ درج کیا جا رہا ہے:

Rx

1. Inj Gravinate

زیادہ قے ہونے کی صورت میں ایک انجکشن بازو میں لگائیں

2. Tab Gravinate

1+1+1 نہار

3. Tab Stemetil

1+1+1 نہار

4. Syp Lysovit

1+1+1 کھانے کے بعد

5. Syp Infacol

1+1+1 کھانے کے بعد

6. Dextrose 10% I.V Drip

بوقت ضرورت لگائیں

☆☆☆

PRE-ECLAMPSIA & ECLAMPSIA

﴿..... پری ایلکیمپسیا اور ایلکیمپسیا.....﴾

تعارف (Introduction):

دورانِ حمل لاحق ہونے والی یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس میں حاملہ کو گردوں کی انفیکشن اور یورینری انفیکشن ہو کر تمام جسم پر سوجن، اڈیما اور بلڈ پریشر انتہائی حد تک ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر دورانِ حمل خدانخواستہ کسی خاتون کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو فوری طور پر تھیراپیوں کو اپنا کر کے حاملہ کی جان بچائی جاسکتی ہے۔ لہذا اگر کسی بھی حاملہ خاتون میں اس بیماری کا شک ہو تو فوری طور پر اسے ہسپتال ریفر کرنا چاہیے۔ اس بیماری کا عام علاج درج ذیل ہے؛

Rx

1. 5% Dextrose Water I.V

ضرورت پڑنے پر بذر لیجوریڈ لگائیں

2. Inj Lasix

اگر اڈیما زیادہ ہو تو لگائیں

3. Inj Aldomet 250 mg

اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو تو لگائیں

4. Tab Aldomet 250 mg

1+1 بلڈ پریشر کے مطابق دیں

5. Tab Ativan 1 mg

ایک صبح، ایک شام دیں

6. Cap Cefiget 400 mg

ایک روزانہ

☆☆☆

PRE-MATURE LABOUR

﴿..... وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونا﴾

تعارف (Introduction):

اگر کسی حاملہ خاتون میں مقررہ وقت یعنی ایکس پیکٹیڈ ڈیلیوری ڈیٹ سے پہلے ہی ڈیلیوری ہونے کی علامات اور نشانیاں پیدا ہو جائیں تو یہ زچہ اور بچہ دونوں ہی کے لئے خطرناک ہیں۔ لہذا اگر کسی حاملہ خاتون کے ہاں وقت سے پہلے ہی ڈیلیوری ہونے کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو ایسی کا تون کو فوری طور پر ہسپتال ریفر کرنا چاہیے۔ وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کی علامات میں درج ذیل علاج کیا جاتا ہے؛

Rx

1. Tab Phenobarbitone

30 ملی گرام دن میں تین بار دیں

2. Magnesium Sulphate 20% Solution

20cc سلوشن بذریعہ وین دیں۔ اس کے بعد ہر گھنٹے کے اندر

10cc متواتر بذریعہ ڈرپ وین میں دیں

3. Tab Bricanyl

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Xanax 0.25 mg

ایک روزانہ دیں

☆☆☆

PUERPERAL INFECTION

﴿..... زچگی کے بعد انفیکشن﴾

تعارف (Introduction):

زچگی یعنی ڈیلیوری دراصل حاملہ عورت کے لئے ایک ٹرایٹک پروسیجر ہے لہذا اکثر عورتوں میں بچے کی پیدائش کے دوران آنے والے زخموں میں جراثیموں کی سرایت کے باعث انفیکشن ہو جایا کرتا ہے جس کا اگر بروقت اور موثر علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ انفیکشن ترقی پا کر عورت میں نہ صرف جسمانی دردوں بلکہ تیز بخار پیدا کرنے کا بھی باعث بنا کرتا ہے لہذا زچگی کے بعد ایسے انفیکشن سے بچنے کے لئے زچہ کو درج ذیل نسخہ استعمال کرنا چاہیے:

Rx

1. Tab Ciprox 500 mg

1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Panadol

2+2+2 کھانے کے بعد

3. Tab Chymotrip

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Multibionta

ایک روزانہ

☆☆☆.....

BURNING MICTURATION

﴿..... پیشاب کا جلنا﴾

تعارف (Introduction):

پیشاب کے جلنے کی شکایت نہ صرف حاملہ عورتوں بلکہ کنواری اور غیر حاملہ عورتوں میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ پیشاب کا جلنا دراصل عورتوں میں یوریزی ٹریکٹ انفیکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ کئی عورتوں اور لڑکیوں میں پیشاب کی جلن کی علامت مہینوں سے پائی جاتی ہے لہذا ایسی عورتوں میں پیشاب کی اس جلن کو نہایت توجہ سے ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر پیشاب کی یہ جلن زیادہ عرصے تک قائم رہے تو یہ انفیکشن نہ صرف عورتوں کے لئے جینی ٹل ٹریکٹ بلکہ گردوں تک بھی پھیل سکتا ہے، لہذا عورتوں میں پیشاب کا جلنا ایک توجہ طلب مسئلہ ہے۔ اس مرض کے لئے عورتوں کو درج ذیل نسخہ عموماً دیا جاتا ہے؛

Rx

1. Tab Ciproxin 250 mg

1+1 کھانے کے بعد

2. Syp Citralka

1+1+1 ایک گلاس پانی میں ملا کر پیئیں

3. Tab Brufen 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Flagyle 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆

BACKACHE

﴿..... کمر درد﴾

تعارف (Introduction):

کمر درد کی شکایت نہ صرف عورتوں بلکہ حاملہ عورتوں اور نوجوان لڑکیوں میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ عام طور پر نوجوان لڑکیوں میں کمر درد کی شکایت لیکوریا کے باعث زیادہ پائی جاتی ہے۔ حاملہ عورتوں میں پیٹ میں موجود بچے کے وزن اور زچگی کے دوران کمر پر زور پڑنے کے باعث کمر درد زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں زیادہ بھاری کام کرنے، غلط انداز میں لیٹنے، موٹاپے اور کیلشیم کی کمی کے باعث بھی کمر درد ہوا کرتا ہے۔ بہر حال کمر درد کی وجہ کچھ بھی ہو اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج موثر طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں درج ذیل نسخہ نافع رہتا ہے؛

Rx

1. Tab Arnil 75 mg

1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Chewcal

ایک روزانہ چوسیں

3. Cap E-Vion 400 mg

ایک روزانہ

4. Voltral Emulgel

صبح، شام کمر پر مالش کریں

☆☆☆

OBESITY

﴿..... موٹاپا﴾

تعارف (Introduction):

موٹاپا عصر حاضر کا ایک انتہائی عام اور تکلیف دہ مرض ہے۔ ایک طرف جہاں موٹاپا انسانی وضع قطع اور خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے تو دوسری جانب اسی موٹاپے کے مرض کے باعث کئی دوسرے امراض مثلاً ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، ذیابیطس، جوڑوں کے درد، کمر درد وغیرہ کا بھی موجب بنتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی عورتوں میں بانجھ پن اور ماہواری کی دوسری خرابیوں کی بھی ایک بڑی وجہ موٹاپا ہی ہوتا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لئے خوراک میں احتیاط اور ورزش کے ساتھ ساتھ درج ذیل نسخہ اکسیر ثابت ہوا ہے:

Rx

1. Tab Glucophage 500 mg

1+1+1 نہار

2. Tab Neurobion

ایک روزانہ

3. Tab Abocal

ایک روزانہ چوبیس

☆☆☆

ANAEMIA

﴿..... خون کی کمی﴾

تعارف (Introduction):

خون کی کمی یعنی انیمیا عورتوں کے لئے ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ خون کی کمی کے باعث جسم میں قوتِ مدافعت بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور جسم دوسرے انفکشنوں اور بیماریوں کو حملہ آور ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ حاملہ عورتوں میں خون کی کمی نہ صرف ان کے اپنے لئے خطرناک ثابت ہوتی ہے بلکہ خون کی کمی کے باعث پیٹ میں موجود بچے کی نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح خون کی شدید کمی کی شکار عورتوں میں ڈیلیوری کے دوران بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ عورتوں اور لڑکیوں میں خون کی کمی کے لئے درج ذیل نسخہ دینا چاہیے:

Rx

1. Tab Iron-Polymaltose

ایک روزانہ چوبیس

2. Tab Revital Multi

ایک روزانہ کھانے کے بعد

3. Tab Iberet Folic

ایک روزانہ کھانے کے بعد

4. Syp Haemoglobin

1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆

HYPOCALCAEMIA

﴿.....کیلشیم کی کمی.....﴾

تعارف (Introduction):

کیلشیم کی کمی کے باعث جسم میں متعدد امراض جنم لیتے ہیں۔ عورتوں میں کیلشیم کی مقدار کم ہونے کے باعث ہڈیوں، جوڑوں، دردوں، بالوں اور ناخنوں کے امراض سامنے آتے ہیں جبکہ حاملہ عورتوں میں کیلشیم کی کمی کے باعث یوٹرس میں موجود بچے کی ہڈیوں کی نشوونما میں کمی آسکتی ہے۔ اسی طرح زچہ عورت میں کیلشیم کی کمی کے باعث پستانوں میں دودھ کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اکثر لڑکیوں میں لیکوریا کی بیماری ایک بڑی وجہ خون اور جسم میں کیلشیم کی کمی ہوا کرتی ہے۔ عام طور پر گائنا کالوجسٹ حمل کے پہلے ہی ماہ سے حاملہ خواتین کو کیلشیم سپلیمنٹ تجویز کرتی ہیں۔ کیلشیم کی کمی کے لئے روزانہ دودھ لینے کے ساتھ ساتھ درج ذیل نسخہ بھی اہمیت کا حامل ہے:

Rx

1. Tab Cac 1000

ایک روزانہ پانی میں ملا کر پیئیں

2. Tab Abocal

ایک روزانہ چوسئیں

3. Syb Calcium-P

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Neurobion

1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆

MENOPAUSAL SYNDROME

﴿..... مینوپازل سائنڈروم﴾

تعارف (Introduction):

عورتوں میں پچاس سے پچپن سال کی عمر کے درمیان سن یاس یعنی مینوپاز واقع ہوا کرتا ہے۔ مینوپاز میں عورتوں کو ہر ماہ آنے والی ماہواری یا تو یکدم یا پھر بتدریج کم ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں میں ماہواری بند ہونے کے باعث کچھ جسمانی اور نفسیاتی علامات رونما ہو جاتی ہیں جن میں ہڈیوں کا بھر بھرا ہو جانا، گرمی کا زیادہ لگنا، تمام جسم میں جلن سی محسوس ہونا، چڑچڑاپن، بھوک کا اڑ جانا، عام جسمانی دردیں ہونا، ٹھنڈی اشیاء کی خواہش وغیرہ شامل ہیں۔ میڈیکل ٹرینالوجی میں سن یاس کے بعد عورت میں ان علامات کے اظہار کو مینوپازل سائنڈروم کہا جاتا ہے جس کا تیر بہدف علاج درج ذیل ہے؛

Rx

1. Tab Calcee Plus

ایک ساشے روزانہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پیئیں

2. Tab Chewcal

ایک روزانہ چوسیں

3. Tab Theragran N.V

1+1 کھانے کے بعد

4. Tab Multibionta

ایک روزانہ

☆☆☆

FRIGIDITY

﴿..... عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی﴾

تعارف (Introduction):

کئی عورتوں میں جنسی عمل کی جانب رغبت کم ہوا کرتی ہے جس کے باعث ان کی فیملی لائف متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ادویات سے زیادہ ایسی عورتوں کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی عورت کے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر جائز بات مانے، اُسے حوصلہ دے، اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرے، اس پر مکمل توجہ دے اور اس کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی بیوی سے جنس کے موضوع پر کھل کر بات کرے اور اس کا ہر قسم کا خوف دور کرنے کی کوشش کرے اس طرح درج ذیل ادویات کے ساتھ اچھا رزلٹ ملتا ہے؛

Rx

1. Tab E-vion 400 mg

ایک روزانہ

2. Tab Xanax 0.25 mg

ایک روزانہ رات

3. Tab Neurovit

1+1 کھانے کے بعد

4. Spanish Fly Drops

15+15+15 قطرے کھانے سے پہلے نہار

(یہ فرانس کی بنی ہوئی ایک ہومیو پیتھک دوا ہے جو عورتوں میں زبردست جنسی رغبت پیدا کرتی ہے)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

LEUCORRHOEA

﴿..... لیکوریا﴾

تعارف (Introduction):

لیکوریالڑکیوں اور عورتوں میں پائے جانے والی ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری میں عورتوں کی شرمگاہ سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے جس کے ساتھ مریضہ کو کمر اور ٹانگوں میں درد سار ہوتا ہے، طبیعت سُست ہو جاتی ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور آنکھوں کے نیچے حلقے سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مرض اگر پرانا ہو جائے تو مریضہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی صحت عامہ بگڑ جاتی ہے۔ شادی شدہ عورتوں میں لیکوریا کی زیادتی کے باعث کئی مرتبہ حمل بھی نہیں ٹھہرا کرتا۔ لیکوریا کے مرض کی درست تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس مرض کا انتہائی موثر علاج درج ذیل ہے؛

Rx

1. Tab Flagyle 400 mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Cap Cefspan 400 mg

ایک روزانہ کھانے کے بعد

3. Cap Icon 100 mg

ایک روزانہ کھانے کے بعد

4. Tab Dicloran 50mg

1+1+1 کھانے کے بعد

5. Clotrima Vaginal Cream

صبح، شام و بچائے میں لگائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

PRURITIS VULVAE

﴿..... شرمگاہ کی خارش﴾

تعارف (Introduction):

اس مرض میں خواتین کو شرمگاہ پر شدید خارش ہوا کرتی ہے اور اکثر اوقات رات کے وقت یہ خارش زیادہ شدید ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ مرض ایک خاص جراثیم ”ٹرائی کوموناس ویجی نیلس“ کی انفیکشن کے باعث لاحق ہوا کرتا ہے لیکن کئی مرتبہ یہ مرض صابن، ادویات، نائلون کے کپڑے پہننے، مانع حمل ادویات کے استعمال اور جراثیم کش ادویات کے باعث بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح ذاتی طور پر گندار ہنے اور ذیابیطس کے مرض کی پیچیدگی کے طور پر بھی شرمگاہ کی خارش لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کا فوری اثر علاج ذیل میں دے دیا گیا ہے:

Rx

1. Tab Avil

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Novidat 250 mg

1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Deltacortril 0.5 mg

2+2 کھانے کے بعد

4. Tab Nilstat Vaginal

ایک صبح، ایک شام اندام نہانی میں رکھیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

FEMALE STERILITY

﴿..... عورتوں کا بانجھ پن﴾

تعارف (Introduction):

شادی کے دو سال بعد تک خاوند کے ساتھ باقاعدہ جنسی تعلقات رکھنے کے باوجود اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اسے بانجھ کہتے ہیں جبکہ اس مرض کو بانجھ پن کہا جاتا ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن کی وجوہات اور تشخیص سے متعلق گزشتہ ابواب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں عورتوں کے بانجھ پن سے متعلق شافی علاج بیان کیا جا رہا ہے:

Rx

1. Tab Clomid

ایک گولی ماہواری ختم ہونے کے بعد سے دس دن تک روزانہ ہر ماہ دیں

2. Cap E-Vion 400 mg

ایک کپسول روزانہ کچھ ماہ استعمال کرائیں

3. Syp Gynoguard

1+1+1 کھانے کے بعد

4. Cap Fefol Vit

ایک روزانہ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

MILK FEVER

﴿..... دودھ کا بخار﴾

تعارف (Introduction):

اس مرض میں بچے کی پیدائش کے بعد زچہ کی چھاتیوں میں دودھ سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور زچہ کو لرزے کیساتھ بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس مرض کی خاص وجہ زچہ کی چھاتیوں میں دودھ کا زیادہ پیدا ہونا ہے جسکی وجہ سے چھاتیوں میں موجود خون کی باریک رگیں دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور مریضہ کو کمر درد، جسم درد اور دُکھن کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے اور ٹھنڈی لگتی ہے۔ اسی طرح جب زچہ کی چھاتیوں سے دودھ نکل جاتا ہے تو بخار رفع ہو جایا کرتا ہے، بہر حال اس کیلئے تیر بہدف نسخہ درج ذیل ہے؛

Rx

1. Cap Amoxil 500mg

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Chymoral

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Panadol

2+2+2 کھانے کے بعد

4. Olive Oil

صبح، شام ہلکے ہاتھ سے چھاتیوں پر مالش کریں

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

SUPPRESSED MILK

﴿..... دودھ کی کمی﴾

تعارف (Introduction):

اس میں زچہ کی چھاتیوں میں بعض اوقات دودھ اتنا پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ یہ مرض پہلے سے کچھ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے مثلاً خون کی کمی، کمیشن کی کمی، ڈیلوری کے بعد پرولیکٹن ہارمون کی کمی کے باعث زچہ کے پستانوں میں دودھ کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ زچہ میں دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لئے دودھ پلائیں، طاقتور غذائیں کھلائیں، موسمی سبزیاں، پھل اور فروٹ دیں اور درج ذیل ادویات کا استعمال کرائیں:

Rx

1. Tab Hilecta

ایک روزانہ کھانے کے بعد

2. Tab E-Vion 400 mg

ایک روزانہ کھانے کے بعد

3. Tab Trihemic

ایک روزانہ کھانے کے بعد

4. Tab Kak-D

ایک روزانہ کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

GENERALIZED WEAKNESS

﴿..... عام جسمانی کمزوری﴾

تعارف (Introduction):

عورتوں میں کئی مرتبہ کسی خاص مرض کی موجودگی کے بغیر عام جسمانی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں لڑکیوں یا عورتوں کو ہر وقت سُستی، کابلی اور تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ پیلا اور آنکھوں کے ارد گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں جسمانی وزن اور فکردن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ایسی خواتین اور لڑکیوں کے چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے۔ عموماً اس مرض کی ایک بڑی وجہ جسم میں خون کی کمی ہوا کرتی ہے۔ خواتین میں عام جسمانی کمزوری کے لئے درج ذیل نسخہ اسیر کی سی حیثیت رکھتا ہے؛

Rx

1. Syp Faulad

1+1+1 کھانے کے بعد

2. Tab Theragran-H

ایک روزانہ کھانے کے بعد

3. Calcee Plus Sachets

روزانہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پیئیں

4. Syp Surbex

1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

CHEST INFECTION IN PREGNANCY

﴿..... حاملہ کے سینے کا انفیکشن﴾

تعارف (Introduction):

کئی مرتبہ حاملہ عورت کو سینے کا انفیکشن ہو جایا کرتا ہے۔ حاملہ کے سینے کے انفیکشن کے باعث اگر حاملہ کو شدید کھانسی ہو تو اس سے حاملہ کا انٹرایڈامینٹل پریشر زیادہ بھڑاپ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے جس سے نہ صرف خود حاملہ کے سینے اور پیٹ کے مسلز میں دھکن اور روکی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ یوٹرس میں موجود بچے کو بھی نقصان پہنچ کر خدانخواستہ ابارشن کا خطرہ ہو سکتا ہے لہذا اگر حاملہ کو سینے کا انفیکشن لاحق ہو جائے تو اس پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے درج ذیل علاج کرنا چاہیے:

Rx

1. Syp Sancos

1+1+1 چمچہ کھانے کے بعد

2. Cap Amoxial 500 mg

1+1 کھانے کے بعد

3. Tab Ascorban 500 mg

ایک روزانہ چوسیں

4. Tab Softin 10 mg

ایک روزانہ کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

SEXUAL FATIGUE

﴿..... جنسی تھکاوٹ﴾

تعارف (Introduction):

عورت اور مرد کو آپس میں سیکس کرنے کے بعد جو جسمانی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اُسے سیکشونل فٹیک یعنی جنسی تھکاوٹ کہتے ہیں۔ جنسی تھکاوٹ عام طور پر عورت اور مرد کو چالیس سال کی عمر کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو جنسی تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جنسی تھکاوٹ کی یہ تکلیف اکثر اوقات سیکس کی زیادتی کے باعث بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد و عورت کے دن میں جسمانی و دماغی محنت اور مشقت کے بعد جنسی ملاپ کے لئے رات کو دیر تک جاگنے سے بھی جنسی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اکثر اوقات عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی، کسی پرانی بیماری کی جسم میں موجودگی اور غیر متوازن خوراک کے باعث بھی جنسی تھکاوٹ کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے جس کا بہترین، شافی، موثر اور مستقل علاج درج ذیل ہے:

Rx

1. Syp B-Complex

1+1+1 چھ کھانے کے بعد

2. Tab Neurobion

1+1+1 کھانے کے بعد

3. Calcee Plus Sachets

روزانہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پیئیں

4. Cap E-Vion 400 mg

ایک روزانہ کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

HYPERTENSION IN PREGNANCY

﴿..... حمل کے دوران بلند فشارخون﴾

تعارف (Introduction):

کئی مرتبہ حاملہ عورت کا بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ ہو کر اچانک بڑھ سکتا ہے۔ دورانِ حمل حاملہ کا بلڈ پریشر اس طرح اچانک بڑھ جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے بلکہ بغیر کسی وجہ کے حاملہ کے بلڈ پریشر کے بڑھ جانے کے باعث پری ایکلمپشیا اور ایکلمپشیا کی کنڈیشن سامنے آ سکتی ہے جس کے باعث ایمرجنسی طور پر حاملہ کا تھیراپیونک ابارشن کرنا پڑ سکتا ہے بہر حال وجہ کچھ بھی ہو حاملہ کا بلڈ پریشر بڑھنا ماں اور بچے دونوں کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے لہذا اس صورت میں درج ذیل فوری اثر علاج کرنا چاہیے؛

Rx

1. Tab Aldomet 250 mg

ایک روزانہ کھانے کے بعد

2. Tab Xanax 0.25 mg

ایک روزانہ رات

3. Tab Lasix 40 mg

ایک گولی بوقت ضرورت اگر پیشاب آوردوا کی ضرورت ہو

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

یونٹ: 28

نارمل لیبارٹری ویلیوز (NORMAL LABORATORY VALUES)

خون کی کیمسٹری (BLOOD CHEMISTRY)

NORMAL HAEMATOLOGICAL VALUES

خون کی نارمل ویلیوز

NAME	REFERENCE VALUES
Bleeding Time (Ivy)	Up to 11 min
Blood volume	
Red cell mass, Men	30 + 5 ml / kg
Women	25 + 5 ml / kg
Plasma volume (both sexes)	45 + 5 ml / kg
Total blood volume, Men	75 + 10 ml / kg
Woman	70 + 10 ml / kg
Folate - serum	2 - 20 Micro g/l
Red cell	> 100 Micro g/l
Haemoglobin, Men	14 - 16 g / dl
Women	12 - 14 g / dl
Leucocytes - adults	4000 - 11000 mm ³
Differential white cell count	
Neutrophil (granulocytes)	66 %
Lymphocytes	25 %
Monocytes	5 %
Eosinophil granulocytes	3 %
Basophil granulocytes	1 %
Mean corpuscular haemoglobin (MCH)	27 - 32 pg
Mean corpuscular haemoglobin Concentration (MCHC)	30 - 35 g / dl
Mean corpuscular volume (MCV)	78 - 98 fl
Packed cell volume (PCV) or Haematocrit, Men	0.40 - 0.54 l/l
Women	0.37 - 0.47 l/l
Platelets	150,000 - 400,000 / mm ³
Red cell count, Men	450,000 - 650,000 / mm ³
Women	380,000 - 580,000 / mm ³
Red cell life span (mean)	120 days



LIVER PROFILE

جگر کے ٹیسٹ

NAMEREFERENCE VALUES

Bilirubin total

0 - 1.0 mg / dl

Bilirubin direct

0 - 0.3 mg / dl

Bilirubin indirect

..... mg / dl

ALT (GPT)

up to 40 U / L

Alk. Phos (Adult)
(Child)

up to 117 U / L

up to 390 U / L

Total Proteins

6.0 - 8.0 gm / dL

Albumin

3.5 - 5.0 gm / dL

Globulin

2.0 - 3.0 gm / dL

A/G ratio

1.1 - 2.2



RENAL PROFILE

گردوں کے ٹیسٹ

NAMEREFERENCE VALUES

Urea

20 - 45 mg / dL

Creatinine

0.5 - 1.5 mg / dL

Calcium

9 - 11 mg / dL

Phosphorous

2.5 - 4.5 mg / dL



CARDIAC PROFILE

دل کے ٹیسٹ

NAMEREFERENCE VALUES

AST (GOT)

up to 35 U / L

LDH

up to 460 U / L

CPK

up to 195 U / L



LIPIDS PROFILE

چکنائیوں کے ٹیسٹ

NAME

Total lipids

Cholesterol

Triglyceride

H.D.L

L.D.L

REFERENCE VALUES

500 - 1000 mg /dL

150 - 250 mg /dL

50 - 150 mg /dL

>35 mg /dL

<160 mg /dL



SERUM ELECTROLYTES

سیرم کے نمکیات

NAME

Sodium

Potassium

Chloride

Bicarbonate

REFERENCE VALUES

136 - 148 mmol / L

3.8 - 5.0 mmol /L

96 - 107 mmol / L

25 - 29 mmol /L



MISCELLANEOUS

متفرق ٹیسٹ

NAME

Glucose (Fasting)

Glucose (Random)

Uric Acid, Male

Female

Acid Phosphatase

Amylase

REFERENCE VALUES

70 - 110 mg / dL

110 - 140 mg / dL

5 - 7.0 mg / dL

2 - 6.0 mg / dL

up to 4.7 U / L

up to 390 U / L



طبی معلومات عامہ

(GENERAL MEDICAL KNOWLEDGE)

فزیو تھراپی

(PHYSIOTHERAPY)

تعارف (Introduction): فزیو تھراپی میڈیکل سائنس کی وہ شاخ ہے کہ جس میں دواؤں کے بجائے مختلف طبعی ورزشی طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ فزیو تھراپی دراصل دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ فزیو یعنی طبعی اور تھراپی یعنی علاج۔ لہذا فزیو تھراپی کا مطلب ہے طبعی علاج۔ فزیو تھراپی میں جو طبعی طریقے بیماری کو ٹھیک کرنے کیلئے استعمال کئے جاتے ہیں ان میں حرارت، شعاعیں، بجلی، ورزش، مالش، برف، پانی اور ارتعاش وغیرہ شامل ہیں۔ فزیو تھراپی کے تمام طریقے جدید سائنسی اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ فزیو تھراپی یوں تو سینکڑوں امراض میں موثر ثابت ہوئی ہے لیکن خصوصی طور پر جسم کے کسی حصے کی جانب دوران خون بڑھانے، درد کو ختم کرنے، پٹھوں، اعصاب اور رگوں کو طاقت دینے، جسمانی فابجی کیفیات دور کرنے، ہاتھ، پیروں یا جسم کی دیگر بد وضع حالتوں کو درست کرنے، بیماری یا زخم سے جلدی بہتری کا امکان پیدا کرنے کیلئے کی جاتی ہے۔ غرضیکہ فزیو تھراپی سے جن امراض میں بہترین نتائج حاصل کئے جا رہے ہیں ان میں درد، سوجن، اعصابی درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا کھنچاؤ، گردن و کمر کے مہروں کی ٹکالیف، پولیو فلیج، سوکھا پن، رگوں اور پٹھوں کی کمزوری، کمر میں خم آنا، عرق النساء، آپریشن کے بعد کی کمزوری و ٹکالیف، چوٹ اور فریکچر وغیرہ شامل ہیں۔ فزیو تھراپی میں کسی بھی بیماری کا علاج عام طور پر دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو علاج بذریعہ ورزش ہے اور دوسرا طریقہ علاج بذریعہ مشین ہے۔ فزیو تھراپی میں عام طور پر استعمال ہونے والے طریقے درج ذیل ہیں۔



شارٹ ویوڈ ایا تھرمی

(SHORT WAVE DIATHERMY)

تعارف (Introduction): فزیو تھراپی کے اس طریقے میں حرارت پیدا کی جاتی ہے جو بعد ازاں پٹھوں اور ہڈیوں کی گہرائی تک پہنچائی جاتی ہے اور یوں متاثرہ پٹھوں و ہڈیوں میں امراض کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔



برقی تحریک

(ELECTRIC STIMULATION)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کے اس طریقے میں ایک مشین الیکٹرک سٹیمولیٹر کے ذریعے متاثرہ پٹھوں کو برقی تحریک دی جاتی ہے۔



الٹرا وائلٹ شعاعیں

(ULTRA VIOLET RAYS)

تعارف (Introduction): الٹرا وائلٹ شعاعیں بہت ہی طاقتور شعاعیں ہوتی ہیں جو دراصل وافع سوزش اثرات رکھتی ہیں۔ جن امراض میں پٹھوں کی سوزش کو دور کرنا ہو تو ان شعاعوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔



انفراریڈ شعاعیں

(INFRA RED RAYS)

تعارف (Introduction): یہ شعاعیں الٹرا وائلٹ شعاعوں کی نسبت زیادہ گہری نہیں ہوتیں اور ان سے حاصل شدہ حرارت پٹھوں کی بیرونی اور درمیانی سطح تک ہی پہنچتی ہے۔



الٹراسونک لہریں

(ULTRA SONIC WAVES)

تعارف (Introduction): الٹراسونک ویوز درد کو کم کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان لہروں سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ جو پٹھوں سے ہوتا ہوا ہڈیوں تک پہنچتا ہے اور ان سے مریض کے درد کی شدت کو کم کیا جاتا ہے۔



انٹرفیئرینشیل کرنٹ

(INTERFERENTIAL CURRENT)

تعارف (Introduction): اس سے بھی ایک خاص قسم کا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ جو درد کو فوری طور پر آرام پہنچاتا ہے۔ یہ کرنٹ عام طور پر چوٹ، موج اور سپورٹس انجری میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو تکلیف کی شدت میں فوری طور پر آرام مل سکے۔



برقی مساج

(ELECTRIC MASSAGE)

تعارف (Introduction): برقی مساج سے مریض کے پٹھوں اور عضلات میں صرف بیرون سطح تک پہنچنے والا ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو بہترین سکون آور ہوتا ہے۔



موم کا علاج

(WAX THERAPY)

تعارف (Introduction): اس طریقے میں گرم موم کے ذریعے جسم کے متاثرہ پٹھوں کو براہ راست نہایت ہی آسانی سے حرارت پہنچائی جاسکتی ہے۔ جو پٹھوں کی بیماریوں اور کمزوری کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔



ورل پول باتھ

(WHIRL POOL BATH)

تعارف (Introduction): فزیو تھراپی کے اس طریقے میں دھات کے ایک برتن میں تیزی سے گھومتے ہوئے پانی میں ہاتھ باز و پاؤں یا ٹانگ بھگونے سے پانی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔



برف کے ذریعہ علاج

(ICE THERAPY)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کے اس طریقے میں برف کے ذریعے چوٹ، موج، سو جن اور درد کا مؤثر علاج کیا جاتا ہے۔



پانی سے علاج

(HYDROTHERAPY)

تعارف (Introduction): ہائیڈرو تھراپی یعنی پانی کے ذریعے جوڑوں اور پٹھوں کی حرکت بڑھائی جاسکتی ہے اور اس کے علاوہ ہائیڈرو تھراپی سے درد کا بھی مؤثر ترین علاج کیا جاتا ہے۔



مالش

(MASSAGE)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کے اس طریقے میں کسی بھی مقوی تیل کے ذریعے مالش کرنے سے درد کو کم یا ختم کیا جاسکتا ہے۔ تیل کے ذریعے مالش کا طریقہ کسی بھی عضو میں دوران خون بڑھانے اور عضلات و جوڑوں کی سختی دور کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔



ورزش

(EXERCISE)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کے اس طریقے میں مریض کو مختلف جوڑوں پر ضرورت کے مطابق ورزش کرائی جاتی ہے۔ جس سے مریض کو درد اور فالج کی کیفیت میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔



حرارت سے علاج

(HEAT THERAPY)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کے تمام طریقوں میں حرارت سے علاج کی خاص اہمیت ہے۔ حرارت سے خون کی نالیاں پھیلتی ہیں جس سے متاثرہ عضو کی جانب دوران خون بڑھ جایا کرتا ہے۔ حرارت سے عضلات کے تناؤ میں کمی واقع ہوا کرتی ہے اور یوں پٹھوں اور ہڈیوں کو زیادہ خون ملنے سے ان کی نشوونما بہتر ہوتی ہے اور انہیں مضبوطی ملتی ہے۔



ٹھنڈک سے علاج

(COLD THERAPY)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کے اس طریقے میں چوٹ کے مقام پر ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے اس لئے اسے کولڈ تھراپی کہتے ہیں۔ کولڈ تھراپی میں عام طور پر ٹھنڈک کیلئے ایتھائل کلورائیڈ اسپرے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو دراصل ایک محلول ہوتا ہے جو جلد پر لگنے کے بعد بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور اس طرح جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ علاج کا زیادہ تر تعلق اسپورٹس انجری یعنی کھیلوں کے دوران لگنے والی چوٹوں سے ہے۔ اس ٹھنڈک کے ذریعے جلد کے درجہ حرارت کو 10 درجے سینٹی گریڈ تک کم کر دیا جاتا ہے۔



مائیکرو ویوڈیا تھرمی

(MICROWAVE DIATHERMY)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی کا یہ طریقہ بھی دراصل شارٹ ویوڈیا تھرمی کی طرح کا ہی حرارت کے ذریعے علاج ہے۔ اس کی لہروں کی ویولینٹھ، انفراریڈ اور شارٹ ویوڈیا تھرمی کے درمیان ہوتی ہے۔ مائیکرو ویوڈیا تھرمی بہ نسبت پھیلے ہوئے یا گہرائی میں موجود امراض کے، مقامی امراض کیلئے زیادہ مفید ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر چوٹ، موج، سوزش، جراثیمی سوزش اور سطحی وچھوٹے جوڑوں کے درد اور ورم میں مفید ہے۔



فیراڈک کرنٹ

(FARADIC CURRENT)

تعارف (Introduction): یہ فیراڈک کوائل سے حاصل ہونے والا نیچی فریکوئنسی کا کرنٹ ہے جسے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ موثر نیوران کو تحریک دیتا ہے جس سے پٹھوں میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل فیراڈک کوائل کی جگہ الیکٹرانک اسٹیمولیٹر استعمال ہوتے ہیں جن سے ویسا ہی کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اثر بھی بالکل وہی ہیں۔



گیلوانک کرنٹ

(GALVANIC CURRENT)

تعارف (Introduction): یہ متواتر اور ایک ہی سمت جانے والا یونی ڈائریکشنل کرنٹ ہے۔ گیلوانک کرنٹ کے استعمال سے خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں جس کی وجہ سے دوران خون بڑھ جاتا ہے اور متاثرہ عضو کو آکسیجن کی فراہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باریک نسوں کی دیواروں کی جاذبیت بڑھ جاتی ہے۔ گیلوانک کرنٹ کا اثر صرف سطحی پٹھوں تک ہی ہوتا ہے جبکہ گہری سطح پر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لئے گیلوانک کرنٹ کی اہمیت کافی گھٹنے کے جوڑ اور ایڑھی کے جوڑ میں زیادہ ہے۔



انٹرفیرینشیل تھراپی

(INTERFERENTIAL THERAPY)

تعارف (Introduction): یہ الیکٹریکل تھراپی کا ایک طریقہ ہے جس میں علاج کیلئے درمیانے درجے یعنی میڈیم فریکوئنسی کے دو کرنٹ استعمال کر کے ہلکے درجے کا اثر ٹشو کی گہرائی تک پہنچایا جاتا ہے جو جلد کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ تھراپی درد دور کرنے، سوجن کم کرنے اور عضلات و پٹھوں کی تحریک میں موثر ہے۔ کئی مرتبہ مریضوں میں پرانی چوٹوں کے بد اثرات کے طور پر جسمانی ٹشو کے اندر سوجن اور سوزش رہ جاتی ہے جسے انٹرفیرینشیل تھراپی کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے۔

فزیوتھراپی کے فوائد: فزیوتھراپی کے درج ذیل فوائد ہیں:

☆.....	فزیوتھراپی غیر ادویاتی علاج ہے۔
☆.....	یہ ایک تسلیم شدہ طریقہ علاج ہے۔
☆.....	ادویات کے ساتھ ساتھ اس طریقہ علاج سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
☆.....	فزیوتھراپی کے کوئی مابعد اثرات بد نہیں ہوتے۔
☆.....	فزیوتھراپی کے ذریعے کئی امراض کا موثر علاج کیا جاسکتا ہے۔
☆.....	فزیوتھراپی کی بروقت امشاق کئی مستقل معذوری کی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔
☆.....	فزیوتھراپی کے ذریعے فالج، پولیو اور سوکھے کی بیماری کا موثر ترین علاج کیا جاسکتا ہے۔
☆.....	فزیوتھراپی کے علاج پر کچھ زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے۔
☆.....	ماہر فزیوتھراپسٹ کی زیر نگرانی اس طریقہ علاج سے انتہائی زیادہ حد تک فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
☆.....	فزیوتھراپی کلینک ہر شہر میں جا بجا موجود ہیں۔
☆.....	شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں فزیوتھراپی یونٹ سرکاری طور پر قائم ہیں جن سے مریضوں کی ایک بڑی تعداد استفادہ حاصل کر رہی ہے۔
☆.....	پرانی بیماریوں میں مبتلا ایسے مریض جو عرصہ دراز سے بستر پر پڑے ہوئے ہوں فزیوتھراپی انہیں کئی اقسام کی پیچیدگیوں سے بچا لیتی ہے
☆.....	عرصہ دراز سے بستر پر پڑے ہوئے معذور مریضوں میں فزیوتھراپی مسلسل کرانے سے بستر ی زخم یعنی بید سور نہیں ہوا کرتے۔
☆.....	فزیوتھراپی کرانے سے متاثرہ پٹھے ہڈیاں، اعصاب اور نسیں ایک نئی طاقت و زندگی محسوس کیا کرتے ہیں۔
☆.....	فزیوتھراپسٹ سے فزیوتھراپی کرانے کے بعد یہی فزیوتھراپی گھر میں خود بھی کی جاسکتی ہے۔



درجہ حرارت

(TEMPERATURE)

تعارف (Introduction): انسانی جسم میں درجہ حرارت زندگی کی علامت ہے۔ جسمانی خلیات میں کیمیائی تعاملات میٹابولزم کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہی حرارت جسمانی درجہ حرارت کہلاتی ہے۔ عام طور پر ایک نارمل انسانی جسم کا درجہ حرارت 98.6 ڈگری فارن ہیٹ ہوا کرتا ہے لیکن میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے 97 ڈگری سے لیکر 99 ڈگری فارن ہیٹ تک ٹھیک نارمل ہی ہوتا ہے۔ جب جسمانی درجہ حرارت نارمل سے بڑھ جائے تو ایسی حالت کو بخار کی حالت یا فیورس کنڈیشن کہا جاتا ہے۔ اگر بخار کی حالت زیادہ بڑھ جائے تو اسے ہائپر تھرمیا کہتے ہیں اور اگر اسی طرح جسمانی درجہ حرارت گر جائے یعنی کم ہو جائے تو ایسی حالت کو ہائپو تھرمیا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص میں بخار بڑھ جانے کی نسبت درجہ حرارت کا کم ہو جانا زیادہ خطرے کی علامت ہے اور اس کا فوری علاج کرنا چاہئے، نہیں تو انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔



تھرمامیٹر

(THERMOMETER)

تعارف (Introduction): تھرمامیٹر شیشے کی بنی ہوئی ایک پتلی سی ٹلی ہوتی ہے جس کی لمبائی تقریباً چار انچ ہوتی ہے۔ اس ٹلی کے شروع کے سرے پر جو کہ پتلا ہوتا ہے، 94 سے لیکر 108 ڈگری فارن ہیٹ تک نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کسی شخص کا درجہ حرارت ناپنا مقصود ہو تو اس ٹلی کے پارے والا سر امریض کی زبان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور مریض دونوں ہونٹ دبا کر منہ آہستہ سے بند کر لیتا ہے۔ اس دوران جسمانی درجہ حرارت کی گرمی سے تھرمامیٹر کا پارہ پھیل کر تھرمامیٹر کی ٹلی میں اوپر کی جانب چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد تھرمامیٹر منہ سے نکال کر جسمانی درجہ حرارت نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ جس نشان تک پارہ چڑھا ہوا تھا ڈگری ہی بخار ہوتا ہے۔ شیرخوار بچوں، بوڑھوں اور بے ہوش افراد میں بغل میں تھرمامیٹر رکھ کر درجہ حرارت نوٹ کیا جاتا ہے بغل کا درجہ حرارت منہ کے درجہ حرارت کی نسبت ایک ڈگری کم ہوا کرتا ہے



اسٹیتھو سکوپ

(STETHOSCOPE)

تعارف (Introduction): اسٹیتھو سکوپ جنرل میڈیکل پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں کیلئے ایک انتہائی اہم ضروری اور بنیادی طبی آلہ ہے۔ اس کے تین حصے ہوا کرتے ہیں۔ اگلا حصہ چیٹ پیس کہلاتا ہے جو مریض کے سینے یا پیٹ پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ربڑ کی بنی ہوئی ٹیوب ہوتی ہے جو چیٹ پیس سے حاصل کردہ آوازوں کو کانوں کی جانب دھکیلتی ہیں۔ ٹیوب کے اوپری سطح پر کانوں میں لگانے والا حصہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر اپنے کانوں میں لگا کر سینہ یا پیٹ کی آوازیں سنا کرتا ہے۔ اسی آلے کی مدد سے کوئی بھی ڈاکٹر اپنے مریض یا مریضہ کا سینہ اور پیٹ چیک کر سکتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے ابتدائی طور پر ایک ڈاکٹر کسی بھی مریض میں پھیپھڑوں، دل اور آنتوں کی بیماریوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے سانس، دل اور پیٹ و آنتوں کی کئی بیماریوں کی ابتدائی تشخیص کی جاسکتی ہے۔



بلڈ پریشر

(BLOOD PRESSURE)

تعارف (Introduction): ہر انسان کی جسمانی رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی خون دراصل انسان کے تمام جسمانی اعضاء اور ہاتھوں کو غذائی اجزاء اور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ جسمانی رگوں میں موجود یہ خون اپنی رگوں پر مسلسل ایک دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے۔ زندگی سے بلڈ پریشر کا گہرا تعلق ہے۔ بلڈ پریشر عام طور پر مرکزی کے آلے سے ناپا جاتا ہے جسے بلڈ پریشر کا آلہ یا سٹگمو مانومیٹر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی زیادتی کو ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر کی کمی کو ہائپو ٹینشن کہا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بلڈ کا وہ پریشر جو دل کے سکڑنے کی حالت میں ہوتا ہے اسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اور دوسرا وہ جو دل کے پھیلنے کی حالت میں ہوتا ہے اسے ڈیا سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یارکھیں سسٹولک پریشر ڈیا سسٹولک کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ نارمل بلڈ پریشر 120/80 mmHg سے لیکر 150/90 mmHg کے درمیان ہوا کرتا ہے۔



ای۔سی۔جی

(E.C.G)

تعارف (Introduction): ای۔سی۔جی دراصل الیکٹروکارڈیوگرافی کا مخفف ہے۔ ای۔سی۔جی دل کی حرکات اور افعال کو برقی لہروں کے ذریعے نوٹ کرنے کا نام ہے۔ ای۔سی۔جی میں دل کی حرکات اور افعال پانچ قسم کی لہروں P, Q, R, S, T کے ذریعے نوٹ کی جاتی ہیں۔ ان برقی لہروں کی اپنی ایک نارمل بناوٹ ہوتی ہے۔ اگر ان نارمل بناوٹوں میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو ان تبدیلیوں سے دل کی مختلف بیماریوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ دل کے دورے کے دوران ای۔سی۔جی کرنے سے دل کی بیماری سے متعلق کافی معلومات حاصل ہوا کرتی ہیں۔ ایک نارمل شخص کو بھی کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ ای۔سی۔جی کرانی چاہئے تاکہ ای۔سی۔جی کے ذریعے دل کے افعال، صحت اور بیماریوں کا اندازہ کیا جاسکے۔ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کی ای۔سی۔جی ریگولر کرائی جاتی ہے اور انہی برقی لہروں کے ذریعے ڈاکٹر دل کی بیماری و صحت کی حالت کا اندازہ لگاتا ہے۔



ای۔ٹی۔ٹی

(E.T.T)

تعارف (Introduction): ای۔ٹی۔ٹی دراصل ایکر سائز ٹالرینس شٹ کا مخفف ہے۔ یہ شٹ دل کی افعالی طاقت کو نوٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے۔ اس شٹ میں مریض کو ایک برقی بیٹل پر جو کہ بجلی کے ذریعے گھوم رہی ہوتی ہے، دوڑنے کیلئے کہا جاتا ہے اور ماہر امراض قلب معالجین ای۔ٹی۔ٹی۔ ٹی رزلٹ کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس شٹ کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کتنی دیر تک بھاری کام کر سکتا ہے اور کتنی دیر کے بعد اسے دل کے مقام پر درد اٹھتا ہے۔ دل کے اٹھنے والے اس درد کو انجاننا کہتے ہیں۔ اس شٹ کے دوران جتنی جلدی مریض کو انجاننا ہوگا، مریض اتنا ہی زیادہ بیمار ہوگا اور اگر مریض کو ایکر سائز کے دوران درد دیر سے ہو یا انجاننا نہ ہو تو مریض اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ای۔ٹی۔ٹی۔ ٹی کی رپورٹ پر ڈاکٹر کو تجویز نسخہ میں مدد ملتی ہے۔



ایکو کارڈیو گرافی

(ECHO CARDIOGRAPHY)

تعارف (Introduction): بعض اوقات ای۔ سی۔ جی اور ای۔ ٹی۔ ٹی سے دل کی بیماری یا افعال سے متعلق مکمل معلومات حاصل نہیں ہو پاتیں یا معالج کو دل کے اندرونی افعال سے آگاہی درکار ہوتی ہے تو اس مقصد کیلئے دل کا ایک اور سٹ ایکو کارڈیو گرافی تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ سٹ دراصل دل کا اندرونی الٹراساؤنڈ ہے جس کے ذریعے دل کے اندرونی خانوں اور والوز کی بناوٹ یا ان میں کوئی اینارملی واضح طور پر محسوس اور نوٹ کی جاسکتی ہے۔ ایکو کارڈیو گرافی سٹ کے ذریعے کارڈیک جیمبرز اور کارڈیک وینٹری والوز کے افعال یعنی فزیالوجی اور بیماریاں یعنی پیتھالوجی کا پتہ چلتا ہے اور کوئی بھی ماہر امراض قلب ڈاکٹر ایکو کارڈیو گرافی کی رپورٹ کی روشنی میں اور دوسرے قلبی ٹسٹوں مثلاً ای۔ سی۔ جی اور ای۔ ٹی۔ ٹی کی مدد سے مریض کے دل کی بیماری کا درست اندازہ کرتے ہوئے علاج کا صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔



انجیو گرافی

(ANGIOGRAPHY)

تعارف (Introduction): بعض اوقات کئی قلبی مریضوں میں انجیو گرافی یعنی دل کا دروسانس کا چڑھنا یعنی کارڈیک اسٹھما اور دوسری قلبی علامات باوجود میڈیسن کھانے اور کارڈیالوجسٹ سے ریگولر چیک اپ کروانے کے ٹھیک نہیں ہو پاتیں۔ لہذا ایسی صورت میں ایک کارڈیالوجسٹ یعنی ماہر امراض قلب اپنے مریض کو کارڈیک ایکوسٹ کے علاوہ انجیو گرافی کرانے کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ انجیو گرافی دراصل دل کے امراض کے تشخیص کرنے کا ایک ایسا سٹ ہے کہ جس میں مریض کی ران یا کلائی کی موٹی وین یعنی ورید میں سرجیکل طریقے سے چھوٹا سا سوراخ کر کے ایک چھوٹا سا کیمرہ اور تار اندر داخل کیا جاتا ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے دل کی رگوں کا روزی آرٹریز تک پہنچ جاتا ہے اور کارڈی آرٹریز کی تنگی سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے، جس پر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو دل کے بائی پاس آپریشن کرانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ آج کل انجیو گرافی کی ایک ترقی یافتہ شکل سامنے آئی ہے جسے سی۔ ٹی، انجیو گرافی (C.T. Angiography) کہتے ہیں۔ سی۔ ٹی، انجیو گرافی میں مریض کی ران یا کلائی کی وین میں سوراخ نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ انجیو گرافی سی، ٹی، سکین کی طرح سی، ٹی، مشین میں کی جاتی ہے۔



ایکسرے

(X-Ray)

تعارف (Introduction): تشخیص امراض میں ایکسرے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایکسرے مشین ایک جرمن سائنسدان ہنری بیکرل کی ایجاد ہے۔ آج کل بیشتر طبی امراض کی تشخیص کیلئے ایکسرے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکسرے چونکہ مضرت شعاعوں پر مشتمل شٹ ہوتا ہے لہذا اس کا زیادہ استعمال یا اپنے جسم کے زیادہ ایکسرے کروانا صحت کیلئے نقصان دہ اور دوسرے امراض کی پیدائش کا موجب بن سکتا ہے۔ لیکن بہر حال امراض کی تشخیص میں ایکسرے کا استعمال اپنی ایک مسلمہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایکسرے کے ذریعے سر کے امراض، ہڈیوں کا ٹوٹنا وغیرہ، گردوں و مثانے کے امراض، پیٹ و جگر کے امراض اور جوڑوں و ریڑھ کی ہڈی کے امراض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ ایکسرے کا مطالعہ کرنا اور اس کی رپورٹ جاری کرنا نہایت ہی مہارت کا کام ہے جو ایک ایکسرے کا ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ ایکسرے کے ماہر ڈاکٹر کو ریڈیالوجسٹ کہتے ہیں۔



اینڈوسکوپ

(ENDOSCOPY)

تعارف (Introduction): انسانی جسم کے بعض اعضاء کو بیماری کی تشخیص کیلئے اندر سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اعضاء بناوٹ کے لحاظ سے اندرونی طور پر کھوکھلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوراک کی نالی ایسوفیگس، معدہ اور چھوٹی آنت وغیرہ۔ کئی مریضوں میں جب نظام انہضام کی علامات کسی بھی میڈیسن سے مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو رہی ہوں تو پھر ڈاکٹر خوراک کی نالی، معدہ اور چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈینم کو اندرونی طور پر دیکھنے کیلئے اینڈوسکوپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اینڈوسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جس کے سرے پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ایک کٹر یعنی قینچی کی طرح کا آلہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے جو بوقت ضرورت متاثرہ حصے کے ٹشو کو کاٹ لیتا ہے۔ اینڈوسکوپ کے ذریعے غذا کی نالی، معدے اور ڈیوڈینم کے اندر کسی قسم کی سوزش، تنگی، رسولی یا کیسر، زخم وغیرہ کو دیکھا جاسکتا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو متاثرہ حصے سے ٹشو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر بائیوپسی کر کے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔



کالن سکوپ

(COLONOSCOPY)

تعارف (Introduction): کالن سکوپ دراصل بڑی آنت یعنی کالن کی اینڈوسکوپ ہے۔ جب کسی مریض میں بڑی آنت سے متعلق کوئی بیماری یا علامات پائی جائیں اور وہ عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہو رہی ہوں تو پھر ڈاکٹر ایسے مریض کی کالن سکوپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کالن سکوپ کے ذریعے بڑی آنت کی کئی بیماریوں کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ یہ آلہ بھی کیمرے اور کٹر یعنی ٹشو کاٹنے والے آلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ کالن سکوپ ماہر امراض معدہ ڈاکٹر یعنی گیسٹر و انٹرالوجسٹ کرتا ہے۔ کالن سکوپ آلہ مریض کے مقعد کے ذریعے بڑی آنت تک داخل کر کے جا بجا بڑی آنت کی حالت کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ بڑی آنت میں موجود زخم، سوزش، سرخی، کوئی تنگی، رکاوٹ، رسولی یا کینسر کی موجودگی کالن سکوپ کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے اور اگر کسی جگہ ڈاکٹر کو کینسر کا شک ہو تو اس جگہ سے ٹشو کا ایک باریک ٹکڑا کاٹ کر خوردبین کے ذریعے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد کینسر ہونے یا نہ ہونے کے شک کو دور کیا جاسکتا ہے۔



پراکٹو سکوپ

(PROCTOSCOPY)

تعارف (Introduction): پراکٹو سکوپ بھی اینڈوسکوپ کی ایک قسم ہے۔ پراکٹو سکوپ مقعد کے معائنہ اور امراض کو تشخیص کرنے کیلئے کی جاتی ہے۔ پراکٹو سکوپ کے ذریعے مریض کے مقعد کا تفصیلی معائنہ کیا جاسکتا ہے۔ مقعد کی ایسی علامات یا بیماریاں جو مریض کو کافی تنگ کر رہی ہوں اور ادویات مریض پر مکمل اثر نہ کر رہی ہوں یا مقعد سے متعلق علامات یا بیماری کی صحیح طور پر تشخیص نہ ہو رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں ماہر امراض معدہ و آنت یعنی گیسٹر و انٹرالوجسٹ پراکٹو سکوپ کرنے کا فیصلہ کیا کرتا ہے۔ پراکٹو سکوپ کے ذریعے ریکٹم کا معائنہ کیا جاسکتا ہے۔ ریکٹم کی کئی بیماریوں مثلاً سوزش، سرخی، زخم، تنگی، رکاوٹ، رسولی، کینسر اور بواسیر سمیت کئی امراض کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔



برائکوسکوپ

(BRONCHOSCOPY)

تعارف (Introduction): برائکوسکوپ بھی اینڈوسکوپ کی ایک قسم ہے جو سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کی اندرونی حالت کے معائنے اور تشخیص کیلئے کی جاتی ہے۔ برائکوسکوپک آلے کے آگے بھی ایک چھوٹا سا کیمرہ اور شوکٹ کر حاصل کرنے کیلئے کٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ برائکوسکوپ ماہر امراض سینہ ڈاکٹر یعنی چیٹ سپیشلسٹ کیا کرتا ہے۔ جب کسی سینے کے مریض میں کھانسی، دم کشی، بلغم یا بلغم میں خون جیسی علامات ادویات سے ٹھیک نہ ہو پارہی ہوں تو ایسی صورت میں ایک ڈاکٹر نظام تنفس کے اندرونی معائنے و تشخیص کیلئے برائکوسکوپ تجویز کرتا ہے۔ برائکوسکوپک آلہ مریض کے حلق کے ذریعے سانس کی نالی سے گزارتے ہوئے بالترتیب دائیں اور بائیں پھیپھڑے تک لے جایا جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق متاثرہ حصے کا شوکٹ کر بھی خوردبینی تشخیص کی جاتی ہے برائکوسکوپ سے سانس کے کئی امراض مثلاً کینسر، رسولی، سانس کی نالیوں کا سکر جانا وغیرہ تشخیص کیا جاسکتا ہے



انجیوپلاسٹی

(ANGIOPLASTY)

تعارف (Introduction): انجیوپلاسٹی دراصل ایک کارڈیو پروسیجر کا نام ہے۔ انجیوپلاسٹک پروسیجر انجیوگرافی ٹسٹ کے دوران ہی کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ کارڈیالوجسٹ انجیوپلاسٹی کرنا ضروری یا موزوں سمجھے۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ انجیوگرافی میں مریض کے دل کی آرٹریز کی رکاوٹ دیکھنے کیلئے مریض کی ران یا کلائی کی موٹی وین میں کیمرہ نما آلہ تار کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے جو بڑھتے بڑھتے کارڈیو آرٹریز تک پہنچ جاتا ہے۔ جس جگہ کارڈیو آرٹری بلاک یا تنگ ہو اور اگر یہ بلاکج تھوڑی ہو تو اسی آلے کے ذریعے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر کارڈیو آرٹری تنگ ہونے کے مقام پر پلاسٹک سے بنا ہوا ایک اسٹنٹ ڈال دیا کرتا ہے تاکہ تنگ آرٹری مزید تنگ نہ ہو۔ کارڈیو آرٹری میں اسٹنٹ ڈالنے کے اس پروسیجر کو انجیوپلاسٹی کہتے ہیں۔ اگر کارڈیو آرٹری زیادہ تنگ ہو اور اسٹنٹ نہ پڑ سکتا ہو تو پھر ڈاکٹر مریض کو بائی پاس آپریشن کا مشورہ دیتا ہے۔



فزیوتھراپی

(PHYSIOTHERAPY)

تعارف (Introduction): فزیوتھراپی میں کسی بھی مریض کا علاج ادویات کے ساتھ ساتھ مختلف طبعی طریقوں، ورزشوں اور مختلف آلات و مشینوں کے ذریعے جدید سائنسی اصولوں پر کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کیلئے جو طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان میں حرارت، شعاعیں، بجلی، ورزش، مالش، برف، پانی، موم اور ارتعاش وغیرہ شامل ہیں۔ فزیوتھراپی یوں تو کئی امراض میں موثر ثابت ہوئی ہے لیکن خصوصی طور پر فالجی کیفیت کی کمزوری کو دور کرنے، جسم کے کسی عضو کی جانب دوران خون بڑھانے، درد کو ختم کرنے، پٹھوں، اعصاب اور رگوں کو طاقت دینے، ہاتھ پیروں یا جسم کی دیگر بد وضع حالتوں کو صحیح کرنے، بیماری یا زخم سے جلد بہتری کا امکان پیدا کرنے کیلئے کی جاتی ہے غرضیکہ فزیوتھراپی درد، سوجن، اعضائی درد، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھنچاؤ، گردن و کمر کے مہروں کی ٹکالیف، پولیو فاج، سوکھا پن، رگوں اور پٹھوں کی کمزوری، کمر میں خم آنے، عرق النساء، چوٹ، موج اور فریکچر وغیرہ میں نہایت ہی نافع ہے۔ فزیوتھراپی کے ماہر کو فزیوتھراپسٹ کہتے ہیں۔



ایکوپنچر

(ACUPUNCTURE)

تعارف (Introduction): یہ ایک قدیم چینی طریقہ علاج ہے۔ اس طریقہ علاج میں مریض کے جسم کے مختلف مقامات پر خاص قسم کی بنی ہوئی سوئیوں کو چھو کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کی تھیوری کے مطابق انسانی جسم میں انرجی کے کچھ چینلز ہوتے ہیں اور ان انرجی چینلز کے مخصوص پوائنٹ ہوا کرتے ہیں جو کہ تمام انسانی جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ایکوپنچر طریقہ علاج تھوری کے مطابق جسم میں موجود انرجی چینلز میں انرجی کا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی جسمانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کیلئے بیماری کی علامات کے مطابق مخصوص پوائنٹس پر ایکوپنچر کی سوئیاں لگا کر ان پوائنٹس کو ہلکی بجلی کے ساتھ متحرک کر کے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ آج کل سری لنکا، انڈیا، چین، آسٹریلیا میں ایکوپنچر طریقہ علاج کافی مشہور ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے معالین موجود ہیں اور تسلی بخش علاج کر رہے ہیں



لیتھوٹریپسی

(LITHOTRIPSY)

تعارف (Introduction): موسیقی کی دنیا کے لوگ اور شائقین یقیناً جانتے ہوں گے کہ مشرقی موسیقی کے نامور گائیک تان سین جو کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے نورتوں میں شامل تھے نے اپنی آواز کے جادو کے ذریعے کئی کمالات دکھائے مثلاً پانی میں آگ لگا دینا، بارش کر دینا یا اسی طرح آواز کی لہروں کے ذریعے شیشے کے گلاسوں کا توڑ دینا وغیرہ۔ بہر حال تان سین کی آواز کے جادو سے متعلق یہ واقعات درست ہوں یا نہ ہوں لیکن آواز کی لہروں کا کمال واقعی میڈیکل سائنس نے سچ ثابت کر دکھایا ہے جس کی مثال الٹراساؤنڈ اور لیتھوٹریپسی کی صورت میں آج ہم سب کے سامنے ہے جبکہ لیتھوٹریپسی ایک ایسا عمل ہے جو گردوں، یوریز، مثانے اور پتے کی پتھریوں کو بغیر سرجیکل آپریشن کے توڑ کر ننھے ننھے ریزوں کی شکل میں خارج کر دیا کرتا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ بڑی، چکنی شکل اور مضبوط پتھریوں کو لیتھوٹریپسی کے ذریعے نہیں توڑا جاسکتا غرضیکہ چھوٹی چھوٹی پتھریوں میں لیتھوٹریپسی کامیاب ہے اور بوڑھے، نحیف، بچے مریض لیتھوٹریپسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔



ای۔ای۔جی

(E.E.G)

تعارف (Introduction): ای۔ای۔جی۔ جی۔ واصل الیکٹروانسفلوگرافی کا مخفف ہے۔ ای۔ای۔جی۔ ای۔جی۔ ای۔سی۔ جی کی ہی طرح کا ایک ٹسٹ ہے جو برقی لہروں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ دل کی حرکات و افعال اور بیماریوں کو ایک خاص مشین کے ذریعے برقی لہروں کی صورت میں ایک گراف پیپر پر حاصل کر کے دل کی بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے بالکل اسی طرح ایک مخصوص مشین کے ذریعے برقی لہروں کی مدد سے ایک مخصوص گراف پیپر پر دماغی افعال کی کیفیتوں کا مطالعہ کے ٹسٹ کرنے کا نام ای۔ای۔جی۔ یعنی الیکٹروانسفلوگرافی ہے۔ یہ ٹسٹ ایک سائیکائٹرسٹ ہی نہایت مہارت کے ساتھ کر بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ مرگی، پاگل پن، دماغی رسولی اور دوسرے دماغی عوارض میں مبتلا مریضوں کا یہ ٹسٹ کیا جاتا ہے۔



آفتھل ماس کوپی

(OPHTHALMASCOPIY)

تعارف (Introduction): آنکھ کی بیماریاں بیرونی اور اندرونی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی سرخی، الرجی، آشوب چشم، کارنیا کی خرابیاں اور آنکھ میں کچھ پڑ جانے کے علاوہ پلکوں کا ٹوٹ جانا یا پپوٹوں کی سوزش وغیرہ، آنکھ کی بیرونی بیماریاں ہیں جبکہ موتیا، کالا موتیا، نظر کی کمزوری، ڈبل نظر آنا، اندھراتا اور ریٹینا کی خرابیاں وغیرہ آنکھ کی اندرونی بیماریاں ہیں۔ آنکھ کی بیرونی بیماریاں ماہر امراض چشم ڈاکٹر بظاہر دیکھنے پر ہی تشخیص کر لیتا ہے یا زیادہ سے زیادہ بسا اوقات آنکھ کے ماہر ڈاکٹر کو بیرونی آنکھ کی خرابیوں کی تشخیص و معائنے کیلئے عدسے اور ٹارچ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آنکھ کی اندرونی خرابیوں کی تشخیص اور آنکھ کے اندرونی معائنے کیلئے ڈاکٹر ایک خاص قسم کے آلے کا استعمال کرتا ہے جسے آفتھل ماس کوپ کہتے ہیں۔ آفتھل ماس کوپ کے ذریعے مریض کی آنکھ کی اندرونی خرابیوں اور بیماریوں کا صحیح طور پر اندازہ کر کے کوئی بھی ڈاکٹر مریض کی آنکھ سے متعلقہ اندرونی بیماری کی تشخیص کر سکتا ہے۔



آرتھوڈونٹکس

(ORTHODONTICS)

تعارف (Introduction): دانت بھی قدرت کا انمول عطیہ ہیں۔ دانت نہ صرف انسان کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ کھانے، پینے، غذا کو چبانے اور بولنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دانتوں کی پیدائش کے دو مرحلے رکھے ہوئے ہیں۔ بچے میں موجود دانت دودھ کے دانت کہلاتے ہیں جن کی تعداد بیس ہوا کرتی ہے جو اپنی ساخت کے لحاظ سے نرم اور عارضی ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دودھ کے دانت ایک ایک کر کے ٹوٹتے جاتے ہیں اور انکی جگہ مستقل دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مستقل دانت تعداد میں بتیس ہوا کرتے ہیں۔ یہ دانت انتہائی مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ عام طور پر آسانی سے نہیں ٹوٹتے لیکن خدانخواستہ اگر کیڑا لگنے، ایکسیڈنٹ یا کسی اور وجہ سے کوئی دانت ٹوٹ جائے یا نکال دیا جائے تو پھر اس کی جگہ نیا دانت نہیں نکل سکتا لہذا ایسے دانت کو ایک ڈینٹسٹ نقلی طور پر بنا کر فٹ کر دیتا ہے۔ اسی نقلی دانت بنانے کے عمل کو ڈینٹسٹری کی اصطلاح میں آرتھوڈونٹکس کہتے ہیں۔



آر۔سی۔ٹی

(R.C.T)

تعارف (Introduction): آر۔سی۔ٹی دراصل روٹ کینال ٹریٹمنٹ کا مخفف ہے۔ یہ ٹرم ڈینٹسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ ڈینٹسٹری میں دانت کے درد کا سرجیکل علاج آر۔سی۔ٹی یعنی روٹ کینال ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے۔ انسان کے منہ میں جو دانت نظر آتے ہیں وہ دانت کا کراؤن کہلاتے ہیں جبکہ بقیہ دانت اور جڑ، جڑے کی ہڈی میں سختی سے پیوست ہوتے ہیں۔ دانتوں کی جڑ میں دانت کو سپلائی کرنے والی رگیں اور اعصاب بند ہوتے ہیں۔ ہر دانت میں دو سے تین یا چار تک جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات دانت کی حالت تو بہترین ہوتی ہے لیکن دانت میں سخت درد ہوتا ہے۔ بار بار درد ہوا کرتا ہے۔ چونکہ دانت زیادہ بوسیدہ نہیں ہوتا اس لئے ڈینٹل سرجن دانت نکالنے کے بجائے آر۔سی۔ٹی کرانے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس ڈینٹل پروسجر میں دانت میں سوراخ کر کے دانت کی جڑ میں موجود خون کی نالیاں اور اعصاب کو باریک باریک سوئیوں سے تباہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں دانت کے سوراخ کو بھر دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ متاثرہ دانت کی جڑ میں اعصاب نہیں ہوتے لہذا مریض کو درد بھی محسوس نہیں ہوتا اور دانت بھی نکالنا نہیں پڑتا جس کی وجہ سے نہ تو دانتوں کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی کچھ کھانے پینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔



پلاسٹر آف پیرس

(PLASTER OF PERIS)

تعارف (Introduction): پلاسٹر آف پیرس کو مختصر آپی۔ او۔ پی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں کل دو سو چھ ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں کیلشیم اور فاسفورس کے مرکبات سے ملکر بنتی ہیں اور اپنی ماہیت میں انتہائی مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ عام چوٹ سے یا گرنے سے یا شدت کی چوٹ یا ایکسیڈنٹ کے باعث جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ قدرت نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں خود بخود جڑنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ ضرورت محض اس بات کی ہوتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی یا ہڈیوں کو مناسب طریقے سے ایک دوسرے کے قریب لا کر انہیں بے حرکت رکھنا چاہئے تاکہ یہ آپس میں قدرتی طور پر جلد از جلد جڑ سکیں۔ ہڈی کے ٹوٹنے کے مقام پر کیلشیم خود بخود جمع ہو کر ہڈی کے جڑنے میں مدد کرتی ہے۔ کیلشیم کی مدد سے قدرتی طور پر ہڈی جڑنے کے عمل کو کیلسی فی کیشن کہتے ہیں موثر کیلسی فی کیشن کیلئے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام پر بیرونی طور پر پلاسٹر آف پیرس کر دیا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کچھ عرصے کیلئے بے حرکت رکھتا ہے اور پلاسٹر کئے ہوئے اس عرصہ میں ہڈی خود بخود جڑ جاتی ہے عام طور پر پلاسٹر چار سے چھ ہفتے کیلئے کیا جاتا ہے۔



کیتھٹر

(CATHETER)

تعارف (Introduction): ہمارے جسم میں فاسد مادے بنتے رہتے ہیں اور ان فاسد مادوں کا اخراج پاخانے، پیشاب، پسینے، سانس اور کئی دوسرے ذرائع سے ہوتا رہتا ہے۔ فاسد مادوں کا یہ اخراج انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ پیشاب کا اخراج ہے۔ پیشاب کے بننے اور اخراج کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دو گردے، گردوں کی نالیاں، مثانہ اور پیشاب کی نالی عطاء کی ہوئی ہے۔ ایک صحت مند آدمی کے جسم میں فاسد مادے اسی پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی بیماری، ایکسیڈنٹ، شک یا بے ہوشی کے نتیجے میں اپنا پیشاب خارج نہیں کر سکتا اور اس کا مثانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے تو پھر جسم کے فاسد مادے اور پیشاب واپس خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن کو یوریمیا کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ مردوں میں پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے سے بھی پیشاب کا اخراج رک جاتا ہے لہذا ایسی صورت میں مریض کو یوریمیا سے بچانے کیلئے فوری طور پر مریض میں پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے تک کیتھٹر پاس کیا جاتا ہے جس سے مثانے میں موجود پیشاب کیتھٹر کی نالی کے ذریعے باہر خارج ہو جایا کرتا ہے اور یوں مریض کم از کم یوریمیا سے بچ جایا کرتا ہے۔



این۔ جی۔ ٹیوب

(N.G.TUBE)

تعارف (Introduction): این۔ جی۔ ٹیوب دراصل نیز و گیسٹرک ٹیوب کا مخفف ہے۔ اسی ٹیوب کو رائلز ٹیوب یا اسٹاک ٹیوب بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ربڑ کی بنی ہوئی ٹیوب ہوتی ہے جو عام طور پر ڈھائی فٹ تک لمبی یا 75 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے جس کا ایک سرا پھیلا ہوا قیف نما ہوتا ہے۔ این۔ جی۔ ٹیوب کو کیسٹر ٹیوب یا پیرافین یا لیکٹو کین جیلی سے چکنا کر کے ناک کے ذریعے معدے میں داخل کیا جاتا ہے۔ این۔ جی۔ ٹیوب کا سرا جب معدے میں داخل ہو جاتا ہے تو اوپر والے حصے سے غذا یا دوا جو کہ مائع کی صورت میں ہو معدہ میں پہنچائی جاتی ہے اور اسی طرح معدے کی رطوبت کو بھی سرنج کے ذریعے نکالا جاسکتا ہے۔ زہر خورانی کے کیسوں میں این۔ جی۔ ٹیوب کے ذریعے معدے کی رطوبات اور زہریلے مادہ کو باہر نکالا جاسکتا ہے اور معدے کو دھویا جاسکتا ہے۔ اسی طرح یہ ٹیوب کمزور اور بے ہوش مریضوں کو غذا اور دوا پہنچانے کے بھی کام آتی ہے۔



الٹراساؤنڈ

(ULTARSOUND)

تعارف (Introduction): یہ زمانہ حال کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اس سے جسم کی ہارک ہارک ساختوں کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا بھی پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ جسم کے کسی عضو میں کوئی خرابی یا غیر طبعی کیفیت پیدا ہو جائے تو الٹراساؤنڈ مشین اس کا فوٹو فلم کی طرح بنا کر اسکرین پر پیش کر دیتی ہے اور ایک ماہر اس خرابی کو نوٹ کر کے اس کی رپورٹ مرتب کر لیتا ہے۔ پتہ کی ننھی ننھی پتھریاں، جنین کی پوزیشن اور جنس، اعضاء کے سائز، ان کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، غرض وہ تمام غیر طبعی حالات جو ایک سرے سے معلوم نہیں کئے جاسکتے الٹراساؤنڈ سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اس ایجاد سے تشخص کے فن میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ الٹراساؤنڈ کی پیش کردہ معلومات عموماً صحیح ہوتی ہیں بشرطیکہ اس کی رپورٹ صحیح مرتب کی جائے۔ رپورٹ پڑھ کر ہی ایک ڈاکٹر جسم میں ہونے والی خرابیوں اور بیماریوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ تکنیک جسم کے داخلی حصوں کی پیمائش اور کسی قسم کے اندرونی ابھار، گانٹھ یا ورم وغیرہ کی بہت صاف نشاندہی کر دیتی ہے اور اس مقصد کیلئے اب تک کی سب سے محفوظ تکنیک ہے۔ اس بناء پر سولی یا اندرونی زخم وغیرہ کا پتہ لگانے کیلئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تکنیک سے گردہ یا پتہ میں موجود پتھری کی نہ صرف نشاندہی ہو جاتی ہے بلکہ اب جدید ترین طریقہ کے تحت ایک خاص قسم کی لہروں کے ذریعہ پتھری کو توڑا بھی جاسکتا ہے۔ اس کے بعد پتھری کے ذرات پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی بیماریوں میں پتلی کے پھیلاؤ، آنکھ کے اندرونی پردوں میں جریان خون، پردہ چشم میں شگاف، عصب بصری میں ورم وغیرہ کا پتہ لگانے میں بھی الٹراساؤنڈ تکنیک کامیاب ثابت ہوئی ہے۔



سی۔ ٹی۔ سکین

(C.T. SCAN)

تعارف (Introduction): سی۔ ٹی۔ سکین دراصل کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی سکیننگ کا مخفف ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کے انتہائی حساس کمپیوٹرائزڈ ایکسرے ہوتے ہیں جس کے ذریعے مختلف زاویوں سے جسم کے اندرونی اعضاء کی بہت اچھی اور شفاف تصاویر لی جاسکتی ہیں جن کے معائنے پر صاف طور پر پتہ لگ سکتا ہے کہ سکیننگ آرگن نارمل ہے یا انا نارمل ہے۔ غرضیکہ یوں سمجھیں کہ سی۔ ٹی۔ سکین عام ایکسرے کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے کیونکہ عام ایکسرے میں صرف ہڈیوں کی تصاویر لے کر معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور جسم کے اندرونی سافٹ آرگن کے متعلق کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہو پاتیں۔ سی۔ ٹی۔ سکین میں مریض کو ٹیبل پر لٹا کر سکین مشین کے اندر لے جایا جاتا ہے جہاں ایکسرے کی شعاعیں جسم کے معائنہ کرنے والے حصے میں مختلف زاویوں سے داخل کی جاتی ہیں اور لاکھوں انفارمیشن کے ڈیٹا کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے اور اس طرح اندر والے اعضاء کی پکچر بن جاتی ہے۔ پھر سی۔ ٹی۔ سکین فلموں کا معائنہ کر کے ریڈیالوجسٹ اپنی رپورٹ مرتب کرتا ہے۔ سی۔ ٹی۔ سکین دماغ، پھیپھڑوں، پیٹ کے اعضاء، پیلوں، جسم کے سافٹ آرگنز اور سپائن کا کیا جاسکتا ہے۔



ایم۔ آر۔ آئی

(M.R.I)

تعارف (Introduction): ایم۔ آر۔ آئی دراصل میکینک ریزوننس امیجنگ کا مخفف ہے۔ سی، ٹی، سکین کے بعد ایم۔ آر۔ آئی کی ایجاد نے طبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایم، آر، آئی سکین کے ذریعے جسم کے ہر عضو اور حصے کی اندرونی تصاویر بڑی صاف اور صحیح طور پر دیکھی جاسکتی ہیں جو کہ کسی بھی مریض کی بیماری کو صحیح طور پر تشخیص کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایم آر۔ آئی کی ایجاد سے پہلے ڈاکٹروں کو سرجری کے ذریعے اندرونی اعضاء کا مشاہدہ کرنا پڑتا تھا۔ ایم، آر، آئی میں ایک ایسی مشین استعمال کی جاتی ہے جس میں ایک بڑا سا میگنیٹ یعنی مقناطیس لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ اپنے ارد گرد میکینک فیلڈ میں رکھا جاتا ہے اور ایک اینٹنا سے ریڈیو فریکوئنسی کی لہریں اس فیلڈ میں بھیجی جاتی ہیں جو کہ معائنہ کرنے والے حصے سے ٹکرا کر دوبارہ دوسرے اینٹنا کی جانب آتی ہیں جن کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے اندر کے حصے کی تصویریں اسکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر ایک ریڈیالوجسٹ مریض کے مرض سے متعلق اپنی تشخیصی رپورٹ مرتب کرتا ہے۔



انیما کرنا

(ENEMA)

تعارف (Introduction): انیما کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کی آنتوں میں تحریک پیدا کر کے فضلے کو خارج کر دیا جائے۔ قونج، درد گردہ ریاحی، قبض وغیرہ میں اس طریقے سے مریض کو بہت جلد تکلیف سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ تیز بخاروں، آنتوں کے ورم وغیرہ کی حالتوں میں انیما سے پرہیز کیا جانا چاہئے۔ انیما تین طرح سے کیا جاتا ہے۔

1	گیلیرین سرنج سے	2	ڈوش کین سے	3	تیار شدہ انیما ڈیوائس سے
---	-----------------	---	------------	---	--------------------------

پہلی قسم میں گیلیرین سرنج پلاسٹک یا پیتل کی ہوتی ہے۔ 25 ملی لیٹر گیلیرین کو سرنج میں بھر کر اس کی نوک پر کیسٹر آئل لگا کر مقعد میں داخل کر دینا چاہئے۔ یہ بہت آسان اور موثر طریقہ ہے۔ اس سے بغیر کسی تکلیف کے فوراً اجابت کی خواہش ہوتی ہے اور پاخانہ آ کر مریض کو سکون مل جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ڈوش کین کا ہے۔ اس میں چینی کے ڈوش میں صابن گھلا پانی بھر کر کسی اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ پھر بڑی نلکی کا ایک سر ڈوش میں لگا کر دوسرے نوزل لگے سرے پر کوئی چکنی چیز مثلاً کیسٹر آئل لگا کر مقعد میں داخل کر کے نوزل کھول دی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے آہستہ آہستہ اور زیادہ مقدار میں پانی آنتوں میں پہنچ کر فضلے کی صفائی کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ پلاسٹک ٹیوب میں تیار شدہ محلول اور انیما بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ ٹیوب کی نلکی کو چکنا کر کے مقعد میں داخل کر کے ٹیوب دبا کر خالی کر دی جاتی ہے۔ یہ کلمین انیما (Kleen Enema) کے نام سے ملتا ہے۔



صحت سے متعلق چند ضروری ہدایات

(FEW IMPORTANT ADVICES FOR HEALTH)

”اچھی صحت نعمت خداوندی ہے“

اچھی صحت قدرت کی جانب سے انسان کیلئے بہترین تحفہ ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کیلئے ہمیشہ درج ذیل اصولوں پر کاربند رہنا چاہئے؛

☆.....	ہمیشہ زود ہضم اور ہلکی غذا استعمال کرنی چاہئے۔
☆.....	جب کھانے کی رغبت ہو صرف اسی وقت کھانا چاہئے۔
☆.....	اپنی نیند ہمیشہ پوری کرنا چاہیے۔
☆.....	رات کو وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہئے۔
☆.....	صبح سویرے کسی بھی وقت خالی پیٹ چہل قدمی کرنی چاہئے۔
☆.....	زیادہ اور فالٹو دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچنا چاہئے۔
☆.....	سگریٹ نوشی اور دوسری منشیات سے ہمیشہ بچنا چاہئے۔
☆.....	پانی زیادہ اور صاف ستھرا پینا چاہئے۔
☆.....	زیادہ مرغن اور چربی و مرچ مصالحوں والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
☆.....	وقت بے وقت غصے سے پرہیز کرنا چاہئے۔
☆.....	پیشاب اور پاخانہ ہمیشہ وقت پر کرنا چاہئے۔
☆.....	وقتاً فوقتاً اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہئے۔
☆.....	ہر پندرہ بیس دن بعد احتیاطاً بلڈ پریشر چیک کرائیں۔
☆.....	اگر جسم میں مستقل اور ہلکا ہلکا بخار ہو تو فوراً معالج سے رجوع کریں۔
☆.....	معالج کے مشورے کے بغیر کوئی دوا خود سے کبھی استعمال نہ کریں۔

☆.....	معالج کے مشورے کے بغیر کبھی دوا کھانا ترک نہ کریں۔
☆.....	معالج کے مشورے کے بغیر کبھی دوا کی خوراک میں کمی و بیشی نہ کریں۔
☆.....	دوائیں ہمیشہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
☆.....	اگر کوئی دوا ری ایکشن کرے تو اس کا استعمال فوری ترک کر دیں۔
☆.....	اپنے مرض سے متعلق زیادہ تفکر نہ کریں لیکن توجہ دینا ضروری ہے۔
☆.....	مرض سے متعلق کسی بھی قسم کے وہم اور وسوس کو دل میں جگہ نہ دیں۔
☆.....	معالج کے مشورے کے بغیر حد سے زیادہ پرہیز نہ کریں۔
☆.....	سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز پنجگانہ قائم کریں۔



عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِيشَنز

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

☆☆.....(A).....☆☆	
Assess	اندازہ کرنا
Aims	مقاصد
Asthma	دمہ
Appearance	حالت
Asucultation	شیتھسکوپ سے چیک کرنا
Allergy	الرجی
Areola	پستانوں کے گرد حلقہ
Albumin	پروٹین کی ایک قسم
Anaemia	خون کی کمی
Anxiety	تشویش
Alimentary Tract	نظام انہضام
Amenorrhoea	بندش حیض
Active Motile	حرکت کے قابل
☆☆.....(B).....☆☆	
Breast Feeding	چھاتی سے دودھ پلانا
Bad Effects	مضر اثرات
Breast Pump	پستان سے دودھ نکالنے کا آلہ
Bruises	رگڑ-خراش
Broad	کھلا-وسیع
Bradycardia	دل کے دھڑکنے کی رفتار کم ہونا
Brain	دماغ
Birth Asphyxia	ولادت کے بعد بچے کو سانس نہ آنا
Antiseptic	جراثیم کش
Anti Biotic	جراثیم ہلاک کرنے والی
Anti Pyretics	بخار ختم کرنے والی
Artificial Milk	مصنوعی دودھ
Acquired	حاصل شدہ
Agalactia	دودھ کا دوب جانا
Antispasmodic	تشنج ختم کرنے والی
Analgesic	درد ختم کرنے والی
Acidity	تیزابیت
Atrophy	عضو کا سکڑ جانا
Ascarides	کیڑے
Anus	مقعد
Alive born	زندہ نوزائیدہ
After Pains	بعد از ولادت دردیں
Air Way	سانس کا راستہ
Asphyxia	سانس کی رکاوٹ
Aseptic	جراثیم سے بچاؤ
Anesthesia	بے ہوش کرنے کا عمل
Abortion	استقاط
Anoxia	آکسیجن کی کمی
Acute Infection	حاد چھوت

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

☆☆.....(C).....☆☆			
Cathetrization	کیتھی ٹراگائنا	Barrier	رکاوٹ
Coitus Interruptus	مرد کا ویجاٹھ سے باہر اخراج کرنا	Baby	شیر خوار بچہ
Contraceptive	مانع حمل	Brow	بھونئیں
Contra Indication	ممانعت	Breach	کولہا۔ چوڑ
Compositic	مرکب مخلوط	Beans	پھلیاں
Cancer	سرطان	Bath	غسل
Cramps	تشنج۔ کھنچاؤ	Backache	کمر درد
Cracked	پھٹا ہوا	Blood	خون
Criminal	مجرمانہ	Blood Pressure	خون کا دباؤ (فشار خون)
Completion	تمکمل	Bladder Stone	مثانہ کی پتھری
Characteristics	کوائف	Biliary Colic	پتے کا درد
Colitis	بڑی آنت کی سوزش	Bilirubin	سرخی مائل صفرا
Clamped	بند کرنا	Bone Marrow	ہڈیوں کا گودا
Condition	حالت	Bones	ہڈیاں
Close	بند	Bluish Vagina	اندام نہانی کی نیلی رنگت
Contraction	سکڑاؤ	Bladder Irritation	مثانہ کی تحریک
Cerebral bleeding	دماغ سے خون کا اخراج	Breast	چھاتی۔ پستان
Contract	تنگ ہونا	Blood vessels	خون کی نالیاں
Chronic	مزمن۔ دیرینہ	Blood Flow	خون کی روانی
Capacity	گنجائش	Bartholinitis	بارتھولین گلینڈ کی سوزش
Contour	خدوخال	Bartholins Gland	بارتھولین گلینڈ
		Bleeding	خون بہنا۔ جریان خون

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY)

گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Ciliated	بال نما	Carbohydrates	نشاستہ
Colic	درد	Care	احتیاط
Cervical Gland	رحم کی گردن کے غدود	Cardiac Disease	امراض قلب
Circular Fibers	گول ریشے	Clinch	بھینچ جانا تختی سے بند ہونا
Connective Tissue	الحاقی بافت	Coma	بے ہوش
Cervicitis	رحم کی گردن کی سوزش	Convulsion	دورے
Cervix	رحم کی گردن	Cramps	کھچاؤ
Clitoris	بظر	Complication	پہچیدگی
Caesarean	ولادت کیلئے کیا جانے والا بڑا آپریشن	Colostrum	پستان کی ابتدائی رطوبت
☆☆.....(D).....☆☆		Clotting Time	خون جمنے کا وقت
Drug	دواء	Cystitis	مثانہ کی سوزش
Depression	ذہنی دباؤ۔ ذہنی پریشانی	Cervical	رحم کی گردن سے تعلق رکھنے والا
Dysentary	پیش	Cyst	فاسد مادے کی تھیلی
Drymilk	خشک دودھ	Chorionic Villus	کارپس لیوٹم میں تبدیل ہونا
Dysmenorrhoea	حیض کا درد کے ساتھ آنا	Chorion	بیرونی جھلی
Displaced Uterus	رحم کاٹل جانا	Cluster of Cells	خلیات کا مجموعہ
Dehydration	پانی کی کمی ہونا	Constipation	قبض
Diarrhoea	اسہال	Conception	سپرم اور اووم کا ملنا
Dead Born	مردہ نوزائیدہ	Changes	تبدیلیاں
Dystocia	زچگی میں رکاوٹ	Capillaries	عروق شعریہ
Delay	تاخیر	Cycle	دور۔ چکر
Diagnosis	تشخیص	Cavity	جوف

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Embryotomy	فینس کوکاٹ کرنا لانا	Dorsal Position	کمر کے بل
Emergency	ہنگامی طور پر	Descent	جنین کے سر کا نیچے کی جانب حرکت کرنا
Episiotomy	ولادت میں آسانی کیلئے ولوا پر چیر لگانا	Duration	دورانیہ
Enema	حقنہ	Diastolic B.P	ڈایاسٹولک بلڈ پریشر
Eye Brows	آنکھ کی بھنویں	Deficiency	کمی
Estimate	اندازہ	Detect	معلوم کرنا۔ سراغ لگانا
Exercise	ورزش	Diabetes	ذیابیطس۔ شوگر
☆☆.....(F).....☆☆		Dilate	پھیلانا
Fear	خوف	Digestive Juice	ہاضمہ کی رطوبت
False	غیر حقیقی (جھوٹا)	Decidua	ڈیسی ڈوا
Food Substance	خوراک کے اجزاء	Duct	نالی
Fat Soluble	چربی میں حل ہونے والا	Discharge	اخراج۔ بہاؤ
Fetal Circulation	جنین کا دوران خون	Dermal	جلدی
Fat	چربی	☆☆.....(E).....☆☆	
Fertilised Ovum	بار آور بیضہ یا اووم	E.D.D	بچے کی پیدائش کی متوقع تاریخ
Fetal Parts	جنین کے اعضاء	Elasticity	لچک
Fertilization	استقرار حمل۔ حمل کا ٹھہرنا	Endometritis	رحم کی اندرونی جھلی کی سوزش
Follicle	کیس۔ خول	Endometrium	رحم کی اندرونی جھلی
Fluid	مائع۔ سیال	Endocrine	بے نالی غدود
Fallopian Tubes	قاذف نالیاں	Excretion	مادوں کا اخراج
Fundus	بچہ دانی کا اوپری حصہ	Erysipelas	سرخاب۔ زہر باد
Fibers	ریشے	Eyes	آنکھیں

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Glans	عضوتناسل کا اگلا حصہ۔ حشفہ	Function	افعال
Genitals	جنسی اعضاء	Fetus Exit	بچے کے باہر نکلنے کا راستہ
Gynaecology	عورتوں کے جنسی و اعضائے تولید کا علم	Fetus	جنین
☆☆.....(H).....☆☆		Fold	تہہ، چٹ، سلوٹ
Hymen	پردہ بکارت	Family Planning	خاندانی منصوبہ بندی
Hip Joint	کولہے کا جوڑ	Foam	جھاگ
Head	سر	Fistula	دو آرگنز کے درمیان سوراخ بننا
Heatstrock	لوگنا	Flexion	مڑ جانا
Hepatic	جگر سے متعلق	Finding	متابج
Height	قد۔ بلندی	Fore Water	فیش کے سر کے آگے موجود پانی
Hereditary	موروثی	Face	چہرہ
Hysteria	اختناق الرحم	Fetoscope	جنین کے دل کی دھڑکن سننے کا آلہ
Hydrometra	رحم کا استسقاء	☆☆.....(G).....☆☆	
Habitual	عادتا	General	عام۔ عمومی
Hearing	سماعت	Gestation	حمل
Hypotension	بلڈ پریشر کم ہو جانا	Gonorrhoea	سوزاک
Hygiene	حفظان صحت	Glycosuria	ذیابیطس شکرى
Hard	سخت	Growth	پیدائش۔ نشوونما
Hind Water	فیش کے سر کے عقب میں پانی ہونا	Gastritis	معدہ کی سوزش
Health	صحت	Gastralgia	معدے کا درد
Haemophilia	ایسا مرض جس میں خون نہیں جمتا	Glands	غدد
Haemorrhage	جریان خون	Granular	دانے دار

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Incubator	نوزائیدہ کے رکھے جانے والا آلہ
Inspection	معائنہ
Internal	اندرونی
Incidental	اتفاقیت۔ حادثاتی
☆☆.....(J).....☆☆	
Jacquinier's sign	نیلا ہٹ
Jelly	جیلی۔ لیس دار مادہ
Jaundice	یرقان
Joint	جوڑ
☆☆.....(K).....☆☆	
Kiss of Life	منہ سے منہ ملا کر سانس دلانا
Kinds	اقسام
Kidneys	گردے
Kneeling	گھٹنوں کے بل
☆☆.....(L).....☆☆	
Lateral	اطراف کی جانب
Lochia	نفاس۔ زچگی کے بعد اخراج
Leucorrhoea	سیلان الرحم۔ لیکوریا
Lubricate	گیلا۔ ملائم۔ چکنا
Labia Minora	اندام نہانی کے چھوٹے ہونٹ
Labour	ولادت۔ زچگی
Laparotomy	پیٹ کا آپریشن

Hypoxia	آکسیجن کی کمی
Hypovolemia	خون کی مقدار میں کمی
Hypertrophy	خیلات کا تعداد میں زیادہ بڑھنا
Heart Burn	سینے کی جلن
Headache	سر درد
Haemoglobin	خون کا سرخ مادہ
☆☆.....(I).....☆☆	
Implant	جڑا ہوا
Insomnia	بے خوابی
Infection	چھوت
Inflammation	سوزش
Ischium	چوتھ کی ہڈی
Ilium	کولہے کی ہڈی
Innominate Bone	کولہے کی بے نام ہڈی
Inferior	نیچے کی جانب
Intercourse	مباشرت۔ جماع۔ جنسی ملاپ
I.U.C.D	خاندانی منصوبہ بندی کا چھلا
Infant	ایک سال تک کا شیرخوار بچہ
Induration	تختی
Inversion	الٹ جانا
Incision	چیر لگانا۔ شکاف ڈالنا
Incomplete	نامکمل

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Menstrual Flow	حیض کا بہاؤ۔ ماہواری کا اخراج	Large	بڑا۔ لمبا
Menorrhagia	کثرت حیض	Labour Room	ولادت کا کمرہ
Menses	حیض۔ ماہواری	Limbs	ہاتھ۔ پاؤں
Mons Veneris	ولوا کا بالائی ٹکونی حصہ	Length	لمبائی
Midwifery	دایہ گیری۔ دائی جنائی	Linea Nigra	حاملہ کے پیڑو سے ناف تک لکیر
Malaria	ملیریا۔ نوبتی بخار	Lactation	رضاعت
Measles	خسرہ	Liver	جگر
Mammography	پستان کا خاص ایکس رے	Lanugo	جنین کے جسم پر نرم بالوں کی تہ
Mastitis	پستان کی سوزش	Lungs	پھیپھڑے
Metrorrhagia	رحم سے خون گرنا	Liquor	پانی جیسا سیال۔ مائع
Meningitis	دماغی جھلی کی سوزش۔ گردن توڑ بخار	Ligament	سہارا۔ بندھن
Mouth	منہ۔ دہن	Longitudinal Fiber	لمبوترے ریشے
Mole	گوشت کا لوتھڑا	Layer	تہہ۔ پرت
Measures	پیمائش	☆☆.....(M).....☆☆	
Management	انتظام۔ بندوبست	Morula	خلیات کا مجموعہ
Moist	مرطوب	Mucous	بلغم
Method	طریقہ	Morning Sickness	حاملہ کی متلی
Multigravida	کئی دفعہ ماں بننے والی	Menopause	سن یاس
Maternal Trauma	دوران ولادت اعضا کا زخمی ہونا۔	Muscular Coat	عضلاتی تہہ
Movement	حرکت	Myometrium	رحم کی درمیانی تہہ
Meat	گوشت	Menstrual Cycle	ماہواری کا دور
Milk	دودھ	Muscle Fibers	عضلاتی ریشے

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Nephritis	گردوں کی سوزش	Marital Relation	ہم بستری۔ مباشرت
Neonate	ایک ماہ تک کا نوزائیدہ بچہ	Mental Relaxation	ذہنی سکون اور اطمینان
Nipple	پستان کا سرا۔ بھٹی	Multi Pregnancy	ایک سے زیادہ بچوں کا حمل
Nutrition	خوراک۔ غذا	Maternal Weight	حاملہ کا وزن
Nerves	اعصاب	Myocardial	عضلات قلب
☆☆.....(O).....☆☆		Moderate	درمیانی۔ معتدل
Ointment	مرہم	Mild	نرم و ملائم
Oral	منہ کے راستے کھانے والی	Minor	معمولی
Oophritis	بیضۃ الرحم کی سوزش	Metabolism	میٹابولزم
Offensive	بدبودار۔ متعفن	Migrain	درد شقیقہ
Occipital	سر کی پشت	Mature	پختہ
Orifice	سوراخ	Minerals	معدنی نمکیات
Onset	آغاز	Meconium	بچے کا پہلا پاخانہ
Oligouria	پیشاب کا کم آنا	☆☆.....(N).....☆☆	
Observe	مشاہدہ	Natural	قدرتی
Obesity	موٹاپا	Nymphomania	خواہش نفسانی کی زیادتی
Oedema	استسقا۔ پانی پڑنا	Neuralgia	اعصابی درد
Odour	بو	Normal	قدرتی۔ معمول کے مطابق
Ovulation	انڈے (اووم) کا اخراج	Neurological	اعصابی
Ovarian Artery	بیضۃ الرحم کی شریان	Narcotics	نشہ آور اشیاء
Os Uteri	رحم کا منہ	Necrosis	نشوز کی مقامی موت
Obstetrics	بچہ جنائی کا علم (دائی جنائی)	Nausea	متلی

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

☆ ☆ (P) ☆ ☆	
Perineum	سیون
Puberty	بلوغت
Peristaltic	آنتوں کی حرکت
Pelvic Glands	پیڑو کے غدود
Peritonium	پیٹ کی جھلی
Perimetrium	رحم کی بیرونی تہہ
Posterior	عقبی جانب
Position	حالت
Placenta	آنول۔ مشیمہ
Penis	عضو تناسل۔ ذکر۔ قضیب
Palpation	ٹٹولنا
Powder	سٹوف
Poisoning	زہر خورانی
Piles	بواسیر
Pneumonia	پھیپھڑوں کی سوزش
Puerperium	چھلڑا
Puerperal Mania	زچہ کی دیوانگی
Polymenorrhoea	حیض کا وقت از وقت آنا
Primary	ابتدائی۔ آغاز میں
Pruritus	شدید خارش
Puerperal Fever	زچہ کا بخار۔ پرسوتی بخار
Puerpera	زچہ کے متعلق
Premature Labour	قبل از وقت پیدائش
Poly Hydramnios	امنیاتک فلوئیڈ کی زیادتی
Presenatation	جنین کی پوزیشن یا حالت
Period	دورانیہ
Preparation	تیاری
Protein	لحمیات
Post Obsteric Hx	سابقہ ولادت کے حالات
Pica	عجیب و غریب اشیاء کی خواہش
Ptylisim	تھوک کی زیادتی
Plug	ڈاٹ
Pyometra	رحم میں پیپ پڑنا
Pubic Bone	پیڑو کی ہڈی
Pelvis	پیڑو کا حلقہ
Protection	تحفظ
Pulsation	نبض
Pregnancy	حمل
Psychological	نفسیاتی
Physical	طبعی
Prostate Gland	عدہ مذی
Prepuce	عضو تناسل کا گھونگھٹ

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Rheumatic Fever	گٹھیاوی بخار	Prolonged	طویل
Retained	رکا ہوا	Prevention	حفاظت۔ تدارک
Repair	مرمت	Pain	درو
Round	گول	Push	آگے دھکیلنا
Rotation	فوری گردش۔ چکر	Primigravida	پہلی دفعہ ماں بننے والی عورت
Rigid	سخت	Palpitation	دل کی دھڑکن
Ring	دائرہ	Pallor Face	زرد چہرہ
Rupture	پھٹ جانا	Prolapse	سرک جانا۔ پھسل جانا
Rest	آرام	☆☆.....(Q).....☆☆	
Renal Failure	گردوں کا فیل ہونا	Quadrant	ایک چوتھائی
Renal Colic	گردے کا درد	Quadriceps	ران کے ایک پٹھے کا نام
Respiration	عمل تنفس	Quadruples	ایک وقت میں چار بچوں کی پیدائش
☆☆.....(S).....☆☆		Quarantine	مریض کو دوسروں سے علیحدہ رکھنا
Syphilis	آتشک	Quickening	پیش میں فیٹس کی حرکات محسوس کرنا
Severe Bleeding	شدید جریان خون	Quinine	کوئین (ملیریا کے علاج کی دوا)
Serious	سنجیدہ	☆☆.....(R).....☆☆	
Sadness	اداسی۔ غمگینی	Red Blood Cells	خون کے سرخ جیسے
Sacrum	پیڑو کے عقب میں تکیونی ہڈی	Rectum	امعاء مستقیم
Stomach	معدہ	Regeneration	نئے سرے سے پیدائش
Stream	بہاؤ۔ دھار	Reproduction	دوبارہ پیدا ہونا
Skin	جلد	Royal's Tube	خوراک دینے کی نالی
Sex	جنس	Red Fever	سرخ بخار

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Stool	پاخانہ	Signs	نشانیوں
Surface	سطح	Scrotum	خصیوں کی تھیلیاں
Stillborn	خاموش نوزائیدہ	Spermatozoa	تولیدی خلیات
Symptoms	علامات	Superior	اوپر کی جانب
Septic	متعفن۔ جراثیموں سے متاثرہ	Sperm	تخم منی
Sepration	علیحدگی	Semen	منی
Support Sitting	نیم دراز حالت	Secretion	رطوبت
Soundless	خاموش۔ آواز کے بغیر	Structure	ساخت
Sound	آواز	Sexual	جنسی
Swelling	سوجن	Salpingitis	قائذ نالیوں کی سوزش
Stiffness	اکڑاؤ	Subcutaneous	زیر جلد
Spine	ریڑھ	Sublingual	زبان کے نیچے
Soft	نرم	Stroke	دماغی رگ کا پھٹ جانا
Stage	مرحلہ	Sterlized	جراثیموں سے پاک
Show	قبل زچگی خون آلود مواد کا اخراج	Spermicide	سپرم ہلاک کرنے والی
Segment	ٹکڑا	Sterilization	جراثیم کشی
Systolic B.P	سسٹولک بلڈ پریشر	Salts	نمکیات
Shoulder	کندھا	Soreness	دکھن۔ پک جانا
Stethoscope	سٹیٹھو سکوپ	Sterility	بانجھ پن
Shape	شکل و صورت۔ ساخت۔ بناوٹ	Secondary	ثانوی
Sugar	شکر	Solid	سخت
Starch	نشاستہ	Spasms	تشنج۔ کھچاؤ

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Talipes Valgus	پاؤں پھیرا (باہر کے رخ)	Sleep	نیند
Talipes Varus	پاؤں پھیرا (اندروں کے رخ)	Suitable	مناسب
Talipomanus	ہاتھ کا ٹیڑھا پن	Sun Shine	سورج کی روشنی۔ دھوپ
Talus	ٹخنے کی ہڈی کا نام	☆☆.....(T).....☆☆	
Torsus	سات ہڈیاں	Typhoid	تپ محرقہ
Taste	ذائقہ۔ چکھنا	Threat Abortion	مکملہ ابارشن
Teat (Nipple)	تھن۔ پستان۔ نیل	Tear	چیر آنا
Temperature	درجہ حرارت	Taste	ذائقہ
Temple	کنپنی	Tachycardia	دل کی رفتار کا بڑھا ہونا
Temple Bone	کنپنی کی ہڈی	Thigh	ران
Tendon	گوشت اور ہڈی کے جوڑ والے مضبوط ریشہ	Tightly	مضبوطی سے
Tent	کپڑے کی پٹی	Trauma	ضرر۔ نقصان
Tension	تناؤ۔ شدت۔ جوش	Thalassaemia	خون میں ہیموگلوبن کی خرابی کا مرض
Tentigo	مستی۔ شہوت۔ ہوس	Trunk	دھڑ
Tepid	نیم گرم	Transverse	ترچھا۔ آڑھے رخ
Teras	نامکمل بچہ	Travel	سفر
Teratosis	اعضاء کی پیدائشی بد صورتی	Tuberculosis	تپ دق
Term	دورانیہ	Toxaemia	زہریلا پن
Termination	خاتمہ	Tobacosis	تباہ کو کا زہر
Terms	ماہواری	Tabefication	لاغری
Tertiary	بالترتیب تیسرا	Tablet	گولی دوا کی
Tertipara	وہ عورت جو تیسری بار حاملہ ہوئی ہو	Talipes	پاؤں کا ٹیڑھا پن

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Toco	بچے کی پیدائش	Testicle	مرد کا خضیہ
Tocography	یوٹرس کا تناؤ ناپنا	Testes	مرد کے خضیے
Toe	پاؤں کا انگوٹھا	Tetanus	جھٹکوں کی بیماری
Tongue	زبان	Thalassaemia	خون کی شدید کمی۔ تھیلا سیما
Tonsillitis	گلے پرٹنا۔ ورم لوزتان	Thelalgia	سرپستان کا درد
Toothache	دانت کا درد	Thelitis	ورم بھنی
Topical	مقامی۔ اوپر۔ بیرونی طرف	Theomania	عبادت کرتے رہنے کا جنون
Tormina	استریوں کا تشخ	Therapeutics	علم العلاج۔ دافع مرض
Toucher	انگلیوں سے بچے دانی کا معائنہ کرنا	Theriacal	تریاق۔ سانپ کے کاٹے کی دواء
Tourniquet	ٹورنی کیٹ	Thermometer	تھرمامیٹر
Toxicology	زہروں کا بیان	Thermo Therapy	علاج بذریعہ حرارت
Tracheitis	ہوا کی نالی کا ورم	Third Stage	تیسرا مرحلہ
Tracheocle	گلہڑ	Thorax	سینہ۔ چھاتی کا اندرونی خلا۔ پنجر
Trachoma	مکڑے	Throat	گلا
Tract	جسم کا کوئی حصہ یا دائرہ۔ راستہ	Throbbing	تپکن
Transvaginal	ویجائنہ میں سے گزارنا	Thrombus	خون کا لوتھڑا
Transvers Lie	آڑا رخ	Thrush (Aphthae)	منہ کے چھالے
Trapezium	کلائی کی ایک ہڈی	Thumb	ہاتھ کا انگوٹھا
Trauma	ٹراما۔ چوٹ۔ ضرر	Thyroid Gland	تھائی رائیڈ غدود
Traumatic	جراحت۔ چوٹ	Thyroid Shield	ڈھال جیسا تھائی رائیڈ
Traumatology	زخموں کے متعلق علم	Thyroiditis	تھائی رائیڈ غدود کی سوزش
Tremor	لرزہ۔ تھرتھراہٹ	Toast	آگ پر سینکنا

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Umbilical Region	حلقہ ناف	Tremulous	تھر تھرا ہٹا ہوا ڈرپوک
Umbilicus	ناف	Tri	بمعنی تین
Uniparous	ایک حمل سے ایک ہی بچہ پیدا ہونا	Tribadism	عورتوں کی باہمی طور پر غیر قدرتی مباشرت
Uniovalar	ایک اووم میں سے	Trichitis	بالوں کی جڑوں کی سوزش
Unstable Lie	پوزیشن تبدیل ہوتے رہنا	Trichosis	بالوں کی جڑوں کا مرض
Unsupported	کوئی سہارا نہ ہونا	Trimester	تین ماہ کا عرصہ
Uracratia	گردوں کے فعل کا بگڑ جانا	Triplets	ایک وقت میں یوٹرس میں تین بچے
Uraemia	خون میں یوریا کی زیادتی	Tunica	پروہ جھلی
Sexual Prevent	جنسی عمل کی روک تھام	Turbinated Bone	ناک کی ہڈی
Urea	پیشاب	Tussis (Cough)	کھانسی
Uresis	پیشاب کرنا	Twins	جڑواں بچے
Ureter	پیشاب کی نالی	Tympanic	ڈھول جیسا
Ureterovaginal	یوٹرس اور وجمجانہ سے متعلقہ	Typanities	اُچھارہ
Urethra	مٹانہ سے پیشاب باہر نکالنے والی نالی	Typhina	بار بار آنے والا بخار
Urethritis	یوریتھرا کی سوزش	Typhoid Fever	ٹائی فائیڈ بخار
Urethic (Diuretic)	پیشاب آور	Typhus Fever	ٹائی فس بخار
Urinalysis	پیشاب کا معائنہ	☆☆.....(U).....☆☆	
Urine	پیشاب	Uacactia	انجانے میں پیشاب نکلنا
Uriasis	پیشابی پتھری کا بننا	Ulcer	جلد یا اندرونی جھلیوں کا سطحی زخم
Urinology	پیشاب کا سائنٹیفک مطالعہ	Ulitis	مسوڑھوں کی سوزش
Uroclepsia	انجانے میں پیشاب ہو جانا	Ulna	کلائی کے اوپر والی بڑی ہڈی
Urolith	مٹانے کی پتھری	Ultrasonography	معائنہ بذریعہ الٹراساؤنڈ

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

Venereal	جنسی	Uterine	یوٹرس کے متعلق۔ رحم کے متعلق
Venisection	ورید کو چیرا دے کر برنولہ پاس کرنا	Uteritis (Metritis)	سوزش رحم
Variety	اقسام	Uterine Fibroids	بچے دانی کی رسولیاں
Ventral	پچھلی جانب	Uterotomy	یوٹرس میں نشتر لگانا
Vent	پیٹ کا	Uterovesical	یوٹرس اور مثانہ کے متعلق
Vermis (Worm)	کرم۔ کیڑا	Uterus (Womb)	رحم۔ بچہ دانی۔ یوٹرس
Vertigo	سر چکرانا۔ کمر درد	☆☆.....(V).....☆☆	
Vertex (Top Head)	چوٹی	Vaccine	ویکسین
Vesania	ذہنی نقص	Vaccination	حفاظتی ٹیکہ جات
Vesica	مثانہ	Vacuum Aspiration	پہلے تین ماہ حمل گرانے کا طریقہ
Vesicant	آبلے ڈالنے والی چیز	Vagina	فرج۔ زنانہ عضو تناسل
Vestibule	فرج کا بیرونی حصہ	Vaginismus	ویجائنیکل پھٹوں کا سپازم
Vela	رگ، نالی	Vaginitis	سوزش فرج
Vinegar	سرکہ	Vagitus	فرج کا۔ فرج سے متعلق
Vinum Wine	شراب	Varicose	پھولی ہوئی ورید
Violation (Rape)	عصمت دری۔ زنا بالجبر	Varices	پھیلی ہوئی وریدیں
Virgin	دوشیزہ۔ کنواری	Variciform	نوزائیدہ بچے کا روٹا
Virile	مردانی۔ مقوی باہ۔ قوت باہ	Vasdefrens	نھسے کی منی خارج ہونیوالی نالی
Virilia	قضیب ذکر	Vascular System	نظام دوران خون
Virus	وائرس۔ جراثیم کی ایک قسم	Vasospasm	وریدوں کا تشنج
Viscid	گاڑھا۔ لیپ دار	Vein	ورید
Vivisection	زندہ جاندار کی چیر پھاڑ	Venacava	شہرگ

(GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY) گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی

☆☆.....(X).....☆☆		Vocal	انسانی آواز کا
X-Chromosome	جنسی کروموسوم	Volatile	بھاپ پن کراڑنے والا
Xenophobia	مرض سے نفرت	Volume	حجم
Xerostomia	منہ کی خشکی	Vomiting	قے۔ الٹی
Xerosis (Dryness)	خشکی	Vomitus	قے میں نکلا ہوا مواد
Xiphoid	سٹرغم ہڈی کا نچلا نوکدار حصہ	Vomiturius	قے آور
Xylocaepus	بدبو	Vulva	بیرونی زمانہ جنسی اعضاء
☆☆.....(Y).....☆☆		Vulvar	دلو اسے متعلق
Yard (Penis)	قصبہ۔ ذکر	Vulvitis	فرج کی سوزش
Yawning	جمائی لینا	☆☆.....(W).....☆☆	
Y-Chromosome	جنسی کروموسوم	Wart	منہ
Yeast (Ferment)	خمیر	Wean	پستان چھڑانا۔ دودھ چھڑانا
Yellow	زرد۔ پیلا	Weight Gain	وزن کا بڑھنا
☆☆.....(Z).....☆☆		Wet Nurse	کسی بچے کو دودھ پلانیوالی نرس
Zeotic	حیات سے متعلق	Wheal	اُبھرا نشان جو چھڑی سے آئے
Zoo Agglutinin	سانپ کا زہر	Wheezing	سینے سے آوازیں آنا
Zoo (Animal)	جانور	Whitlow	ناخن کی جڑ میں پیپ پڑ جانا
Zoo Latina	جانوروں کی جانب جنسی کشش	Whooping Cough	کالی کھانسی
Zoology	علم حیوانات	Womb (Uterus)	یوٹرس۔ بچہ دانی۔ رحم
Zoomania	جانوروں سے محبت کرنے کا جنون	Worms	کیڑے
Zoonosis	جانوروں کی بیماری	Wound	گھاؤ۔ زخم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆		Wrist	کلائی



DR. MUHAMMAD USMAN - GOLD MEDALIST

OTHER BOOKS BY THE AUTHOR

ANATOMY for Paramedics	PHYSIOLOGY for Paramedics	BIOCHEMISTRY for Paramedics	COMPUTER SCIENCE for Paramedics
PATHOLOGY for Paramedics	PHARMACOLOGY for Paramedics	FIRST AID for Paramedics	PUBLIC HEALTH for Paramedics
DISEASES for Paramedics	GYNAECOLOGY for L.H.Vs	LABORATORY TESTS for Paramedics	CLASS NOTES 1 st & 2 nd SEMESTER for Paramedics
ULTRASOUND for Paramedics	DENTAL TECHNOLOGY for Paramedics		MEDICAL ETHICS for Paramedics
USMANIA CLINICAL PRACTICE OF MEDICINE ایلوپیتھک پریکٹس آف میڈیسن		TERMINOLOGY & CLINICAL EXAMINATION for Paramedics	

درج بالا کتب اردو ترجمے کے ساتھ دستیاب ہیں

پشاور ڈسٹری بیوٹرز

ناصر بک ایجنسی: ڈھکی نعلبندی، قصہ خوانی بازار، پشاور شہر

فون: 091-2572277 / 0302-8884377 / 0307-8317755



Usmania Publications
1385-Krishanpura Near Bilal Town,
G.T. Road, Peshawar. Ph: 091-2262443

عثمانیہ پبلی کیشنز